

伤寒兼证析义

张倬

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
伤寒兼证析义	5

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望可以帮助有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

伤寒兼证析义

长洲张倬飞畴着

中风兼伤寒论

晨窗雪霁，光射四壁，张子被褐方起，诵雪峤熟者春风劈烂椽之句，客有量屐过我而进苦雪篇者，中有冻馁相继倒一语，恍然久之，因呼从事炉头相与平章风雅，杯单内，论及医道之难，而伤寒为最难，伤寒而挟杂病者尤难，是以亘古绝无兼该之例，后世不能兼善其术也，余曰：安有滔滔江汉，不通潮汐者乎，苟能纯一其道，则圆机在我，活法随人，何处兼症之不克哉，客举手称善，请析中风兼伤寒义始。

问：中经络兼伤寒。

曰：伤寒邪从外入中风风从内召，虽同具汗下和解之法，而虚实之机，微有不同伤寒悉从外邪起见，故必分营卫经络，一毫可混淆，中风外内合邪，故攻表必兼养正，如小续命中芎归参附之类，即兼伤寒者，亦当顾虑正气为主，若率意攻表，则营热转甚，在里之津液，势必随表药外泄，而为燥痒枯竭之症矣。

问：中血脉。

曰：中血脉，即伤寒之半表半里症，伤寒邪未深入，但须和解，中风阴血先亏，故必养血兼除风热，所谓血行风自灭是也，在兼伤寒者，和解药中，稍加调血之味，以滋血燥，不得任用滋阴凉血之药。

问：中府兼伤寒。

曰：中府多见闭症，与伤寒之里实胀闭不殊，伤寒邪热入府，灼烁阴津，故用承气以泄其热，不得杂一味表药，恐引热势上蒸也，中风是里热生风，木邪弃土，故攻里必兼祛风热，如三化汤中用羌活之义，闭症而见痰鸣喘胀，面赤口张，为正气暴卒此必不治。

问：中藏兼伤寒。

曰：中藏多见脱症，与直中阴经之自利无异，古法用三生阴治脾肺之中，地黄饮子肾肝之中，侯氏黑散治心与包络之中，然用以治藏虚受邪之症，诚为圣药，若卒中昏迷，手撒遗尿真阴失守之脱症，虽有合剂，不能复起况兼伤于寒者乎。

问：类中兼伤寒。

曰：类中大纲有三，曰气衰，曰火暴，曰痰逆，总皆阳虚邪害空窍所致，河间之地黄饮子，为下虚上盛，阴火暴逆而设，东垣之三生饮，为脾肺气衰，痰积于中而设，丹溪之星香二陈，为形盛气阻，痰盛于外而设，在兼伤寒者，三法俱不可效惟和营卫中，随症加养气导火豁痰之药，斯为兼得之法。

问：中风本有六经形证，与兼感客邪何异。

曰：中风六经形证，是指口眼喎斜肢体麻瞽等症而言，与伤寒六经见症不同，然亦间有恶寒发热之候，但中风虽有恶寒，必常时凛凛，或经日不止，不似外感之骤然恶寒发热如燔也，中风虽有火炎痰湿头痛，必时甚时减或昼甚，或夜甚，不似外感之顿然发热大痛，昼夜不分也，中风虽有肢体烦疼，必麻痹不仁，或久卧床褥所致，不似外感之忽然壮热无汗，骨节烦疼也，中风虽有表虚自汗必时濺濺，不似外感之暮然发热，头痛自汗也，中风虽有往来寒热，必常常若此，不似外感之发热头痛三四日，而转入少阳也，中风虽有大便秘结，必平昔至图艰难，不似外感之大热数日，热邪入里而燥结不通也，中风虽有小水短濇，必向来不利，或见频数，不似外感之热结膀胱，烦渴引饮，小腹胀满也，以此审辨，则中风之本症兼症，可了然心目矣。

问：有年少体肥之人，平素左半身无汗，胁下一片常冷，数日前索逋下乡，是日天气暴寒，舟中食饭一箸，随食随冷，便觉凛凛畏寒，登崖失足颠仆，扶挟解带而寝，是夜即发热头痛，喘鸣胸满，遍体烦疼，腰脊左肋尤甚，左半身不能转动，仍冷不热，手足亦微冷，第三日扶病而归，其脉左手弦细，右手迟滑，绝不似外感之候，因见脉弦肋痛，与小柴胡二服不应，又似半肢风废，与小续命亦不应，检方书中半身无汗例，当二陈四物合用，按法治之亦无效，今舌上微有薄胎，而左畔白滑，右畔微黄，得病后大便已去二次，去亦无多，小便略见黄濇究竟此属何症，当与何药。

曰：此人素有寒饮结紧肋下，更兼内外感寒，加以惊仆痰逆，则发热喘鸣头痛，胸满身疼，势所必至，其右半经脉贯通处受邪，则从阳而化为热，左半寒饮积结之界，半时尚且无汗，纵有寒邪凑泊，亦必从阴而酿寒，阳气不到之所，自然重着难移，阳气不行于脉，自然弦细搏指，至于右脉迟滑，手足微寒，皆缘脾气向衰，热势不盛，所以舌胎不能干燥，大便不能结鞭，其小便黄濇一证，虽因肺胃气化不行，亦见下焦真阳未艾，斯人向后必夭，目今尚可挽回，当与五积散昼夜三进，总藉辛温解散之力，可以内消寒滞，中温血脉，外逐表邪，一举而有三得，其外可用白芥子川乌姜滓，炙热包熨之，候表邪分解，里气调和，然后用六君子加辛附姜桂之属，徐温中气可也。

虚劳兼伤寒论

问：虚劳之人，兼感风寒者，何以辨之。

曰：必先明受病之三纲，见症之五常，然后参详脉症，以辨客邪，三纲者，房劳伤，思郁伤，药物伤，五常者，骨蒸，欬嗽，吐血，泄泻，男子失精，女不月，此皆本病之常，他症虽多，莫如此五者为甚，如平时骨蒸劳热，时重时轻，火炎则面热颊赤，两角隐隐掣痛，忽然壮热头疼不分昼夜，是感客邪也，平时欬嗽声怯，痰涎不应，忽然鼻塞声重，涕唾稠粘，是感客邪也，平时关尺脉弦，忽然大迎浮盛，是感客邪也，医不达此，每认本病变重，日与调补助邪，深入伤残之余，立刻告竭，究竟不知其为风寒，而反归咎于饮食居处，不亦冤乎。

问：房劳伤者，先见何症，兼客邪者，当用何药。

曰：房劳伤者，作强太过，而伤其先天也，世俗谓之阴虚，而实兼伤阴中阳气，故曰先天，若云肾本受伤致病，则有质之精，依然后天水谷所化，安得谓之先天乎，惟素稟虚寒，阳气不振，恣饵金石，热毒入于肾藏，伤耗真阴者，乃为阴虚，其症皆从下而上，由肾肝而至于脾，或先失血，或见遗精，次见欬嗽骨蒸等症，真阳亏者，乏气少食，后见泄泻而危，真阴亏者，强中热中，必发痲肿毙，故治本病之阴虚，八味肾气异功保元等药，兼外感者，黄芪建中，本病之阴虚，六味都气补阴虎潜之类，有药毒者，滋肾丸洗涤之，兼客邪者，小建中加丹皮，先吐血者为营血受伤，黄芪建中加当归，先遗精者，为封藏不固，桂枝加龙骨牡蛎汤，虽有外邪，无逾上法，但须参邪之盛衰，从少从多，以为活法可也。

问：思郁所伤，较斲丧所致者，孰重孰轻，证治与房劳何异。

曰：斲丧是精气受伤，可用填补之剂，思郁是神气受困，七情之火交煎，真阴不久告匮，岂药石之所能疗哉，惟早适其志为第一义，此病起于肾，关乎心，而迫肺伤肝及脾，再交水火，谓之七传，初起骨蒸干欬，继则亡血失精，女子不月，至死而面色不衰，以其阴火蒸腾津液于上，所以肢体日削，神采愈鲜，不似房劳之精气先伤，而形神枯索也，在初起真阴未耗时，急宜调治，如地黄丸逍遥散归脾汤之类，若经闭不行，而气体尚强，可用玉烛散疏涤其热，次以金匱下瘀血汤作丸，归脾汤下之，倒经血溢于上者亦然，男子失血遗精，都气丸加鳔胶，与四乌鲂骨一藟茹丸间服，有外感者，通宜小建加大剂牡丹皮，服后热不除，合当归补血汤自止，若误与羌防升柴等药，多致昏热痞闷，变生不测，慎之慎之。

问：医药伤者，伤在何经，治用何药，更加伤寒，尚可一回否。

曰：此皆表邪发散不清，病留肺络而欬嗽缠绵，医者不察，认阴虚肺热，而与寒凉清肺，除火滋阴，其邪从皮毛入肺而及心胃，为从上而下，亦有因寒凉伤胃，胃输寒气于肺，咸必先嗽而后寒热也，复有风热认作风寒，误投辛散而伤少阴之经者，

必先欬唾脓血，而后泄利，又有汗下太过，失于调养而成，此则营卫受伤，必先微寒数热而后欬嗽，凡此皆能致虚，若于本门求治，百不一效，惟用伤寒搜涤之法，庶或可图，但得形气未衰，脉症相符，纵加客症，亦有成法，如邪留肺络而喘欬不休，脉见浮紧浮数者，大小青龙射干麻黄选用，喘欬有血者，和剂欬冬花散之类服二三剂，而见鼻塞声重，有似伤风之状者，此邪从上泄也，即当以保元异功少加细辛，调理中气，兼六味丸加桂枝滋其下元，若服二三剂不应反加喘咳脉疾，或腹痛声哑者难已，如寒凉伤胃而欬，畏寒少食，气口脉见紧细沈弦，大剂桂枝人参汤，服四五剂而见下血，或有积沫，小复微痛，喜得温按者，邪从下泄也，小剂理中汤和之，七日不止者难治，风热误用辛温者，麻黄升麻汤，萎蕤汤，消风散，随轻重而施，已上等法，皆是因风寒久伏，故与兼客邪者同治，惟汗下太过者，当助正气，如十全大补大建中人参养营酌用，倘邪弃虚入而见表症，新加汤，桂枝加附子汤，柴胡桂枝汤，凉寒热施治可也。

问：虚劳之因不同，而所见之症则一，其故何也。

曰：致病之因虽异，其所受病者，不过阴阳血气而已，故凡治疗，必察阴阳，如骨蒸劳热之晡夜善易饥者，阴虚也，昼日烦热，至夜稍安者，阳虚也，欬嗽咽干，欬甚略有粘痰者，阴虚也，嗽多清痰，嗽甚则呕水者，阳虚也，吐血紫赤，浓厚光泽，或有结块星缕者，阴虚也，血色晦淡无光，吐久不凝，或虽有瘀结，多带痰水者，阳虚也，泄泻臭秽，身烦热渴，或兼脓血者，阴虚也，泻下纯清水，或白沫者，阳虚也，失精梦寐不宁，二便引急，阴虚也，阴头寒而精出不知，或溺后常有滑精者，阳虚也，经闭发热，欬嗽五心烦热者，阴虚也，少腹引痛，而背微恶寒者，阴气有余，循经而弃阳位，必有干血，若经虽不行，但少食倦怠，腰腹不痛者，阳虚也，阳虚则气衰不能生血，经虽不通必无结血，此病机之最要者，勿以其繁而忽诸，大都阴虚则热，阳虚则寒，阴阳俱虚，则寒热之症错乱而见，又当审其偏胜而为处方，设不知此，日以不寒不热之剂投之，则偏者愈偏，胜者愈胜，永无均适之期矣，故智者临病，务在调其所偏，察其所变，诊察之际，其脉忽然鼓大，症异平时，便当推原饮食起居，以辨客邪有无之应，又有忽然恶寒发热，脉无常候，乃阴阳倚伏，亢极反害之大虚症，岂可一认风寒，而与开泄，不旋踵而告变矣，历观此症，但阳虚可服参芪者，十全五六，阴虚不服参芪者，十难救一，若年在三旬以外者，其人质干已固，尚可斡旋，如在二十上下，非特筋骨柔脆，抑且情形难制，纵极力图治，终难克效。

中满肿胀兼伤寒论

问：胀满兼伤寒当与何药。

曰：先察其脉之属寒属热详其邪之在表在里方可议药。

问：胀诸腹大，皆属于热，恐无属寒之理。

曰：曷观坛中之水，冰则胀，胀甚则裂，岂非寒极胀闭之一验乎。

问：胀满之寒热，何以为辨。

曰：诸病水液，澄澈清冷，皆属于寒，水液浑浊，皆属于热，然亦有本寒标热，而大便不实，小便赤濇者，大抵中满当辨痰饮食积，水肿当辨阴水阳水，鼓胀当辨气血虫积，此为大纲。

问：肿胀之表症，寒者何治，热者何治。

曰：中满肿胀之人，痰湿素盛，中气先伤，更加伤寒，未有不先犯胸膈，而为烦扰不宁，喘胀呕逆之患，外症虽有头疼发热人迎未必繁盛然往往有气口反大于人迎者，倘医者不加辨察，只认本病变重，而与清热利水，恣邪深入，辗转误药，不死不已，邪在表时，切不可动其痼疾，亦不可恣用表药，惟当和其营卫为主，如寒胀用桂枝加附子汤五积散，热胀用桂枝加厚朴杏仁汤芎苏散之类，本寒燥热者，膀胱津气大亏，切不可用利水药，惟茯苓桂枝白朮甘草汤加葱白最当，若溺闭小腹鞭满者，和用春泽汤，以五苓开结导水，四君滋其化源此泻中寓补之义也。

问：见半表里症何治。

曰：此病本在里，邪复向里，如大小柴胡之类皆无妨碍。

问：见里症何治。

曰：宿病虽有虚实寒热之不同，若更加外邪弃机内入，虽正气本虚，亦当微导以泄其热，或通幽门，或疏水道，随其攸利，若以其虚而禁攻，则邪气流连，漫无期矣，至于真元虚惫者，神丹亦不可复起也。

问：中满水肿鼓胀兼伤寒者，治各有异否。

曰：三者皆属里症，咸禁升发，而中满者，汗剂中宜加痰气之药，则不致于逆满，水肿则可用开鬼门之法，惟极虚阴水，与阴本阳标者戒汗，若鼓胀则大忌发汗，当理中兼调营卫，多有浹然汗出而解者，若用表剂，则热转剧，胀反甚，必无得汗之理，至其传里，当各随本病之气血痰水，兼以养正药治之，慎勿以其虚而骤进壅补，亦不可因胀而擅用峻攻，此治虚中实邪之大法也。

噎膈反胃兼伤寒论

问：噎膈反胃，异名同类，倘复为客邪所伤，其治亦彷彿否。

曰：噎者，食即带痰而出，有时屈曲而下，膈者，膈塞闭绝，上下不通，反胃者，饮食如常，后必倾囊而出，三症虽各有辨，而致病之由，总不离乎鬱结，故其治亦不甚相远，洁古以上焦吐者从乎气，言食则暴吐，心下嘈杂皆痰饮鬱火所致，中焦吐者从乎积，每吐则膈间隐隐刺痛，必有死血，好饮热酒人，每多犯此若默默如痴者为虫积，灵枢所谓虫为下膈是也，下焦吐者从乎寒，食久不消经日必吐，乃火衰不能生土，土不制水之候，王太仆云：食不得水，是有火也，食入反出，是无火也，观噎膈反胃症虽不一，其可治不可治，可一言而知，在老人中气久衰，血液枯槁更加鬱结而成真膈者，即不兼伤寒，百不一疗，惟血气未衰之人，因痰饮死血搏结为患者，纵加表症，尚可图治，其症虽发热头痛，而足必冷，伤于寒则鼻燥身疼，而脉微紧，中于风，则鼻鸣干呕，而脉微数以中气久衰，不能鼓搏其脉，热势亦不能盛，与鼓胀之中蕴湿热者不同，是以辨治尤难，治此者虽当散邪为急，然必先安中气，如甘草干姜汤，加桂枝姜枣之类，切不可杂一味耗气破血攻伐宿病之药，若胃虚而逆，大半夏汤，藿香安胃散，皆以人参助胃气，行药力也胃中痰湿上逆，肠鸣膈痞者，半夏泻心汤，以干姜黄连和其寒热，则不致于扞格也，反胃呕吐而渴，欲饮水者，茯苓泽泻汤以泽泻引桂枝干姜之辛入膀胱，行布水精于五经也，若肾虚水逆而呕，金匮肾气丸，减半地黄倍用桂枝，兼散邪以收摄之，热吐酸水哕逆，橘皮竹茹汤下佐金丸，如见里症，不妨用下夺之法，使气下而不上正与本病相合，如半夏生姜大黄汤，人参利膈丸，皆可应用，但胃中寒冷者又为切戒，故仲景有客热不能消谷，胃中寒冷则吐之论，当效理中加枳实加附子等法治之。

内伤兼伤寒论

问：劳力感寒与伤寒症治何异。

曰：劳力是内伤其气，气伤者补之，伤寒是外伤其形，形伤者泻之，此形气俱伤，内虚外实有攻补两难之势，复有兼停宿食者，尤为扼腕，设医者素无成见于胸中，必致发汗以伤其表，则外热转盛，消克以伤其里，则痞胀益甚，辗转戕伐计无所施惟有极力攻下而已深可慨也，夫内伤一症，因劳动太过，阳气亢极而化为火，火气内盛阴气先亏，阳愈盛而愈衰，乃致清气不升浊气不降，阴阳交错，谷气少进，胸中之扬，既不能内守势，必上逆外扰而为身热头痛，有似乎伤寒之症，而实非外感之邪，内经所谓阴虚生内热，阳盛则外热是也，后世惟东垣深得其旨，因立补中益气汤，以升举清阳，补益中气，则浊阴不降而降矣，此方虽专为内伤脾胃而设，然邪弃虚入，非兼神则必不解，即于此汤稍加表药，热服取汗最捷，兼停宿食者，桂枝人参汤，若伤寒轻而内伤轻，黄芪建中汤，至若始为热中，当确遵东垣补中益气之法，未传寒中，则又不能出仲景理中汤之范围也。

问：仲景形作伤寒，其脉不强紧而弱，弱者发渴，夫脉弱则无热邪，何故发渴，又

何以知其为伤寒。

曰：伤寒一科，原以症为主，脉参之，此因劳形作力而感寒发热，故以形作伤寒目之，今世所谓劳力感寒者是也，夫伤寒之脉，法当弦紧，今因劳力伤其津气，气伤不能鼓运其脉，所以反弱，津耗不能上蒸于咽，所以作渴，虽非热邪灼烁使然，而津液受伤则一也，按切脉之道，古人原合望闻问：三法而言，今之病家不达此理，深居帟幄，惟以切脉试医，医者又耻于详问：，每多忽略，设遇此症此脉，得无有误治之失乎，况人所禀之脉，与面目性情不殊，有偏大偏小，纯阴纯阳，反关四出，种种异状，皆生成本脉，岂可悉归之于病侯耶，客曰：向谓医道之难莫，甚于脉，今闻是言，则知诊法又不在七表八里，而在活法推详，几几乎难言之矣，余曰：医无难，察脉难，辨症难，用方难，夫察脉虽难，于活法而实无外乎规矩，不过原其人之清浊贵贱，形志苦乐，与脉候之符与不符，便可推测病情之逆顺，譬诸塾师讲学，得其旨者，自然不远于理，用方如儒者作文，人于其旨，能有几人合局，辨症如释氏参禅，未悟已前，举止障碍，既彻已后，触处灵通，信手拈来，头头是道，然后方可自信而为人司命也。

宿食兼伤寒论

问：伤寒何以见有宿食。

曰：伤寒而见胸前大热，额颅胀，胸腹满，按之痛，或呕逆，或泄利，或腹痛，皆是停食之候，若右关脉见迟滑，为宿食伤胃，濡伏为脾阴受伤，数盛为食积发热，往往有脉见促结，症见足冷，乃宿食妨D3经脉流行之道而然，不可遂认为代脉阴症，大抵伤寒有发热头疼，虽见脉沈足冷，阳道痿缩，皆是阳症夹阴，合用温中兼消导之剂，宿食一通，胃气敷布，又当从阳症例治也，若误认阴症而与四逆，则热势转亢，真阴立槁，多政亡血躁乱而死，误作实治而与承气，则真阴下脱，虚阳上逆，多致喘胀开泄而死，近有一医治尤德昭霍乱，四逆烦渴脉伏，误与温中药，遂呃逆发斑，屡更四医，杂治罔效，第七日求救于大人。曰：六脉洪滑而促，呃声频并，斑色焮赤，舌本紫肿，证脉俱阳，始先所见厥利脉伏，皆宿食阻塞于中，脾气遏绝之候，肠中之垢虽下，胃中之实未除，与凉膈散去硝加犀角黄连，一服斑退呃止而愈，复有少年患夹食伤寒，足冷面戴阳，医用发汗药，致动阴血，而见四逆呕泄无度，他医用枳实理中，夜半阳回足暖，前医复用消导收功，极诋参朮为非，病家反以为然，詎知此症之生，全赖温中之力耳，一同道之室，伤寒夹食，自用疎表消导，四五日后，邪热入里，而烦渴引饮，水道黄赤，与五苓散一服，遂致水逆不，入小便涓滴不通，昼夜懊憹不安，下问于余，令用大剂五苓散，随吐随灌，继用栀子豉汤，灌吐稠痰水饮数升，二便随至是夜即得安卧，彼谓自用之药未尝有异，但力未到，不得收效，安知其为先前误用五苓引邪犯本，故仍用五苓灌吐，领之外泄，其先后退之之机，难为世俗言也。

问：伤寒夹食，何者宜消，何者宜下。

曰：大法先去外邪，继除里实，在胃则宜消，在肠则宜下，若不分经府，内外并治，必致引邪内犯，故有表邪未尽不可攻里之戒，然人之禀不无偏胜，宿食亦有寒热，不可一途而取，如胃中痰湿素盛，必兼理气豁痰，胃虚不能蕴热，必兼温中消导，有寒食伏久而化热者，当兼清食积之火，有过用消克伤胃者，当温中养气，以资健运之能，若夫下症之缓急，岂特三阳明三承气而已，如虚寒坏病，非假人参之力，则攻之不应，寒积固结，非藉附子行经，则下之不解，湿热胀闭，前后不通，下症最急，非用木香荜半开发痰气，则推之愈逆，大约水道不利，肠鸣腹满之症，必无燥结，大黄必须姜制，芒硝断不可施，与夏秋肠澀同法，然有一下即安者，有下后肠空，胃中之实得下而粘者，制剂之大小，亦当师以成法，如大承气以荡实热，大黄不妨即用两许，双解散分解内外蕴热，和杂药不过二三钱，必续续而进，渐取开结之功，枳实栀子豉汤治食复，所加大黄，不过博棋子大五六枚，临症处方之际，苟非讲明有素，必合辙也。

问：伤寒停食症治，四时有异否。

曰：非但四时症治有异，病名传变，各各不同，而水土方隅，亦是不一，如西北土地高厚，风寒凛冽，患伤寒者非特冬时，春夏恒多有之，尝有北人在南感寒，二三日尚恶寒不止，直待服表药后方发热脉浮者，若岭南炎方濒海，冬月不寒，阳气常泄，四时多患瘴疠，总无伤寒之病，在大江以南，水土卑弱，寒暖不时，伤寒与冬温常间杂而发，举世不察，概与辛温发汗，致变风而死者多矣，亦有邪伏中，至春夏而发为湿病热病者，至于春夏非时暴寒之症，与伤寒殊，冬月寒水司令，其邪虽必从太阳而入，实由阳维而斜次三阴，阴维而斜次三阴，盖邪气满溢，必注沟渠，所以不从十二经而随八脉也，其有宿食者，则必并诸阳明，以其经上贯额颅，是以必胀，即府实热蒸，头痛亦然，若夫春时感冒，则司令已属风木，必先少阳受邪，少阳在中，阳明太阳在外，受则三经俱受，故治感之药，皆不分经络，如芎苏神朮正气之类，为停食感冒之的方，春时阳气枋升，致汗颇易，与蛰藏之令，自是不同，夏月津本外泄，表气先虚，虽或触冒风露，消暑乐中，略兼透表即解，若恣用风药，不无鼓动痰湿之处，如更加停食，必致喘胀逆满矣，大抵停食感寒，无论何时何症，但气口脉显滑盛，而手足温和者，皆为易治，若脉见短澹，而四肢逆冷者，必难克效，此为总诀。

素患欬家兼伤风寒论

问：杂病以欬嗽为重，伤寒以欬嗽为轻，请明其故。

曰杂病之繁冗难明者，莫如欬嗽为最，然究其源，不过胃气不清，阴火上弃，二者而已，内经虽分五藏六府诸欬，而所重尤在聚于胃关于肺六字，此内因之大纲也，

外感之欬嗽有风从皮毛而入于肺者，有寒从背俞而入于肺者，有素患欬嗽，复加风寒，及形寒饮冷所致者，外感乃暴伤经络之邪一表即清，故为轻，杂病积久而发，且有寒热虚实新久之不同，即善察病机者，急难获效，故为重，若夫外内合邪，邪正交互，藏府纠结之症，断非见病医病者之所可以克任也。

问：胃气不清之欬其在胃，客邪所伤在经，治当从府乎，从经乎。

曰：胃为藏府之总司，肺为诸欬之门户，不但五藏之久欬，乃移于六府，即诸府之气，靡不本之于胃，故凡藏府诸欬，感聚于胃而关于肺也，所谓胃气不清者，言水谷之气，不能如雾之上蒸于肺，而转溉诸藏，势必留积于胃，随热气而化为痰，随寒气化为饮，胃中既为痰饮所滞，则输肺之气亦必不清，而为诸欬之患矣，其有六淫外感之邪者，又必兼经而治，如肺胃素有寒热痰饮，诸欬皆用上焦分之药，则与风寒无碍，但虚嗽久嗽之兼风寒者，则难于补敛，稍费周旋耳，外感诸欬中，惟风热风燥二症，世所难明，如冬时先伤非节之暖，复加风寒外遏，而致欬嗽痰结，咽肿身重，自汗浮者，风热也，治此者，当辛润以解其邪，如萎蕤汤之类，切勿误与辛热发汗，致变风温温毒，自利发斑，种种危殆，至于风燥一症，辨治尤难，盖燥为秋气，令不独行，必假风寒之威而令乃振，欬乃发也，然考之于经，则不曰秋伤于燥，而言秋伤于湿，何也夫D4令本燥，以长夏湿土鬱蒸之余气，渐渍身中，随秋令收敛而伏于肺胃之间，直待秋深燥令大行，与湿不相容，至冬而为欬嗽也，此症有肺燥胃湿，两难分解之势，古方中，惟千金麦门冬汤，千金五味子汤二方，独得其秘，不知者以为敛散不分，燥润杂出，则又置而不用，总未达分解之义耳，喻嘉言先生不明湿气内伏，燥令外伤之意，直云内经独遗长夏伤于湿句，致令秋伤于燥，误为伤湿，殊失内经精微之奥矣。

问：阴虚欬逆之人，龙火易于炎上，若更感风寒而用升散之药，则虚火愈炎，为之奈何。

曰：胃气不清之痰嗽，症类繁多，若阴虚火炎干欬，惟有房劳伤精，思鬱伤脾两途审系精伤，则宜补精，神伤则宜养神，一定法也，有客邪加临而见表症，频与小剂桂枝汤其营卫，然必倍芍药以護阴，增胶饴以润燥，使中气有权，则阴火不致于上炎，以共襄建中之功，况芍药得桂，无酸寒收敛之虞，桂得芍药，无妄动阴血之患，如气虚畏寒，手足寒者，则加黄芪，血虚烦热，手心热者，则加牡丹皮，实阴虚感寒之神丹，即欬而小便利，或失小便者，亦不出是汤也，至若夏秋阴虚感冒，莫如葱白香豉汤最宜，兼可以救温病热病时行疫疠之阴虚者，家大人尝言崇禎辛巳，岁饥民困，江南疫病大行，凡服发表攻里之药者皆死，惟用败毒散，补中益气汤，多有得生者，冯长年孝廉，素患阴虚欬嗽而犯时气，遂用葱白香豉汤加入中童便，三日而安，又一地师，宿有血症，亦感是气，即用前汤，更加犀角丹皮，服后大便下血而愈，是皆时气中之变症也，近王公峻先生治一孕妇，风热欬嗽，已经发散后，胎上逼心上气倚息，欬则遗尿，用紫苏饮去芍药腹皮，加萎蕤白微，三剂而胎始

宁，家昆诞先治一少年，阴虚而伤秋燥，常时火炎干欬，五心烦热，，妄梦失精，小水时白时黄，秋杪忽大咳嗽，坐间徧地清痰，周身凛凛畏寒，肌表微微发热，咳甚则呕，呕则鼻衄如注，大便枯燥，小水如淋，先用异功散去朮加山药，次与六味丸加麦冬五味，半月而嗽方止，历推诸验，未有不重在本病者，大抵火炎干咳，悉是阴虚，古人虽有肾肝同治之论，然细格病情，多属肾水枯竭，肝藏多火之症，所以只宜壮水制阳，若导火之法，断断不可轻试也。

问：形寒饮冷所伤，与停食感何异。

曰：停食感冒是三阳经受病，食虽停而未尝固结，胃府未必受伤，故但于解表药中略兼痰理气，其食自消，此受寒气，胃伤冷食，内外并伤，乃致移寒于肺而为欬，邻国尚然为壑，同气连枝之脾，能无寒中之患乎，此一经一府二藏，同时受病，非桂枝人参汤，枳实理中汤，四逆加人参汤等，不能图治，岂停食感冒之可与比例哉。

宿病咽干闭塞兼伤寒论

问：人有素患咽中闭塞者，复伤于寒，则汗下俱禁，有平时咽喉干燥而患伤寒，则但禁汗而不禁下，何也。

曰：干燥与闭塞，二者轻重悬殊，素常咽中闭塞是肾藏精血空虚，生阳之气，不能随经上循喉咙，所以汗之则血随虚阳上脱，而厥冷蜷卧，下之则气随真阴下脱，而下利身疼水浆不下也，平昔但干燥，而不闭塞，乃胃中津液不克，所以不宜发汗，设不知此而与汗剂，重伤津液，不待经传入府而为燥结之患矣，故善治者，一见里症，即当微泄以泄其热，若待结定而下，则与延D5入室何异哉。

问：虚人不宜发汗者，并用建中以和之，如胃燥而用胶饴之润愚所易知，若夫肾虚而用建中，反实土以胜其水，得无愈伤其阴之虑乎。

曰：所谓建中者原在建立中土而堤肾水方中全赖芍药内护其阴，使虚阳无泛上之虞，则桂枝等得以建辛发散之功，更加胶饴滋中气之燥而助其作汗，岂香燥助脾而有伤犯肾水之虑乎。

问：咽中闭塞之见里症，当用何药咽喉干燥之见里症，当用何药。

曰：仲景C4肤汤，治咽中闭塞之里症，神效，外编用童子小便，调生白蜜加C4胆汁隔汤热服，面戴阳者去蜜和葱汤亦佳咽喉干燥者用蜜煎导，热甚用C4胆汁导脐腹按之痛，用小承气急下，以救胃中之津液，所以仲景但禁汗而不禁下也。

问：咽痛非有大热，即为大塞，寒者何以致痛，请明其故。

曰：热则火气鬱蒸，血液燔灼，寒则经络闭塞，阳气不通，皆能致痛，甚症虽繁。大约不出胃热，阴火寒犯少阴三种，如痛而喉舌赤肿，痰气壅塞身热烦闷，前后不通，渴欲饮水，其脉实大有力，或沈伏而滑，皆胃中痰湿挟心包之火为患，此为实邪，或涌或泄或砭，皆能取效，如咽喉虽赤而不甚焮肿，面上时有怫郁之色，而手足不热，二便不秘，渴喜热饮，或口中时有清涎上涌，此龙火上腾而吸引阴津于上，最危之兆若左脉弦数者，阴虚水不制火，惟宜壮水制阳，若六脉数疾无伦，或右尺瞥瞥虚大者，虚阳游散于上也又当用引火归源之法，此皆杂病，即有壮热，不得以伤寒目之，其骤痛无热，而不肿不赤不渴，舌淡青紫，或呕泄清水，二便清利脉来沈紧者，此大寒入犯少阴之经也，若二三日而见烦热躁乱，面赤足冷，脉变虚大者，阴极似阳，虚阳发露之候，急宜通脉四逆，白通加C4胆汁汤温之，迟则不救。

头风兼伤寒论

问：有患伤寒者屡用发散，汗出身凉，而头痛愈剧，彻夜叫号，至夜则有微热，此系何故。

曰：此必素有头风，或血虚风热，而过汗重伤血液，所以其痛益甚也。

问：治此者，仍当祛风乎，清火乎，抑宜养血乎。

曰：风火相煽，额与眉棱目珠但痛，当用选奇汤兼清风热，久鬱成头风者，清空膏茶调散之类，大寒犯脑，痛连齿颊，鬱闭成火者，非兼调寒热，则火不散，如本事玉真丸，宝鉴石膏散，随表里而开发之，痛久不除，须防目翳之患肥人湿土盛者，半夏白朮天麻汤，瓜蒂散，清理湿热为要，若两太阳痛连目梢者为血虚，虽宜养血为主然有火则兼清火，有邪则兼散邪，如四物汤加细辛苍耳芽茶，当归补血汤加葱豉姜枣，皆前人已验之良法。

问：一妇素稟羸弱，孕育过多，常患头痛，背上畏寒之极，夏月必用绵絮裹首，复衣掩背，初冬伤寒，发热头痛异常，周身痛楚，膝下与手臂皆不温，而手心独热，胸膈无恙，二便如常，或用表药，热势不减，畏寒转增，胸膈迷闷，二便艰澀，李怀兹先生用补中益气加蔓荆子微汗而安，愚谓此妇虽虚，然既犯伤寒，法当解表何乃汗之不愈，补之即安，幸明示以开茅塞。

曰：此妇素常阳气不升，而头疼背寒，复与发散伤其卫气，所以热不除而转加畏寒也，用补中益气以升举清阳，卫得参芪之力，自能祛邪外散，非深得东垣之旨者不能也。

问：一老妇久患偏头风，诸治不效，春间复感风寒，方士用火针刺风池合谷等穴，针处皆发赤肿，气从小腹上冲，不时头面赤热，诸医莫解其故，因延疡医治之，用消毒药，肿愈坚大，施元倩先生用桂枝汤数剂而平，细绎此症，似属邪热，而用辛温之药反效，何也。

曰：此即烧针令其汗，针处被寒，核起而赤之成法，幸有施子能用，知仲景之学，尚不至于全废也。

问：今有一少年，形体肥盛，患伤寒昏热，或用表药不得汗，遂譫妄躁乱，愚用凉膈散加黄连而热除，但头痛经月不止，昼则目珠与眉棱太阳俱酸疼，夜则大痛引急如掣，目中如有风吹状，以热掌按之，即稍觉爽快，寐则头与胸前大汗如漉，左脉紧细，右脉浮缓，服茶调散，用搐鼻法不应，与养血药亦不应，不识此为何病，何药可以收功。

曰：此热邪虽从内泄，而寒痰袭于经中，因体肥不能外泄，所以流连不解，内经所谓其人肥则为目风眼寒是也，治当解营分郁闭之火，除经络沈沍之寒，授以三因芎辛汤加生石膏半两，数日必能获效，服之果然。

心腹诸痛兼伤寒论

问：凡宿有心腹诸痛，因外感之邪触动而发，若欲先治表症，里痛势难刻缓，若欲兼治其痛，又恐有碍于表，历考方论中，素无成法可师，幸显示至理，以补昔贤之未逮。

曰：诸痛皆有表里气血虚实寒热之分，其痛在肌表者，中间不无里症，如胃脘留饮之臂痛，肾虚足不任地之脚心痛，肾衰风袭之下体痿弱，骨节疼痛，岂非痛出外而病根于里者乎，然病虽从内而发，其实痛在经络，所以治表之药，总无妨于本病，但不可不顾虑血气，以虚其虚，痛必转剧也，其胸胁肩背诸痛，症虽不一，以大纲论之，悉为阳分之疾，纵有伤寒表症，而痛楚不堪者，不妨兼治其痛，并无引邪入犯三阴之虞，即使阴邪上逆，不过先温其里，若肾心痛之与背相控，如从后触其心者，仍无碍于里症也，观仲景太阳例中，伤寒医下之，续得下利清谷不止，身疼痛，急当救里，则知后身疼痛，清便自调者，急当救表，内有虚寒者，必当先温其里而后解表，乃正治也，至于腰脐少腹诸痛，虽皆阴分之患，然既有表症，则当从表治之，如腰痛而兼外感，亦须桂枝汤以分解太阳之邪，则里气亦得疏通，而痛必少缓，寒者则加附子以温之，腹痛用小建中，为土中伐木之圣药，血虚而气散者尤宜，有寒则加干姜，寒甚则加附子，虚寒则用桂枝人参汤，寒极而呕，金匱大建中汤，少腹痛，用当归四逆汤，寒加吴茱萸最妙，此皆兼理外内之良法也，大抵有宿病之人，不得用峻汗峻攻之法，必参其人之形气盛衰，客邪微甚，本病之新久虚实，向来之宜寒宜热，宜补宜泻，宜燥宜润，宜降宜升，或近日服过何药之相安不相安

，其间或挟痰，或挟血，或挟火，或挟气，或挟水，或挟积，务在审症详明，投剂果决，自然随手克应矣，故凡智者用方，法法不离古人，而实未尝执古人之成法也。

问：一少年素有便血，自言触秽腹痛，经日不止，因觅土医刺委中出血如注，是夜即大发寒热，头痛如捣，腹胁满痛，不能转侧，讖语如见鬼状，一馆师以大柴胡下之而愈，愈后不时寒热咳嗽，服滋阴清肺之药两月余，其嗽愈甚，近日饮食少进，大便作泻而兼下血，左右关尺皆弦细而数，未识此症，尚可图治否。

曰：此必刺委中时感冒风寒，因其人素有便血，邪弃虚入，而为热入血室，如阳明病下血讖语之例，非独妇人经水适来适断而有是症也，用大柴胡得愈者，是偶中，痛随利减之效，原非正治，所以愈后不时寒热咳嗽，脾肺清阳下陷，而肺失通调输化之气也，斯时不与调补脾胃，反与寒凉清肺，则脾气愈伤，不能统血，而为下脱泄泻之患，虚损已成，虽暂时复生，恐难为力矣，盖腹痛一症，举世咸谓沙胀，或刮或刺，或饮冷水，种种为害非浅，曾见有阴虚停食腹痛，误饮冷水，吐利不止，周身青黑而毙者，有经水将行作痛，亦饮冷水，经闭不通而成蛊胀者，与夫痛痹一症，灵枢谓之贼风，后世方书名为痛风，亦曰白虎历节风，近来呼为箭风，例禁汤液，恣用针艾火焮，愚夫无知，被其煽惑而受非刑，固不讶，即明哲之士，亦常以箭风二字凿凿而谈，且有自任时医者，身有所痛，必倩村中舆妪挑焮，咒水吞符，无所不至，吾将以灵素痹论，金匱胸痹血痹诸例，请用从火庶不致与俗全违耳。

亡血家兼伤寒论

问：仲景太阳篇中，有亡血家不可发汗，发汗则寒栗而振，有衄家不可发汗汗出则额上陷，脉急紧，直视不能眴，不得眠，夫亡血是统诸失血而言，何衄家另设一例，且血为阴，血亡则阴伤，阴伤则阳盛何故汗之反寒栗而振，衄家何独不然，又为额上陷，脉急紧等症。

曰：血之与气，异名同类血虽属阴，实为阳气之根，与气相为维附，一息不能相离，凡人身中有气不到处，则血凝不流而为刺痛，痛处必热，有血不行处，则水饮袭入而肿痛，痛止必寒，素有血症之，人复发汗以夺其血，寒栗而振，势所不免，血既消亡于内，则阳气无根，所以诸亡血家骤脱不止，必用大剂人参敛其神气，气敛则血有所统，无复再脱之虞，斯时虽不敢望其阳生阴长，但得扶定胃气以进饮食，即是生长之基，设不知此而用血药，惟有膩膈伤中，而为夺食泄泻之患也，至于衄血一症，皆由阳明经火气逆行而至，故曰：衄行清道，不知者以清道指肺，遂有衄血出于肺之说，大可喷饭，详衄血一症，十二经惟手足阳明太阳四经有之，即使因肺致衄，亦必由手阳明经而至，肺虽清肃之藏，业常少血，且经脉不行于鼻孔，其血从何而至哉，盖阳明多气多血，是以患其症者，恬不知怪，然惯衄之人，稍有劳动，或烦心过饮，受热感寒，血必随火而行熟径，盖火即气，气随血散，久之经气

并伤，更加夺汗，则血不荣筋，而为两额之动脉收引，眦急不能卒视也，其所以不得眠者，虚火蕴降于胃，胃不和则卧不安，此皆亡血人复发其汗之候，若因伤寒而致亡血，又当随症施治如太阳症失汗，邪留经中而衄，非麻黄汤汗之不解，有热传营分而为吐血，则当清解其内，如犀角地黄汤，黄连阿胶汤之类，凡此种种，未遑尽述，姑就宿病伤血之人伤寒表症而言，如衄血则宜小建中加犀角丹皮，咯血则宜小建中加丹皮童便，吐血则宜黄芪建中加童便阿胶，伏气发温而为吐衄，皆从内而至，经络胃府通宜凉膈解毒，三黄石膏加葱豉童便之属，若感冒风热之衄，则宜葱白香豉汤加童便，若素有便血而兼伤寒，则宜千金内补当归建中，寒加灶土炮姜，热用白头翁汤，妇人宿患血崩而感客邪，则宜金匱三物旋覆花汤加香豉，或当归建中加黄芪防风葱豉最妙，至若热邪传里而触动阴血，无论宿病新病，皆无表症纠缠，但须详从何道而至，或稠或清，或鲜或晦，自可直清本病，竟行无碍矣。

问：亡血家衄家症见于外，尚有发汗之误，其血畜于内而显发热头痛者，得无误汗之患乎。

曰：凡畜血必有见症，可察而知，其所患处有三，畜于胃脘之内，则胸膈隐隐刺痛，甚则牵引于背，畜于厥阴之经，则胁下痛引腰脊，畜于膀胱之府，则少腹急痛，若小便不利者，并伤气分也，其辨治之法，须详新久虚实寒热，大率新者多实，实则宜攻久畜必虚虚当兼补，寒则非暖不散，最忌酸寒，热则宜于寒下，然必加辛温而为向导，亦有症显虚热，而所畜属寒者，必畏寒而畏热饮，不可因其假症，而误与寒凉攻血，多致发呃脱泻而死，其治畜血之兼伤寒表症，轻则小建中香苏散之类，重则五积散，随上下寒热而为裁酌，至见半表，及传入里，皆与本病无碍，但久畜虚人，不可轻动其血此为切禁。

问：邹孔昭之弟费仲雪之女，皆患失血何以知其必死而辞之。

曰：孔昭昆仲俱患，喘欬吐血，肩息不得卧，孔昭之脉，尺部虽弦而寸关却浮，症虽阴火迫肺，脉则兼感客邪，且审其所吐之血，多滞涎水，知必从胃而出，故先与小建中加丹皮，和其营卫，绩与异功去朮加薯芋丹皮，下灵砂丹收摄阴火，则肺胃自清，于昭之脉，关尺皆弦细如循刀刃，血色正赤如凝朱，为少阴守藏之血，故知必死，费仲雪先生，久患膈塞呕逆，中脘搅痛如刺，或时痰中带血，六脉沈细如丝，自谓六阴之脉，及按至神门，别有一脉，上至阳溪迢迢应指，知胃气未竭，尚可苟延，其令爱不不过欬血一二次，尚有梳洗出，诊脉得纯弦细数，此胃气已竭，安有复生之理。

问：郭孝闻之室血崩，闻用金铃子而愈，何也。

曰：孝闻夫人暑月经行时，凉卧风中，色患淋漓，加以恼怒跌哭，遂崩脱不止，小腹中如线条，贯心掣痛，常发热头疼，遍体烦疼，服止血诸药不应，而进参芪，忽

然忽惯不省，崩脱愈甚，深夜急遽邀往，脉得弦大而芤，独左寸丸滑，知冲任二脉受病，明是风入胞门所致，久之风从火化，血愈伤而火愈炽，非旋覆花汤金铃子散兼进，不能清其风热，降其逆气也，况此症多有火淫血室，湿结子户，及鬱结伤脾，怒动肝火，恐惊失跌，种种不同，若用通套升发补敛之药，乌能获效哉。

问：兵道李石台内侄之伤寒，更七医而转笃，皆不识为何症，尊大人何以知其为血而下之。

曰：鲁公弃于夏月从陆来吴，途中中喝受伤有之，大暑中何有伤寒之症，医见壮热皆惯，便与发汗，发汗不已，兼之消导，不已，继进参朮，主见杂出，补泻偏尝，正气转伤，畜积愈固，而见善忘如狂，身汗如油直视不眠，唇反不收，齿龈腐秽，七昼夜喃喃不休，手足动掉不宁，脉得纯弦而豁大中芤，明是畜血而兼狐惑之症，急与犀角地黄汤加黄连乌梅，清其胃，安其虫腹中之黑物自下，而神识顿清，从未尝用攻血之药也。

多汗家兼伤寒论

问：汗家不宜发汗，则邪从何解。

曰：所谓汗家不当发汗，是指平昔腠理不固，不时伤风自汗者而言，即仲景例中汗家重发汗，必恍惚心乱，小便已阴疼一条不过言卫虚营气常泄之人，汗之复伤其营，乃有如是变症，非谓多汗之人，一概不可发汗也，尝见阴虚盗汗者，发汗不得汗，则干热不已，汗出则足冷面戴阳，阳虚自汗者，发汗则恶寒不食，甚至冷汗厥逆，盖阴虚则血热，其汗亦热，阳虚则其寒，其汗常冷，且有胃气虚寒者，常出淡汗，凡此皆以发汗为禁，惟小建中为主阴虚加丹皮，阳虚加黄芪，阴阳俱虚，二味并加，胃虚自汗不止，则加人参，又有血虚心痛，则加当归，血虚寝汗热不止，则合当归补血汤，皆万举万当，百不失一者，若夫湿热素盛之人，举动则浑身汗出，设有客邪表症，亦谓其虚而禁发汗，则表邪与内湿，固结难分，当弃邪未入里时，急与表散，当表法与寻常不同，必兼辛凉淡泄之味，则胃热方化，非但无痰逆气满之虞，并可以杜风热内入之患，如越婢加半夏汤，小青龙加石膏汤，麻杏甘石汤，麻黄连翘赤小豆汤之类，若治稍失时，邪一入内，即当随症用泻心汤诸法，复有湿热多汗之人而兼阴虚者，汗之则喘汗胸满，上热下寒而上脱，下之则溺闭腹胀，五液注下而下脱，兼阳虚者，汗之则额上与手背冷汗不止而上脱，下之则呃逆呕秽，暴下不止而下脱，所以犯此皆死，余尝用小陷胸合C4苓汤，治阴虚湿热，小陷胸合理中汤治阳虚湿热，每多见效，倘阴虚下利不止，用赤石脂禹余粮汤，阳虚下利不止，用桃花汤，间有得生者此皆平时多汗，复感客邪之候，若因外感而见自汗者，则与上法无预也。

积聚动气兼伤寒论

问：积聚动气三者，皆腹中固疾，其受病之原有异否。

曰：积聚寒气客于五脏之膜，血气不行所生，聚则汁沫聚于六腑之廓，溢畜不泻而成，动气为无形之气受病，所以忽有忽无，与积聚之有形质者不同。

问：有动气之人，不可汗下，其有积聚者，亦有所禁乎。

曰：动气是脾衰气失统运之候，汗下先动脾津，故为切禁，非若积聚初起之可用攻击者，若久病气衰，亦必兼补而攻始应，尝见有积聚误汗，则津液外泄，固结随表药而上升者，误攻则气随下脱，阴邪无制而愈逆者，亦有下之便利不止，水道涩痛如淋者，内经所谓此风根也，不可动，动之为水溺澹之病是也。

问：已误汗下者，为之奈何。

曰：误汗虚阳扰乱而气上冲，或欬吐眩暈，或心烦恶寒者，通宜五苓散去朮，多加枣仁降敛之，误下虚阳不禁而气下夺，或身热蜷卧，或下利汗出者，金匱大建中汤，吴茱汤，府子理中加桂苓汤，急温其里，则虚热不治自息矣。

问：三证之表法。

曰：积之兼表者，以温血为主，加甘草干姜汤加桂枝姜枣，感冒则香苏散，葱白香豉汤，聚之兼表者，以涤饮为先，如小半夏茯苓汤加桂枝姜枣，或四七汤，芎苏散之类，动气之兼表者，以安中为务，如小建中黄芪建中为最当，非若积之芍药助阴有碍，聚之胶饴助湿难投也，若营伤无汗者，则合香苏饮，凡表药皆升而香苏独降也。

问：三证之和法。

曰：和法总不出小柴胡，然于本方中宜除去参芩，积加细辛干姜，聚加茯苓橘皮，动气但去黄芩，加木香桂心之类，又须知中虚挟邪之，人胸多寒热不和，常有痞满之患，当于三泻心汤，黄连汤，旋覆代赭石汤选用，若待胀满喘急而治，难为力矣。

问：三者治失其宜而见里症，当何法以除之。

曰：大约中气久虚，及有宿病之人，先用导法，如积用蜜煎加川乌末导，聚用C4胆汁加姜汁导，动气用酱姜导，若里热势剧不下必死者，积用大黄附子汤，聚用厚朴七物汤，动气理中汤去朮，加桂苓姜制大黄微利之，庶免阴气逆上之虞，至于伏气发温，虽有积气当凉膈散大柴胡，及三黄石膏加大黄急下之，以热毒从内而发，里

先受邪，所以不禁内夺，非导法所能荡涤其热也。

疝证兼伤寒论

问：七疝之名，各有不同，且所治诸药，多寒热错杂，此属何意。

曰：疝瘕之症，因内经有任脉为病，男子内结七疝句，致元方子和各立七疝之名，咸非内经所谓，内经以邪留诸经，腹中引急诸痛，通名曰疝，近世惟以睪丸之病为疝，外此皆置而不论也，详经中虽有藏府诸疝，统而言之，不离任与厥阴，盖肝则任之生化，任之阴气为疝，肝之阳气为风，故治疝多用风药，观金匱大乌头煎，乌头桂枝汤，并不用附而用乌，义可见矣夫疝之受病，多由寒热不和，所以经脉缓急，即使湿热，必因寒束而痛伏寒必由火鬱而发但须详偏寒则从寒，偏热则从热，如乌头栀子汤，治本寒标热，少腹中缓急痛引心胁之疝，苍朮五苓加楝实檿皮汤，治癰胀坠之疝，皆寒为热引，热为寒导之法，然其症各有所挟，必非空气作痛，故有血则兼攻血，有积则兼攻积，能识此义方可与言治疝诸法。

问：疝症多兼风治，表症自可无虞，不识里症有所禁否，

曰：在无客邪时，治其本病，多兼风药，若一有风寒，则表药反难恣用常见有疝瘕人，服羌防柴葛之类，升动阴邪，每致喘胀呕呃，善治者，必兼桂苓楝实等味于香苏芎苏小建中，葱白香豉诸方中，则陈气不致于上逆，若有陈寒，必加乌附细辛姜桂之属里气不温，外邪必不得散，倘见里症，切禁苦寒峻攻，与积聚等法无异。

淋浊兼伤寒论

问：诸淋皆肾虚膀胱受热，何古方中多有用热药者。一曰：淋之为病，小便如粟状，方书分膏石气血劳五种，丹溪谓诸淋皆忌补气，气得补而愈胀，血得补而愈涩，热得补而愈甚，惟劳淋则宜补气，但须兼利州都，则水道之热方化，然多有肾虚囊中受寒者，症必先寒凜而后溲便血淋亦有属寒者，其色必瘀晦无光，不鲜不紫，是皆膀胱虚寒，阳不化阴之候，观金匱治小便不利，有水气而渴，用栝蒌D6麦丸，消渴之饮一斗，溲一斗溲上如脂，用肾气丸，一属肾气不开，一属肾气不合，并用附子以司开合之权，岂可概谓膀胱受热乎。

问：浊带之症，丹溪谓胃中浊痰渗入膀胱，而所下常有赤色首何。

曰：肥人固多浊带，而瘦人亦恒患此，且多有阴中，不洁，败浊袭入精窍者，辨治之法，大约以干掩窍端者为火，不干掩者为湿，小水赤濇而痛，或浊有赤色者为小肠湿热，小水不赤不痛，而所下色白，或渗利转甚者，为脾气下陷，茎中痛痒而发寒热，或有结痛者，为毒邪所侵，若此种种，讵止痰湿一端而已。

问：淋浊皆前阴之疾，设有是症而更伤于寒，其治亦相类否。

曰：淋为精病，浊为气病，安得相类精病则宜黄芪建中，热加丹皮，寒加附子，下消走精二味并加，精滑不止，或梦中走泄，桂枝加龙骨牡蛎，汤气病则宜香苏散，湿加苓半木香，热加葱豉滑石，虚加升柴参芪，水气上逆而渴，五淋散灌吐取汗最捷，此皆治淋浊兼外感之良法，复有兼杂他症者，如苕溪田孟先，久患膏淋，溲中有块如橘核状，外裹血膜，中包黄水，乃醉后入房，酒湿流入肾藏所致，偏服利水固精药不应，溽暑中忽然憎寒发热，喘促闷乱，腰背烦疼，脉见浮濡沈细，是淋久阴伤暑气袭虚之症，先与生料六味加川萆薢作汤，下消暑丸，次用前汤送本事猪苓丸，八服诸症霍然，江右孝廉蔡允恭严冬患浊，小腹结硬，大发寒热，巅痛自汗，脉得左缓右濡，两尺紧细，乃风挟毒邪入犯厥阴之经，与当归四逆汤热服，覆汗而热除，即以前方除去通草姜枣，加蝎稍陵鲤甲麝脐，丸服不令作汗，数日块绌痛止，但浊犹未净，或令嚼生银杏而痊，世人咸谓银杏濡精，殊不知其专涤败浊也。

泻痢兼伤寒论

问：泄泻皆脾胃之疾，何内经有风寒湿热之泄，且治泻多有兼用风药者。

曰：六气中，除燥气外，皆能为泻，其邪咸从经络入犯中土，所以治泻多用风药，即内因之泻，亦常兼用，如脾虚气陷作泻，用补中益气，必加羌防以胜湿，乃正治也，其五更肾泻，昔人皆谓肾虚，而用四神五味补敛之药，服之未必悉应，殊不知此皆酒湿入伤水藏所致，余尝用金匱泽泻汤加姜辛五味萆薢之属，往往获效，又有脾肾俱虚之泻，若小便清利倍常，则泄泻大作，此降泄多而升气少，切不可用苓泽之类，且关门失守，肾气空虚，亦不得用升柴等药，惟宜附子理中，加紫石英赤石脂红豆以固敛之，如素有酒积食积，痰湿水饮，或积兼气滞顿泻而兼感外邪者，并宜香苏散为主，酒积合泽泻汤，食积合平胃散，痰湿合二陈汤，水饮合五苓散，气滞合四七汤，泻症繁多，聊举一二为例，余可类推矣。

问：滞下以通利为务，若兼感风寒而与通利，能无妨于表症乎。

曰：痢疾多患于夏秋，本无伤寒之理，然初秋常有非时暴寒，或久痢延至冬时，及休息痢，多有兼外感者，既有表症，自应救表，但须审本病之新久虚实或气分受伤，或血分受伤，或气血并伤，参酌而治可也，夫痢之通利，不过弃初起湿热全盛时，及为相宜，然在元气虚人，伤犯胃气，多有呃哕不食，下利不止而危者，当知积滞原系肠中津液，因气不统运而为败垢，惟当宣通其气，则失统之败垢自下，未伤之津液自安，后重窘迫自除矣，近世但守痛随痢减一语，概以通利泻气之剂，施之久痢虚痢，吾未见有得愈者，况兼客邪为治乎，方书中原有胃风汤，治风毒下痢参苏饮治下痢发热，白头翁汤治热痢下重，败毒散，治疫痢壮热阳旦汤，治血痢身热脉浮，阴旦汤，治血痢瘀晦腹痛，当归四逆汤，治下痢身热手足冷，五苓散，治下

痢有热水道闭，升麻葛根加犀角汤，治下痢身热发斑，调中饮，治下痢胸前手足阴班，三奇汤，治久痢后重不除，补中益气汤治久痢元气虚陷，及疟后病后一切虚痢，皆先哲之成，则未尝不用伤寒之法也，然非博闻广识之士，难以语此。

问：一人阴虚发热，下痢赤白，至夜烦渴不宁，或用凉血攻积药而死，一人阴虚发热，下痢五色，胸中常觉饥状，得食则胀，或用补中益气而死，一人阴虚发热，下痢不食，郭友三先生用猪苓汤，黄连阿胶汤而痊二，方并非下痢门中药，而用之辄应，何也。

曰：世患阴虚下痢者颇多，古人从未阐发，其症未有不发热不烦渴，不畏食，不见红，不夜甚者，盖阴气内亡，势必虚阳外扰，故治阴虚之痢，凉血死，攻积死，补气亦死，惟兼清解热毒，兼滋阴血，庶可保全，此用仲景少阴例中救热存阴之法，与金匱治产后下痢虚极，用白头翁加甘草阿胶汤不殊也。

胎产兼伤寒论

问：孕妇百病以胎产为主，若有外感客邪，黄芩白朮，仍宜用否。

曰：古人用黄芩安胎，是因子气过热不宁，故用苦寒以安之，脾为一身之津梁主内外诸气，而胎息运化之机，全赖脾土，故用白朮以助之，然惟形瘦血热，营行过疾，而胎常上逼，过动不妻者，乃为相宜，若形盛气衰，胎常下坠者，非人参举之不安，形盛气实，胎常不运者，非香砂耗之不安，血虚火旺，腹常急痛者，非归芎养之不安，体肥痰盛，呕逆眩晕者，非苓半豁之不安，此皆治母气之偏胜也，又有父气虚羸，或有宿病而胎稟不固者，则当如父调理自安，若因风寒所伤，而胎不安者，则桂枝汤，香苏散，葱白香豉汤，谅所宜而用之，和解则小柴胡，柴胡四物，里症则大柴胡，小承气，凉膈散，随上下轻重而施，伏邪时气，尤宜急下，此即安胎之要诀，内经所谓有故无陨是也，下药中独芒硝切不可犯，凡胎死腹中，及误断脐肠，胞衣上升，壮实人并用平骨散加芒硝，虚人理中汤，因外感伤胎者，五积散加芒硝服之，胞胎即缩小而下，走血之性可知，其半夏大黄，虽言孕妇忌服，然用之得宜，亦安胎圣药，若有客邪而用芩朮，使热邪留连不解，反足伤胎，观紫苏饮，治孕妇风寒，恼怒喘胀，腹痛诸疾，即于本方除去川芎生姜，而加白朮，为达生散，瘦胎饮，则以芩朮为君，而加枳葱滑石，岂二味专主安胎，又能滑胎耶，盖瘦胎饮一方，特为奉养太过，胎肥不能转运而设，今人不达此理，无故服之，伤耗其气，临产无力送胎，反致难产，及酿成产后诸患者不少，良由不明虚实补泻故尔。

问：产后以行血为务，若有表邪而与行血得无引邪伤营之患乎。

曰：产后诸疾非行血则邪不去，即诸虚症，亦须血行其气乃复，第行之有方，不可过峻，凡产后危症，莫如三冲三急，三冲者，败血之冲肺冲心冲胃也，三急者，新

产之呕吐泄泻多汗也，其用药则有三禁，禁佛手散，以川芎能发汗也禁四物汤，以地黄能作泻也，禁小柴胡，以黄芩能阻恶露也，然皆产后之常法，设有风寒危急，亦将守此坐令致毙乎，尝读金匱产后之例，有大承气汤，下瘀血汤，阳豆汤，三物黄芩汤等方，不能使人无讶，及见家严所治金圣祥妇，产后败血冲肺，发热面赤喘胀，人事不省用二味参苏饮，倍苏木加芒硝恶露即通而苏宋孝先次孙媳，产后发热头疼，腹中急痛，死绝复苏者再，与当归内补建中汤，得汗而痊，其长孙媳临产下痢，产后脓血无度，更兼感冒客邪而发热头痛，此血液大脱，胃气逮尽，非但难胜药力，即益母汤，亦伤胃难用，惟借金匱黄土汤之法，令以伏龙肝，炒黑查肉炒焦砂糖炒焦陈米，入姜枣煎成不时热服，取枯以去垢，而有温中止痢之功，姜枣以和营散邪，三日热退痢减，果进糜饮，七日而痢全瘳矣，郑墨林夫人亦临产下痢，用连理汤加木香，二服而止，止后即产，产后呕吐大汗，以抵圣散去赤芍加炮姜黄连而安，徐日升妇，草蓐中发露得风，壮热头痛，面赤胸烦用香苏散加荆芥葱豉而热除，但手足心热，不时烦扰，善食易饥，二便不利，与三物黄芩汤而安，以上等治，未尝不用汗下，不用寒凉，而暴病势紧，不得不猛治者，下手稍软，去生便远，其病久气衰者，非但不可峻攻，峻补亦是不可，必缓剂轻调，以候胃气之复，务在临症权宜，若拘世俗之见而禁汗下专事血药以治胎产之疾我未敢信以为然。

经脉

经脉出自灵枢本当全篇融贯熟读，为医门之实学，第苦L0缕交加，难于诵记，于是稍为裁削，略其繁词，兼取轩岐仲景切于经脉之文，参入一二，以为决诊之捷法，若言笔削圣经，则我何敢。

肺手太阴之脉，起于中焦，下络大肠还循胃口，上膈（膈膜遮膈浊气使不上熏心肺），布胸中属肺，从肺系横出腋下，循臑内，下肘中，循臂内，入寸口循鱼际，出大指，其支者从腕后直出次指内廉出其端。是动（邪在气气为是动），则病肺胀满，膨膨然而喘欬（其脉布胸中故病喘欬肺宜温润燥则病寒亦病），胸中痛，缺盆中痛（缺盆乃手足阳明脉气所发肺病则胃气不升大肠之气不降故气不行而痛），甚则交两手而瞀（瞀麻木不仁也），是主肺所生病者（其在血血为所生病），欬上气喘渴，烦心胸满，臑臂内前廉痛，气盛有余，则喘渴，胸盈仰息，肩背痛，风寒汗出中风，小便数而欠（风寒在表故汗出中风邪伤其气故小便数而欠欠少也），气虚，则肩背痛寒，少气不足以息，溺色变（气虚则阳病故为痛为寒而怯然少气金衰则水涸故膀胱气化不行而溺色黄赤也），气绝则皮毛焦，爪枯毛折，盛者寸口大三倍于人迎，虚者寸口反小于人迎也。

大肠手阳明之脉，起于大指次指之端（肺脉出次指大肠脉即受肺交而起食指），出合谷两骨之间，上入两筋之中，循臂上廉，入肘外廉，上臑外前廉上肩出髃（音余），骨之前廉，上出柱骨之会上，下入缺盆，络肺下膈，属大肠（大肠上接小肠下接回肠传送不洁之物必待肺气下行故与肺为表里），其支者从缺盆上颈贯颊，入下

齿挟口，交人中左之右，右之左上挟鼻孔。是动，则病齿痛（必要热饮），颊肿，是主津所生病者（大肠与肺为表里肺主气津由气化故凡大肠之或泄或闭皆津所生之病也），目黄口干，鼾衄喉痹（能言），腹中雷鸣切痛，感寒则泄，气常冲胸，疰（日发而渴）肩前膈痛，次指不用，气有余，则当脉所过者热肿皮肤谷谷然坚肿而不痛，虚则寒栗不复，肩背肘臂外痛，盛者人迎大三倍于寸口，虚者人迎反小于寸口也。

胃足阳明之脉，起于鼻之交頤中，入上齿挟口环唇，出人迎（内名在面），络于目（阳明主肉其脉挟鼻络于目）上耳前循发际，至额颅，其支者，下人迎（穴名在颈动脉应手），循喉咙，入缺盆下膈属胃络脾，其直者，从缺盆下乳挟脐入气街中（气冲穴也），其支者，起胃口，循腹里，下气街中而合以下髀关抵伏兔（伏兔在膝上六寸髀关在伏兔后）下膝腘中，循胫外廉下足跗入中指内间，其支者，下膝，入次指外间（按足阳明属充内庭陷谷皆在次指灵枢甲乙脉经俱作中指误），其支者，别跗上入大指间出其端。是动，则病洒洒振寒，善伸数欠，颜黑（伸欠类黑土胜水也）恶人与火（胃寔则热，热则恶火），闻木音则惕然而惊（土恶木邪故惊也），心欲动，独闭户塞牖而处，甚则欲上高而歌，弃衣而走（阳盛则四肢实实则能登高也），贲响腹胀（火盛与水相激故激搏有声即肠鸣也本输篇云大肠小肠皆属于胃），骂詈不避亲疏（土热鬱蒸于心胸神明则乱也），是主血所生病者（阳明多气多血是主血所生病），狂疟（间日发而不渴），湿淫（湿浊下渗也），阴痿足废（冲督带三脉皆聚阳明阳明主润宗筋宗筋主束骨而利机关也）汗出鼾衄，唇漯漯暴难言，甚则不能言，面肿齿痛（必恶清饮）口喎唇胗（人中肿也），面赤热，颈肿喉痹（不能言），大腹水胀，（土病不能制水也），膝腘肿痛，膺乳气街股骭外廉，足跗上皆痛，次指不用，腹胀，胃脘当脐而痛，上支两胁，膈塞不通，饮食不下，胃中不和则不能正偃，腹中鸣，身重难以行，胃热则宗气喘数（胃之大络名虚里出左乳下其动应衣宗气也），气盛，则身以前皆热，消谷善饥，溺色黄（此阳明寔热在经在府之辨也）气不足，则身以前皆寒栗，胃中寒则胀满（此阳明虚寒在经在府之辨也），盛者人迎大三倍于寸口，虚者人迎反小于寸口也。

脾足太阴之脉，起于大指之端上内踝（音哇），循股内前廉，入腹属脾，络胃，上膈，挟咽，连舌本，散舌下，其支者，复从胃别上膈，注心中。是动，则病噦本强，食则呕（脾气暖则健故食易消寒则衰故食不化而呕逆），胃脘痛，腹胀善噫（脾脉入腹属脾络胃故为痛为胀阴盛感而上走阳明故气滞而为噫），得后与气，则快然如衰（病后失气则快然如病衰但倦怠耳）身体皆重（脾湿之气下流也），是主脾所生病者，舌本强（气病则强血病则痛）烦心心下急痛，寒疟溏泄泄（脾寒则为溏泄脾滞则为症瘕），水闭黄疸不能卧（水气逆满伤气也），善饥善味肉痿，足不收行善瘰，强立股膝内肿，厥大指不用，寒甚则厥而响响然，腹中谷谷便溲难，心痛引背不得息，实则腹胀泾溲不利，身尽痛虚则四肢不用，五藏不安，百皆纵腹大肠鸣飧泄面黄不嗜食，食不化怠惰嗜卧九窍不通身体不能动摇，当脐上下左右动气，气绝则脉不营肌肉，舌萎人中满唇反盛者，寸口大三倍于人迎，虚者寸口反小于人迎

也。

心手小阴之脉，起于心中出属心系下膈，络小肠其支者，从心系上挟咽，系目系其直者复从心系上肺，出腋下，下肘内，循臂内后廉，入掌内，循小指之内出其端（心系有二一则上与肺通为心包络之系一则下络小肠为周身血脉之总司）。是动，则病噤干心痛渴而欲饮（心火炎则心液耗故渴而欲饮），善笑善忘，眩仆烦心，善惊不寐是主心所生病者，目黄，膺背肩肋满痛，膈臂内后廉痛，厥掌中热而腕浸淫疮疡，舌干焦苦，消渴舌破心胸间汗，实则笑不休，虚则悲，胸腹大胁下与腰相引而痛，气绝则脉不通，血不流，髡色不泽，面黑如漆柴，盛者寸口大再倍于人迎，虚者寸口反小于人迎也。

小肠手太阳之脉，起于小指之端，循手外侧上腕循臂骨下廉，出肘内侧两筋间上循膈外后廉，交肩上，入缺盆，上冲心，贯肝肺，络心循咽，下膈抵胃属小肠，其支者从缺盆，循颈上颊至目锐眦，却入耳中，其支者，别颊上（音抽）抵鼻，至目内眦。是动，则病噤痛，颌肿不可以顾痛在颈侧也，肩似拔，膈似折，是主液所生病者（小肠主泌别清浊宿则清浊不分而流衍无制是主液所生病也），耳聋目黄，颊肿鼻衄（不成流），颈颌肩膈肘臂外，后廉皆痛虚则小腹控睾（音高），引腰脊上冲心而痛，盛者人迎大再倍于寸口，虚者人迎反小于寸口也。

膀胱足太阳之脉，起于目内眦（睛明穴也），上额交颡其支者从巅，至耳上角，其直者，从巅入络脑，还出别下项，循肩髃间，挟脊抵腰中，入循膂络肾，属膀胱其支者，从腰中下贯D7入腠中，其支者，从髀内左右别下贯脾，挟脊内过髀枢，下合腠中，以下贯踇内（踇音湍足跟也）至小指外侧。是动，则病冲头痛（邪循经上而痛也）目似脱，项似拔（痛在项后不可俛仰），脊痛腰似折（痛上寒），髀不可以曲，腠如结，踇如裂是主骨所生病者（肾主骨膀胱为肾之府故亦主之世本作是主筋所生病者误），痔瘡（虚则痔盛则瘡），狂癲疾（邪入于阳也）头顙（音信）项痛，目黄（为畜血），泪出眦衄（则成流），小腹偏肿而痛，以手按之即欲小便而不得，胞痹少腹按之内痛，若沃以汤，溺于小便，上为清涕，膀胱不利为癃，不约为遗溺也项背腰D8腠踇脚皆痛，小指不用，盛者人迎大再倍于寸口，虚者人迎反小于寸口也。

肾足少阴之脉，起于小指之下，斜走足心，循内踝后别入跟中，出腠内廉上股内后廉，贯脊属肾络膀胱，其直者，从肾上贯肝膈，入肺中循喉咙，挟舌本其支者，从横骨中挟脐，循腹上行而入肺（横骨一名下极），从肺出络心，注胸中（肾藏有二其脉交通水火左者直上入肺而循喉挟舌右者直行脐腹而上络心胞越人以右肾为命门非也）。是动，则病饥不欲食（阴火上弃虽饥不欲食也），面如漆柴（肾水枯也），欬唾则有血（真阴损而延及其母也），喝喝而喘（肾水不能上通于肺也），口干吕血坐而欲起（阴虚阳扰而不能静也），目如无所见（目之明在瞳子瞳子者骨之精肾气内夺故目如无所见也），心如饥若饥状（心肾不交则精神离散故心如悬阴虚则

内馁故常若饥状），气不足，则善恐心惕惕如人将捕之（肾主志为恐肾气怯故惕惕如人将捕之），是主肾所生病者，耳鸣遗泄口热舌干，咽肿上气，噤干及痛（厥气走而不能言手足清大便自利口热如胶）烦心痛（痛引腰脊而欲呕），黄瘁（水虚土寔故为瘁其额上必黑），肠澼（肾开窍于二阴故为肠澼寒则利清谷热则便脓血），脊股内后廉痛痿厥嗜卧泄利下重，足下热而痛，小腹急痛，腰下冷痛，自言腹胀满，而寔不满，胫肿烦冤（烦为烦扰冤为冤热）骨痿不能起，中清（音抄季胁下也）指清黑，清厥意不乐，四肢不收，身重，寝汗出憎风，气绝则肉软怯，齿长而垢，发无泽，盛者大再倍于人迎，虚者寸口反小于人迎也。

心主手厥阴心包络之脉起于胸中，出属心包络（诸邪之在心者皆心包络受之）下膈，历络三焦，其支者，循胸出胁，下腋循膈内，入肘中，下臂，行两筋间入掌中，循中指，其支者，别掌中，循小指次指出其端（无名指也）。是动，则病手心热，臂肘变急，腋肿，甚则胸胁支满，心中憺憺大动面赤目黄，喜笑不休，是主脉所生病者（诸脉虽属于心而行太阴肺部脉之运动皆由包络之火故又为阴包所主），烦心心痛（痛引腋胁而欲欬）掌中热（脉起心胸入掌中也）盛者寸口大一倍于人迎，虚者寸口反小于人迎也。

三焦手少阳之脉，起于小指次指之端上出两指之间，循手表腕，出臂外两骨间，上贯肘循膈外，上肩，入缺盆，布膻中，散络心包下膈，循属三焦，其支者，从膻中，上出缺盆，上项系耳后，出耳上角，以屈下颊至，其支者，从耳后入耳中，出耳前交颊至目锐眦（三焦有上中下之名其形则一在七节两肾之中所谓上焦如雾中焦如沕下焦如渎者是形容三焦之用非寔有三处也）。是动，则病耳聋，浑浑焮焮而痛，噤肿喉痹（三焦之气通于咽喉不和则痹肿矣）往来寒热，是主气所生病者（三焦为决渎之官水病必由于气也）汗出，目锐眦痛颊痛，耳鸣耳后肩膈肘臂外皆痛，小指次指不用，腹气满，小腹尤坚，不得小便溢则水留即为胀，盛者人迎大一倍于寸口，虚者人迎反小于寸口也。

胆足少阳之脉起于目锐眦上抵头角，下耳后，循颈至肩，上入缺盆，其支者从耳后，入耳中出走耳前，至目锐眦后，其支者，别锐眦，下人迎，合手少阳，抵，下颊车，下颈，合缺盆以下胸中，贯膈，络肝，属胆，循胁里，出气街，遶毛际，横入脾厌中（即脾枢），其直者，从缺盆下腋，循胸，过季胁下合髀厌中，出膝外廉，循足跗，入小指次指之间，其支者，别足跗，入大指间。是动，则病口苦（胆病则液泄故口苦），呕宿汁，善太息（胆鬱则气不舒故善太息），惊惕，心下憺憺恐人将捕之，噤中介介然数唾，心胁痛，不能转侧（足少阳之别贯心循胁里故病则不能转侧），耳无所闻，甚则面有微尘，体无膏泽（胆病则春升之令不行如木之枝叶凋瘁而色枯槁也），足外反热，是为阳厥（病本属火故为阳厥），是主筋所生病者（肝主筋胆为肝之府故亦主之世本作是主骨所生病者误），头角颌痛，目锐眦痛，缺盆中肿痛，腋下肿，马刀挟瘦，汗出振疟（胆居表里之半阴胜则振寒阳胜则汗出故疟），胸胁膝胫踝前诸节皆痛，小指次指不用，少阳终者耳聋，百节尽纵，目系绝

，盛者人迎大一倍于寸口，虚者人迎反小于寸口也。

肝足厥阴之脉，起于大指，上循足跗，上脘内廉，循阴股，环阴器，抵小腹，挟胃，属肝，络胆，上贯膈，布胁肋，循喉咙之后，上入颞颥，连目系，上出额与督脉会于巅，其支者，从目系，下颊里，环唇内，其支者，复从肝，别贯膈，上注肺。是动，则病闭目不欲见，人腰痛不可俛仰（痛上热），丈夫颊疝，妇人少腹肿，甚则咽干面尘脱色，淅淅时寒热，两胁下痛引少腹，上下无常处，淋洩便难，胁痛支满，手足青，面青面青唇黑，是主肝所生病者，胸满呕逆，作酸飧泄狐疝疝，遗溺闭癃，颊肿喉痹（吐脓血），吐血下血（暴涌不止），瘕瘕恶风，浑身酸麻疼痛，四肢满闷，筋痿不能起，阴缩两筋急，转筋足逆冷，胫酸阴痒，盛则善怒忽忽，眩冒（眩运也），而巅疾（巅顶痛也），气逆则头痛耳聋，目赤肿痛，虚则目无所见，耳无所闻，善恐，如人将捕之（善恐如人将捕有三足少阴是肾藏精气虚衰足少阳是胆虚寒涎渍沃足厥阴是肝虚神魂不宁一属精伤一属涎沫一属血虚不可不辨），气绝，则筋急引舌与卵，唇青，盛者寸口大一倍于人迎，虚者寸口反小于人迎也。

奇经

脉有奇常，十二经者常脉也，所见诸症皆平常无奇其奇经八脉交加中外，络绎诸经，所见诸症皆忽起忽伏，脉亦倏去倏来，故谓之奇，旧说以为奇偶之奇，恐非至当，若尔，则不应有阴阳维蹻（音窍平声）之偶矣，所谓督脉督于身后诸阳，任脉任于身前诸阴，冲为诸脉之海，又为血海，阳维维络诸阳，主一身之表，阴维维络诸阴主一身之里，阳蹻得足太阳之别，主一身左右诸阳，阴蹻得足少阴之别，主一身左右诸阴，二蹻皆起跟中，使人蹻捷，带脉横束季肋，约束诸脉，为诸经之别贯，各有专司，盖人身之气血，常行于十二经而后及于八脉，若受邪则先伤八脉。而后传次六经，所以越人譬之沟渠，沟渠满溢，诸经不能复拘也。

督脉起于下极之俞（音殊），并于脊里，上至风府（项中央之脉督脉也名曰风府）入属于脑，阳脉之海也，其络循阴器，合篡间，绕篡后绕臀，至少阴与巨阳中络者合少阴，上股内后廉贯脊属肾，与太阳起于目内眦，上额交巅，上入络脑，还出别下项，循肩膊内，挟脊抵腰中，入循膂络肾，其男子循茎下至篡，与女子等，少腹直上者，贯脐中央，上贯心，入喉，上颐环唇，上系两目之内中央。动苦少腹上冲心而痛，不得前后为冲疝其女子不孕，癃痔遗溺，噎，干卒口噤，背反张，瘕瘕，腰背强痛，不得俛仰，脊强反折及痛，头重不举，大人癫疾，小儿风痫，其脉直上直下而中央浮，或尺寸强，俱直而浮者，督脉也。

任脉起于中极之下，以上毛际，循腹里，上关元，至咽喉，上颐循面，入目络舌，阴脉之海也，同足三阴并行腹里，其浮于外者，出毛际，循关元石门（即丹田）气海，而历三脘，循膻中，至缺盆（缺盆之中任脉也名曰天M1）。动苦少腹绕脐引阴中切痛（入房太过冲督任受伤多此），男子内结七疝，女子带下瘕聚，月事不以时

下，腹皮急，腹中有气如指上抢心，不得俛仰拘急（志欲不遗阴火上乘多此），其脉横寸口，边丸丸紧细而长，或弦，出寸口上鱼际而丸滑者任脉也，冲脉起于少腹之内胞中，为血之海也，其浮于外者，起于气街（即气冲在少腹），并足少阴之经（难经云并足阳明之经以穴考之足阳明挟脐各二寸而下行与冲脉会于宗筋足少阴挟脐五分而上行针经所载冲脉在腹关元等穴皆属少阴非阳明也明矣），挟脐上行，至胸中而散，冲脉任脉，皆起于胞中，上循背里，为经络之海。动苦逆气里急，气上冲咽喉不得息，喘息有音不得卧，腹中刺痛拘急，寒气客于冲脉，则脉不通，故喘动应手，有寒疝痛，则上引胸中也，其脉直上直下而中央牢者，冲脉也，凡人两手脉，浮之俱有阳，沈之即有阴，阴阳皆盛，此冲督之脉也（冲主沈牢督主浮革），冲督为十二经之道路，冲督用事，则十二经不复朝于寸口，其人恍惚痴狂，刺冲督，阳维起于诸阳之会（诸阳皆会于头），主持卫气，其脉发于足太阳外踝，循膝外廉，上髀关，抵少腹，侧循胁肋，斜上肘，会手足太阳阳蹻于臑俞（在背后胛上谷中），上循耳，会督脉于风府，上脑空，下至风池，与诸阳会于头。动苦寒热（阳维为病在表故苦寒热而足太阳少阳始终联附故二经为病苦寒热），腰痛，痛上怫然肿，又腰痛不可以欬，欬则筋缩急，肌肉痹痒皮肤痛，下部不仁，汗出而寒，羊癇倒仆（多发于日），手足相引，甚者不能言，若阳维不能维于阳，则溶溶不能自收持（溶溶缓纵貌），其脉从尺外斜上至寸而浮者，阳维也，阴维起于诸阴之交（诸阴皆交于胸），主持营血，其脉发于足少阴内踝，循股内廉，上行入少腹，会足三阴，上腹里（去腹中行四寸半）循胁，会足厥阴于期门（直乳下一寸半），上胸胁挟咽，与任脉会于颈。动苦心痛（阴维为病在里故苦心痛阴维虽交三阴寔与任脉同归故心痛腹痛多属少阴而兼阴维任脉也）胁满腰痛，甚则悲以恐癲疾失音（多发于夜），肌肉痹痒汗出恶风身洗洗然（洗与洒同），若阴维不能维于阴，则忡然失志，其脉从尺内斜上至寸而沈实者，阴维也。

阳蹻起于跟内，出外踝直上循股外廉，循胁后胛上，行肩膊外，上挟口吻，至目内，上行发际后入风池。动苦缓纵不收，阴缓而阳急（阳蹻脉急当从外踝以上急蹻脉以上缓），腰背痛，羊癇倒仆（多发于日），恶风偏枯，痹体强，目瞋不得瞑其脉寸口左右弹，浮而细绵绵者，阳蹻也。

阴蹻起于然谷之后，上内踝之上，直上循阴股入阴中，上循胸里，入缺盆上出人迎之前，入鼻属目内眦，至咽喉，交贯冲脉。动苦拘急不弛，阳缓而阴急（阴蹻脉急当从内踝以上急外踝以上缓）少腹痛里急，腰痛相引阴中，男子阴疝，女子漏下不止，癲疾寒热（多发于夜），皮肤淫痹，风痉痠痿，目闭不能开，其脉尺内左右弹，沈而细绵绵者，阴蹻也。

带脉起于季肋围身一周，如束带然，与足少阴会于十四椎（自上而下则十四椎自下而上则七节），十二经与奇经七脉，皆上下周流，惟带脉横束如带而冲任二脉循腹胁夹膀胱传流于气冲属于带脉络，于冲脉冲督任三脉，同起而异行，一源而三歧，皆络带脉。动苦腹满腰溶溶若坐水中腰腹纵，如囊水状妇人腰痛少腹痛里急痠痿，

牵引季肋下空软处，月水不调，赤白带下其脉中部左右弹，而横滑者，带脉也。

运气

谚云不读五运六气，检徧方书何济，所以稍涉医理者动以司运为务，曷知天元纪等篇，本非素问：原文，王氏取阴阳大论补入经中，后世以为右圣格言，孰敢非之其实无关于医道也，况论中明言时有常位而气无，必然犹谆谆详论者，不过穷究其理而已纵使胜复有常而政分南北四方有高下之殊，四序有非时之化，百步之内，晴雨不同千里之外寒暄各异，岂可以一定之法，而测非常之变耶，故余仅取司运规例，详释其义，以资顾问，其六元正纪中之某岁某气当见某病，世所最重者，概不采录。

甲巳之岁土运统之乙庚之岁，金运统之丙辛之岁，水运统之，丁壬之岁，木运统之戊癸之岁，火运统之五运之化有常数，主客之运有递代，盖六气之有主客，五运亦有主客，主运皆起于角，以次相生，如木主春令而为角，火主夏令而为征，土主长夏而为宫，金主秋令而为商，水主冬令而为羽，每运得七十三日五刻，与六步主气同，但岁气有阴裼主运分太少假如甲年为阳土，则主运始太角，而生少征太宫少商太羽已为阴土，则主运始少角，而生太征少宫太商少羽，此主运之气，必始于角而终于羽也客运亦一年五步假如甲巳为土运，甲属阳土，甲年则太宫初运，少商为二运，太羽为三运，少角为四运，太征为终运，已属阴土，已年则少宫为初运，太商为二运，少羽为三运，太角为四运，少征为终运，太少相生凡十年一主令而竟天干也，但主运则必始于角两终于羽，客运则以本年中运为初运，以次相生此主运客运之所以有异也。

子午之岁，上见少阴丑未之岁，上见太阴寅卯之岁，上见少阳卯酉之岁，上见阳明辰戌之岁，上见太阳巳亥之岁，上见厥阴。

主气者地气也如厥阴风木主初气，少阴君火为二气，少阳相火为三气太阴湿土为四气，阳明燥金为五气太阳寒水为终气君，相二火相随为一岁之主有常无变，故少阳相火继君火行令，循序而生湿土，所以土阴土居相火之后气之顺行者也客气者，天气也如子午则太阳为初气，厥阴为二气少阴为三气，太阴为四气，少阳为五气，阳明为终气，丑未则厥阴为初气，寅卯则少阴为初气，卯酉则太阴为初气，辰戌则少阳为初气，巳亥则阳明为初气，盖初气皆起地之左间也，而客气之湿土，居相火之前，乃阴阳先后之数也。按六气分正化对化，如子丑寅卯辰巳为对化，对司化令之虚，则胜而有复，午未申酉戌亥为正化，正司化令之实，则胜而不复。

帝曰：胜复之动，时有常乎气有必，岐伯曰：时有常位而气无必也，帝曰：愿闻其道也岐伯曰：初气终三气，天气主之胜之常也，四气尽终气，地气主之，复之常也有胜则复，无胜则否。

帝曰：天地之气何以候之，岐伯曰：天地之气，胜复之作不形于诊也，脉法曰天地之变，无以脉诊此之谓也，帝曰：问气如何，岐伯曰：随气所在，期于左右，帝曰：期之奈何，岐伯曰：从其气则和违其气则病，不当其位者病，迭移其位者病，失守其位者危，尺寸反者死，阴阳交者死先立其年以知其气，左右应见然后乃可以言死生逆顺也。

论言人迎与寸口相应若引绳大小齐等，命曰：平阴之所在，寸口何如，岐伯曰：视岁南北若知矣。

（甲子甲午）南政少阴司天，阳明在泉，则两寸不应。（初气太阳二气厥阴三气少阴四气太阴五气少阳终气阳明）

（己巳己亥）南政厥阴司天，少阳在泉，则右寸不应。（初气阳明二气太阳三气厥阴四气少阴五气太阴终气少阳）

（己丑己未）南政太阴司天，太阳在泉，则左寸不应。（初气厥阴二气少阴三气太阴四气少阳五气阳明终气太阳）

（己卯己酉）南政少阴在泉，阳明司天，则两尺不应。（初气太阴二气少阳三气阳明四气太阳五气厥阴终气少阴）

（甲寅甲申）南政厥阴在泉，少阳司天，则左尺不应。（初气少阴二气太阴三气少阳四气阳明五气太阳终气厥阴）

（甲辰甲戌）南政太阴在泉，太阳司天，则右尺不应。（初气少阳二气阳明三气太阳四气厥阴五气少阴终气太阴）

（丙戌庚壬子午）北政少阴司天，阳明在泉，则两尺不应。（初气太阳二气厥阴三气少阴四气太阴五气少阳终气阳明）

（乙辛丁癸巳亥）北政厥阴司天，少阳在泉，则左尺不应。（初气阳明二气太阳三气厥阴四气少阴五气太阴终气少阴）

（乙辛丁癸丑未）北政太阴司天，太阳在泉，则右尺不应。（初气厥阴二气少阴三气太阴四气少阳五气阳明终气太阳）

（乙辛丁癸卯酉）北政少阴在泉，阳明司天，则两寸不应。（初气太阴二气少阳三气阳明四气太阳五气少阴终气少阴）

（丙戌庚壬寅申）北政厥阴在泉，少阳谷天，则右寸不应。（初气少阴二气太阴三气少阳四气阳明五气太阳终气厥阴）

（丙戌庚壬辰戌）北政太阴在泉，太阳司天，则左寸不应。（初气少阳二气阳明三气太阳四气厥阴五气少阴终气太阴）

诸不应者，反其诊则见矣。

司天在泉四间气者，客气之六步也，凡初气为左间，二气为右间，三气为司天，四气为左间，五气为右间，终气为在泉，故曰司左右者为间气，每气各主一步，又司天主上半年，在泉主下半年，故曰岁半已前，天气主之，岁半以后地气主之。南北政者，即甲己为南政，余为北政是也，谓南政之年，南面行令，其气在南，故寸为上而尺为下，左右俱同，北政之年，北面受令，其气在北，故尺应上而寸应下，是以司天应两尺，在泉应两寸也。脉不应者，指少阴所居之处而言，故曰阴之所在，而三阴以少阴居中，太阴居左，厥阴居右，随南北二政以定上下也，故曰诸不应者，反其诊则见矣，反其诊者，谓南北相反而诊之，北政之年，少阴司天，则两尺不应，太阴司天，则少阴在右，所以右尺不应，厥阴司天，则少阴在左，所以左尺不应，南政之年，少阴在泉，则两尺不应，太阴在泉，则少阴在右，所以右尺不应，厥阴在泉，则少阴在左所以左尺不应也。

厥阴司天，其化以风，少阴司天，其化以热，太阴司天，其化以湿，少阳司天，其化以火，阳明司天，其化以燥，太阳司天，其化以寒，以所临藏位，命其病者也。

厥阴之至其脉弦，少阴之至其脉钩太阴之至其脉沈，少阳之至大而浮，阳明之至短而濇，太阳之至大而长，至而和则平，至而甚则病，至而反者病，至而不至者病，未至而至者病，阴阳易者病死。

大寒至春分为初之气，厥阴风水主令其脉乍大乍小，乍短乍长。春分至小满为二之气，少阴君火主令，其脉浮大而短。小满至大暑为三之气，少阳相火主令，其脉洪大而长。大暑至秋分为四之气，太阴湿土主令，其脉缓大山长。秋分至小雪为五之气，阳明燥金主令，其脉紧细而微。小雪至大寒为终之气，太阳寒水主令，其脉沈短而敦。

方宜

医以天下民生为已任，当具通天下之才识，非胶执一己之见，固守一隅之法者之所能管窥也，吾吴为五方杂处之地，南北士商云集，苟未明水土之刚柔，风气之强弱，资D9之偏胜，而欲妄治遐方游客，或客游他地治病，则与圆枘方凿何异哉，况客游治病，与治旂客之病，其法悬殊，设游艺他方，惟随其地之风土，若遐方流寓，

又须详彼处之资D9，此地之风土，方始合宜，故经有一病而治各不同，地势使然之语，圆机之士，能于是触类旁推，匪特行之方内，虽广诸异域，可以无间然矣。

东方发育之地，土膏气泽，冬鲜凛冽之寒，四序常行春令，俗尚华而少实，病多热中疎理，而无真中风寒，即使外感内伤，总由理疎邪入，中热气伤所致，详热气中疎理四字，已道尽东方元气病情矣，按吴越皆居东方，而江南元气最薄，病则虚热居多，温顺为宜，苦寒切禁，江北则接壤东鲁，其间元气，虚实兼半寒热补泻随宜，江左地气稍厚，略觉奈病胜药，江右则南近闽粤，内连荆楚，得火上之余气，是以不任温补，然亦不胜酸攻，惟清理中外为宜，大抵东方所D9孱弱，宜宗东垣复庵，而丹溪则宜于江之左右，新甫则偏宜江南，若河间戴人之法，非西北资D9刚厚人断断不可效用也。

南方长养之处，阳盛气泄，穷冬恒服絺衣，四序常行夏令，缪仲淳云：阳燠既泄，则使人本气不坚，民虽致理，而雾露不时蒸发，人触之者，未免多挛痹之患，其稍不致者，则有瘴疔之虞矣，即居恒无病之人，气多上壅而少下降，以故时嚼槟榔，唾皆赤色是以土人有天蚩不下雪，地蚩不落叶，人蚩日吐血之语，其患瘴疔之症，亦发热头胀胸满呕逆，与伤寒相似但治法与伤寒迥异感之轻者，但食槟榔祛散滞气，胸膈宽舒即愈，重则必需芳香正气之剂开发中气为主，若误行表散则阳气愈泄，表气愈虚，邪弃虚扰，发热愈无抵止矣，凡岭南烟瘴之乡，天晴亦多雾露，罕见日色，岚湿与晦暖交升，蛊毒与鬼蜮并虐，感之必内应湿土，中气先伤，故瘴疔之治，与疫疔仿佛，但广粤正向离明，黔滇斜临坤位，咸多湿热气蒸，闽虽未踰梅岭，已得南方气候，水土皆泄而不收，纵有大头瘟虾蟆瘟等疫，悉属阳邪其毒亦易解散非若北方之地脉坚厚，阴邪积而不发，发则旦发夕死，如疙瘩瘟黑骨瘟等症之暴绝也。

西方收引之界，金沙之域，地高土厚，多风四序，常行秋令，其俗刚毅而不阿，其民不衣而褐荐，华实而脂肥，则知西域D9赋与关西无异，然蜀直指兑泽元气与人文俱厚，有峡三倒流之势，关西正当北斗，地气与人文俱伟，有剑倚崆峒之概，以其材质俱D0表里俱充故邪弗能伤之也，惟是内气壅盛，故治宜毒药，如西域倒仓，子和漏下等法，观内经病生于内，治宜毒药，一方风气主治，了无余蕴矣。

北方闭藏之境，阴盛气沈，春夏草木不生，四序常行冬令，民D9坎水而生故常以水为事，且性好乳食，所以藏寒生满，则内因之症也，至于乐野处，冒风沙历冰雪，其寒可以断指裂肤，反不言伤寒之病者，以致理惯拒严寒，虽有大风苛毒，弗之能害即得伤之，其气坚固不能便入于里，故感之轻者，但需鸡汤面食，助其肝，实其胃自能祛邪作汗，若伤之重者，竟行辛热表散，里气壅滞便与苦寒峻攻，非若东南之元气瘠薄，投剂稍重，便致变症蜂起也，惟是肾气素劳之人，邪弃虚入而为卒中患者是必峻用温补然煤火内蕴，须兼苦降之味，以防火炎竭泽之虞，盖煤为水土之精，人食其E1长气于阴中之阳，所以力能壮火伤阴，可不预为调制乎，复有车尘

马足之劳，不内外因之候，又宜导气和中，不宜升发温补，若以南方内伤劳倦例治之，愈益其壅满矣，然燕与晋鲁皆北，燕则左河右岱，地气最厚，鲁虽偏居良土，风气已北晋抵关西，惟一河之限元气之充实，大率相类，其治亦相类。

中央正中之位，水土平湿万类各得其和，四序各行其令，民虽食杂不劳，而多痿厥寒热者，良由水土平湿使然，以其食杂不劳，元气平治所伤亦轻，故导引按蹻，便可愈之不必毒药内治针石外治也，然此言平气所致，若伤寒卒病，其可拘于此例乎，盖中央虽居正位，四维八埏之气，皆得干之所以仲景有寒热补泻之不同，立法皆随病制宜，以为天下万世则，而于中州更宜，按仲景为南阳圣医，吏治长沙皆不离洛楚之地夫洛与楚，皆居中央而楚则交界江右，稍偏于南所以一切温补，皆为掣肘，以其地气浑厚，民多温饱，是以不须补益，洛则水土平湿，平湿则气柔气，柔则受补矣，经言：治所以异而病皆愈者，得病之情，知治之大体也。

石顽老人诊宗三昧序

夫人身犹天地也，天地失和，则宇宙为殃，人身失和，则四体为病，所以主之者，在天地稚君，人身惟心，故心为君主，君失其治，则宇宙灾困，心失其养，则四体疾疢，其弭灾困，惟相之调和M2理，治疾疢，亦惟医之调和M2理，故曰不为良相，即为良医，然相失政则残民，医误治则残命，相之与医，岂易言哉，盖天地之九州岛，天地之九野，人身为九藏，又石为之骨，土为之肉，江河为血液，草木为毫发，道路为脉络，风为气，雨为汗，雷为声，凡此则人身无不合于天地者，天地有灾，莫不载闻道路，人身有疾，莫不见诸脉络，故治疾必要于测脉也，予当治邑江城，署多奇疾，遣识张路玉先生，其察脉辨病症，补虚祛实，应如鼓桴，因问之曰：人身脉络众多，取病何独决两腕，云：两寸为心肺之关隘，一身之所主，犹君相之都邑，天下之总会，故天下灾无不肇于都邑，一身病无不形于两腕也，人之六脉，犹近之六部，天下刑赏与罚，莫不由此，然其昂藏磊落，风论卓绝，B0越常识，其能运天时于指掌，决生死于须臾，又非泛泛可及知，无经天纬地之才者，不可与言医也，以之为良相，又谁曰不可，后以脉学一书，索序曰诊宗三昧，予虽不知医，观其论天地阴阳之常变，出川草木之脉理，灵机独发，无不贯通造化，予所云为良相信然，时因取召赴都，碌碌未遑诺就今于职务瘁劳，嗽疾复生，思良医不可得，因述数语邮寄，以志仰云。康熙己巳即墨通家弟郭琇譔

诊宗三昧目录

宗旨

医学

色脉

脉位

脉象

经络

师传

浮，沈，迟，数，滑，濇，虚，实，弦，缓，洪，微，紧，弱，长，短，大，小，
芤，濡，动，伏，细，疾，牢，革，促，结，代，散，清，浊

口问

问三焦命门脉，问神门脉，问冲阳太溪脉，问反关脉，问人迎气口脉，问初诊久按不（同说），问病同胀异等治，问节庵从脉从症等治，问内经脉有阴阳说，问长沙高章纲牒卑损脉法，问辨声色法，问脉沈温补转剧治法

逆顺

异脉

妇人

婴儿

石顽老人诊宗三昧

长洲张登诞先编次

宗旨

石顽老人，趺坐绳床，有弟子进问医学宗旨，老人恍然叹曰：崇古圣人立一善政，后世辄增一害民之事，只今伪君子之风，良由文字夭生民之患，咎始神丹，吾尝纵观万类，无物不有成败之机，人禀造化之灵不能超乎万类，地水火风，常交战于一体，虽有志者，不无疾疢之危，一有小剧，即从事于医药往往贪生失生，深可哀悯，逮如下愚无知，罔悟前车已覆之鉴，缘是不得正命者，日以继踵，若夫未达不敢尝者，自古及今，能几人哉，当世之名于医者，有三种大病，一种藉世医之名，绝志圣学，株守家传，矜言削伐，不顾本元斯皆未闻大道之故，一种弃儒业医，徒务博览，不卒师传，专于温补，极诋苦寒，斯皆不达权变之故，一种欺世盗名，借口

给之便佞，赖声气之交通，高车衎衎，曲为趋时，日杀无辜，以充食客之肠，竭厥心力，以博妻孥之笑，斯皆地狱种子，沈沦业识之故，此三种病，非药可除，吾今伏医王力运六通智开个教外别传，普救天扎，底微妙法门，汝等若有疑团，向前执问，但须迅扫胸中积染，向白地上从新点出个指下工夫，若能顿然超悟，立正宗风，何虑不直接南阳先师一脉乎。

医学

或问医药之书，汗牛充栋，当以何者为先，答曰：医林著作日繁，葛藤益甚，而识见愈卑，总皆窃取狐涎，搜罗剩语，从无片言发自己意者，吾故曰：教外别传，不欲汝等堕诸坑塹也，近来留心斯道者，纷如泥沙，求其具夙根者，卒不可得，是不得不稍借文字，以为接引之阶梯，但此夺权造化，负荷非轻，即有真心向道，以天下生民为已任者，入门宗E2不慎，未免流入异端，向后虽遇明师检点头绪决不能清，头绪不清，审症必不能确，审症不确，下手亦无辣气，安望其有转日回天之功乎，有志之士，务在先明灵枢素问，伤寒论金匱要略四经，为医门之正法眼藏，然皆义深词简，质奥难明，读者不可随人作解，以障己之悟门，或遇不能透脱处，撞着银山铁壁相似，于挨不入处，忽地顶门迸裂，自然洞若观火然后看古人注释，却不仍其纰缪直待胸中学识坚固，随意综览诸家，无往不受其益，即如刘张李朱，世推四大家，观其立言之旨，各执一偏河间之学，悉从岐伯病机十九条入首，故其立方，一于治热，戴人专于拨乱除邪上起见，故汗吐下法，信手合辙，要知二子道行西北，地气使然之故，不可强也，东垣志在培土以发育万物，故常从事乎升阳，丹溪全以清理形气为本，故独长于湿热，二子之道虽皆行于东南，然一当颠沛，一当安和，补泻升沈之理，不可不随时迁变也，在学识粗浅者，不能委悉其全，即当因材施教，指与个快捷方式工夫，一般到家，惟脉学之言，自古至今，曾无一家可宗者，某不自揣，窃谓颇得其髓，惜不能力正习俗之讹，咸归先圣一脉，是不能无愧于心，或云：夫子之道，昭乎日月，而尚有不辨明暗者，何也，曰：是某之机缘不契，亦众生之机缘不契也，教弃所谓时节因缘，非可强也，吾闻佛法无边，能度一切有情，而不能化导无缘，岂区区智力，能充彻法界，使悉归心至教，乎今观游时师之门者，一皆羊质虎皮，问其所学，无非伪诀药性等书，家弦户诵，不过如斯，今古相仍，莫知其谬，盖伪诀出自高阳，生昔戴起宗尝着刊误以辟其妄，而聋瞶之师，犹视以为资生至宝者，以其编成，俚语，易于习诵也，药性赋不知出自何人，乃妄诬东垣所著，尤为发指，吾愿祖龙有知，凡有二书处，请用从火，造福无涯矣，至于王氏脉经，全氏太素多拾经语，溷厕杂毒于中，偶一展卷，不无金屑入眼之憾，他如紫虚四诊，丹溪指掌，婴童枢要，濒湖脉学，士材正眼等，靡不称誉于时，要皆刻舟求剑，按图索骥之说，迨夫得心应手之妙，如风中鸟迹，水上月痕，苟非智慧辨才，乌能测识其微于一毫端上哉，只今诸方云集，向某问个脉法大义，吾当以三昧水，涤除尘见，显示个头头是道，底活法悟门，不涉纤微陈迹，便可言下荐机，学者毋以余言为尚异也，要知冰即是水，别传之义，原不外乎轩岐仲景，祖祖相承之心印，但较当世所言七表八里之法，趋舍殊途，宗旨迥乎角立耳。

色脉

或问人身四支百骸，藏府经络诸病，皆取决于三部，究竟脉属何类，动是何气，而诊之之法，一如古圣所言否，答言，脉本营气所主，为气血之源，故能出入藏府，交通经络，行于肯綮之间，随气上下鼓动，其指下发现之端，或清或浊，或小或大，或偏小偏大，虽言禀赋不同，实由性灵所发，非可一途而取，纵古圣曲为摩写形象，以推阴阳寒热之机，然亦不过立法大义，明眼之士，贵在圆机活泼，比类而推，何难见垣一方，人盖脉之显著虽微，而所关最巨，其受气在混沌未分之先，流行在胚胎方结之际，天地万物，莫不皆然，如璇玑玉衡，江海潮汐，此天地脉运之常也，白虹贯日，洪水滔天，此天地脉络之病也，穷冬闪电，九夏雹冰，此天地气交之乱也，天愁雨血，地震生毛，此天地非常之变也，至于夏暑冬寒，南暄北冽，乃天地阴阳之偏，人在气交之中，脉象岂能无异，时值天地之变，诊切安得不殊，试观草木无心，其皮干茎叶，皆有脉络贯通，以行津液，顽石无知，亦中怀脉理，以通山泽之气，适当亢燥阴霖，严寒酷暑，则木石皆为变色，况于人乎，姑以脉之常度言之，其始从中焦，循肺一经而之三部，由中达外，为身中第一处动脉，较诸他处不同，古人虽有浮沈滑濇等辩论之法，然究其源，有形之脉，乃水谷之精所布，禀乎地也，其鼓运之象，是无形之气所激，禀乎天也，而交通天地之气，和合阴阳生生不息之机，此则禀乎气交也，况此气血之属，原不可以方圆端倪，即如人之面目，虽五官无异，及细察之，千万人中，从未有一雷同者，经脉别论云：诊脉之道，观人勇怯，骨肉皮肤，能知其情，以为诊法，故上古使僦贷季，理色脉而通神明，夫色者神气之所发，脉者血气之所凭，是以能合色脉，万举万全，得其旨，则心目昭如日月，洵非下士可得而拟议焉，阴阳应象论言，善诊者，察色按脉，先别阴阳，审清浊而知道部分，视喘息，听声音，而知病所苦，观权冲规矩，而知病所主，按尺寸浮沈滑濇，而知病所生，以治，则不失矣，此即能合色脉，万举万全之互词，然其所重，尤在适其性情，故诊不知五过四失，终未免为粗工也，迩来病家亦有三般过失，一者匿其病情，令猜以验医之工拙，一者有隐蔽难言之病，则巧为饰词，以瞒医师，一者未诊先告以故，使医溺于成说，略不加详，虽老成名宿，未免反费推敲，多有自认错谬，喻之不省者，苟非默运内照，鲜不因误致误也，坐次一人问曰：夫子每云能合色脉，万举万全，设有深闺窈窕，密护屏障，不能望见颜色，又当何如，曰：是何言之不聪也，尼父有云：举一隅，不以三隅反，但须验其手腕之色泽苍白肥脊，已见一斑，至若肌之滑濇，理之疎密，肉之坚软，筋之粗细，骨之大小，爪之刚柔，指之肥瘦，掌之厚薄，身之寒热，及乎动静之安危，气息之微盛，更合之以脉，参之以症，则气血之虚实，情性之刚柔，形体之劳逸，服食之精粗，病苦之顺逆，皆了然心目矣，又问五色之应五藏，愚所共知，余皆学者未谙，愿卒闻之，以启蒙昧曰：某所谓色脉者，仓公五色诊也，乃王机不刊之秘，知者绝罕，其间奥妙，全在资禀色泽，以参脉症，如影随形守一勿失，灵枢所谓粗守，形上守义者，即此义也，夫神者色也，形者质也，假令黄属脾胃，若黄而肥盛，胃中有痰湿也，黄而枯癯，胃中有火也，黄而色淡，胃本虚也，黄而色黯，津液久耗也，黄为中央之色，其虚寔寒热之机，又当以饮食便溺消息之，色白属肺，白而淖

泽，肺胃之充也，肥白而按之绵软，气虚有痰也，白而消瘦，爪甲鲜赤，气虚有火也，白而夭然不泽，爪甲色淡，肺胃虚寒也，白而微青，或臂多青脉，气虚不能统血也，若兼爪甲色青，则为虚寒之症矣，白为气虚之象，纵有失血发热，皆为虚火，断无寔热之理，苍黑属肝与肾，苍而理粗，筋骨劳勩也，苍而枯槁，营血之涸也，黑而肥泽，骨髓之充也黑而瘦削，阴火内戕也，苍黑为下焦气旺，虽犯客寒，亦必蕴为邪热，绝无虚寒之候也，赤属心，主三焦，深赤色坚，素禀多火也，亦而坚，营血之充也，微赤而鲜，气虚有火也，赤而索泽，血虚火旺也，赤为火炎之色，祇虑津枯血竭，亦无虚寒之患，大抵火形人，从未有肥盛多湿者，即有痰嗽，亦燥气耳若夫肌之滑濇，以征津液之盛衰，理之疎密，以征营卫之强弱，肉之坚软，以征胃气之虚实，筋之粗细，以征肝血之充馁，骨之大小以征肾气之勇怯爪之刚柔，以征胆液之淳清，指之肥瘦以征经气之荣枯，掌之厚薄，以征藏气之丰歉尺之寒热，以征表里之阴阳论疾诊尺云：尺肤热甚，脉盛燥者，病温也，其脉盛而滑者，病且出也，尺肤寒，其脉小者，泄少气斯皆千古秘密一旦豁然，询是临机应用信手拈来，头头是道底第一义，稔须着眼。

脉位

或问古人以三部分别藏府，而大小二肠之脉，或隶之于两寸，或隶之于两尺，未审孰是孰非，愿示一定之理，以解学人之惑，答曰：皆是也，皆非也，似是而非者也，缘经无显论，所以拟议无凭，要知两手三部，咸非藏府定位，不过假道以行诸经之气耳，观灵枢经脉，虽各有起止，各有支别，而实一气相通，故特借手太阴一经之动脉，以候五藏六府十二经之有余不足，其经虽属于肺，实为胃气所主以藏府诸气，靡不本之于胃也，五藏别经云：气口何以独为五藏主，胃者水谷之海，六府之大源也，五味入口，藏于胃，以养五藏气，气口亦太阴也，是以五藏六府之气，皆出于胃，变见于气口，经脉别论云：食气入胃，经气归于肺，肺朝百脉，气归于权衡，权衡以平，气口成寸，以决死生，营卫生会云：人食气于谷，谷入于胃，以传于肺，五藏六府，皆以受气，其清者为营，浊者为卫，营行脉中，卫行脉外，即此三段经文，可以默会其微矣，或言两手六部，既非藏府脉位，何脉要精微论中，有逐部推之之法耶，曰：此即所谓假道以行诸经之气耳，吴草庐曰：医者以寸关尺，辄名之曰此心脉，此肺脉，此脾脉，此肝脉，此肾脉者，非也，五藏六府，凡十二经，两寸关尺，皆手太阴之一脉也，分其部位，以候他藏之气耳，脉行始于肺，终于肝，而复会于肺，肺为出气之门户，故名气口，而为六脉之大会，以占一身焉，李濒湖曰：两手六部，皆肺之经脉，特取以候五藏六府之气耳，非五藏六府所居之处也，即内经所指藏府部位，乃是因五行之气而推，火旺于南，故心居左寸，木旺于东，故肝居左关，金旺于西，故肺居右寸，土旺于中，而寄位西南，故脾胃居于右关，水旺于北，故居两尺，人面南司天地之化，则左尺为东北也，东北为天地始生之界，人在胎息之中，则两肾先生，以故肾曰先天，在五行则天一生水，水性东行膀胱为水注之器，肾司北方之令，又居下部，则其气化，从此而推也宜矣，然肾本有二，同居七节左右，右者独非肾乎，独不主精气乎，独不司闭蛰封藏之令乎，

盖人身同乎造物，凡呼吸运动，禀乎干健，藏府躯壳，合于坤舆，以分野言，则肾当箕尾燕异之界，其地风高土厚，水都潜行地中，结成煤火，以司腐熟之权，人应其气，则三交之火，从此交通，况三焦鼎峙两肾之间，以应地运而右转，是虽右尺偏属相火，为生人生物之源，因有命门之号，其实两肾皆有水火，原无分于彼此，以故岐伯于寸关二部，俱分左右，尺独不分者，一皆主乎肾也，肾为先天一气之始，故首言尺内两傍，则季胁也，尺外以候肾，尺里以候腹，腹者大小二肠在其中矣，膀胱亦在其中矣，以经气言之，平居无病之时，则二肠之气，未尝不随经而之寸口也，以病脉言之，则二肠司传化之任，病则气化不顺，而为留滞，又必验之于尺矣，曷观长沙论中，凡正阳明府症，必尺中有力，方用承气，此非尺里以候腹之一验乎，吾故曰皆是也，皆非也，似是而非者也，盖尺外者，尺脉之前半部也，尺里者，尺脉之后半部也，前以候阳，后以候阴，人身背为阳，肾附于背，故外以候肾，腹为阴，故里以候腹也，东方生木，木应肝而藏于左，故借左关以候肝胆之气，土居中位，而旺于四季，独以长夏湿土气蒸之时，为之正令，故经以之分隶右关，所谓中附上左外以候肝，内以候鬲，右外以候胃，内以候脾鬲者，鬲膜之谓，中焦所主，胆在中矣，中附上者，附尺之上而居于中即关脉也，肝为阴中之阳藏，亦附近于背，故借左关之外以候肝，内以候鬲，右关之前以候胃，后以候脾，脾胃皆中州之官，以藏府言则胃为阳，脾为阴，故外以候胃，内以候脾也，火生于木，而应乎心合乎脉，谓之牡藏牡者阳也左为阳寸为阳中之阳，故宜候之左寸，金生于土而应乎肺，与胃一气贯通，而主西方金气，故经以之候于右寸，所云上附上右外以候肺内以候胸中，左外以候心，内以候膻中，膻中者，心主之宫城，胞络之别名，胸中者，鬲膜之上皆是也，上附上者，言上而又上则寸口也，五藏之位，惟肺最高，故右寸之前以候肺，后以候胸中，心为虚灵之藏，而为君主之火，性喜上炎，又喜附木而燔，然其行令，皆属胞络，故左寸之前以候心，后以候膻中气也，详本篇六部，但言五藏不及六府，而独不遗其胃者，以经络五藏，皆禀气于胃，五藏之本也，藏气不能自致于手太阴，必因胃气，乃至手太阴也，原夫两手六部，虽皆肺金之一脉，而胃气寔为之总司，足阳明一经，与诸经经交贯为后天气血之本源即先天之气，亦必从此而化每见阴虚血耗之人日服六味四物，不得阳生之力，则阴无由而长也，或问六部皆属肺经，皆生胃气，以推藏府之病，敬闻命矣，而灵枢十二经，独以人迎寸口言者，何也曰：此辨别藏府诸经之盛衰，及外内诸邪之纲主也，夫寸口即是气口，又谓脉口，以配人迎，昔人所谓关前一分，人命之主，即此脉也，复问其后诸经之脉，又以三倍再倍一倍言者，此又何耶曰：三阴三阳之谓也，逆其旨，则手足太阴，谓之三阴，故盛者寸口大三倍于人迎手足少阴，谓之二阴，故盛者寸口大再倍于人迎，手足厥阴，谓之一阴，故盛者寸口大一倍于人迎，在阳经则不然，其手足阳明，谓之二阳，以二经所主津液最盛，故盛者人迎大三倍，手足太阳谓之三阳，以二经所主津液差少，故盛者人迎祇大再倍，手足少阳谓之一阳，以二经所主津液最少，故盛者人迎仅大一倍也或言人迎主表气口主里，此言人迎主府，气口主藏者何也，盖人迎主表，气口主里是主邪气而言，人迎盛坚者伤于寒，气口盛坚者伤于食也，此言人迎主府，气口主藏，是指经气而言，原未尝指府藏也，以人迎主在津液津血灌注六府，而偏丽于左气口主在神气，神气鍾于五藏而偏丽于右

，此阴阳血气流行之道，以上下言之，则寸为阳，尺为阴以左右言之，则人迎为阳，气口为阴须知人之血气，与流水无异，水性东行，若得风涌，即随之而逝，不可拘于南北也，人身经脉营运亦然，虽血喜归肝，气喜行脾，而有左右之属，若得其火即随之而上炎，得其风，则随之而外扰，变幻之机，无所不至，岂复拘于部分哉。

脉象

或问人身脉位，既无一定之法，但以指下几微之象，推原藏府诸病，益切茫无畔岸，愿得显示至教，开我迷云，答曰：汝等今日各从何来，或言某从西南平陆而来，或言某由西北渡水而来，或言某于东南仄径遇师于不期之中，因谕之曰：良由汝等识吾居处，得吾形神，故不拘所从，皆可邂逅，否则覩面错过矣，故欲识五藏诸病，须明五藏脉形，假如肝得乙木春升之令而生，其脉若草木初生，指下软若招招，故谓之弦，然必和滑而缓，是为胃气，为肝之平脉，若弦寔而滑，如循长竿，弦多胃少之脉也，若弦而急强，按之益劲，但弦无胃气也，加以发热，指下洪盛，则木槁火炎而自焚矣，所谓火生于木，焚木者原不出乎火也，若微弦而浮，或略带数，又为甲木之象矣，若弦脉见于人迎，肝气自旺也，设反见于气口，又为土败木贼之兆，或左关虽弦，而指下小弱不振，是土衰木萎之象，法当培土荣木，设投伐肝之剂，则脾土愈困矣，若弦见于一二部，或一手偏弦，犹为可治，若六脉皆弦，而少神气，为邪气混一不分之兆，灵枢有云：人迎与寸口气大小等者，病难已，气者，脉气也，凡脉得纯藏之气，左右六部皆然者，俱不治也，或肝病症剧，六部绝无弦脉，是脉不应病，亦不可治，举此以为诸脉之例，不独肝藏为然也，心属丙丁而应乎夏，其脉若火之燃薪，指下累累微曲而濡，故谓之钩，然必虚滑流利，是为胃气，为心之平脉，若喘喘连属，其中微曲，钩多胃少之脉也，若瞥瞥虚大，前曲后居，但钩无胃气也，若虚大浮洪，或微带数，又为丙火之象，故钩脉见于左寸，包络之火自旺也，或并见于右寸，火乘金位之兆，设关之外微曲，又为中宫有物阻碍之兆也，脾为已土而应于四季，虽稟中央湿土，常兼四气之化而生长万物，故其脉最和缓，指下纤徐而不疾不迟，故谓之缓，然于和缓之中，又当求其软滑，是谓胃气，为脾之平脉，若缓弱无力，指下如循烂绵，缓多胃少之脉也，若缓而不能自还，代阴无胃气也若脉虽徐缓而按之盈实，是胃中宿滞蕴热，若缓而濡滞，指下模糊，按之不前，胃中寒食固结，气道阻塞之故耳，若缓而加之以浮，又为风弃戊土之象矣，设或诸部皆缓，而关部独盛，中宫湿热也，诸部皆缓，寸口独滑，膈上有痰气也，诸部皆缓，两尺独显弦状，岂非肝肾虚寒，不能生土之候乎，肺本辛金，而应秋气，虽主收敛，而合于皮毛，是以不能沈实，但得浮弱之象于皮毛间，指下轻虚，而重按不散，故谓之毛，然必浮弱而滑，是为胃气，为肺之平脉，若但浮不滑，指下濡濡然如循鸡羽，毛多胃少之脉也，昔人以浮濡而短，为肺藏平脉，意谓多气少血，脉不能滑，不知独受营气之先，营行脉中之第一关隘，若肺不伤燥，必无短濡之理，即感秋燥之气，亦肺病耳，非肺气之本燥也，若浮而无力，按之如风吹毛但毛无胃气也，加以关尺细数，喘嗽失血，阴虚阳扰，虽神丹不能复图也，若毛而

微濡，又为庚金气予不足之象矣，若诸部皆毛，寸口独不毛者，阳虚阴浊用事，兼挟痰气于上也，诸部不毛，气口独毛者，胃虚不能纳食，及为泄泻之征也，肾主癸水而应乎冬，脉得收藏之令，而见于筋骨之间，按之沈实，而举指流利，谓之曰石，然必沈濡而滑，是为胃气，乃肾之平脉，若指下形如引葛，按之益坚石多胃少之脉也，若弦细而劲，如循刀刃，按之搏指，但石无胃气也，若按之虽石，举之浮紧，又为太阳壬水受邪之象矣，若诸脉不石，左寸独石者，水气凌心之象，右关独石者，沈寒伤胃之象也，可知五脉之中，必得缓滑之象，乃为胃气，方为平脉，则胃气之验，不独在于右关也，况内经所言，四时之脉，亦不出乎弦钩毛石，是知五藏之气，不出五行，四时之气，亦不出于五行，故其论脉，总不出五行之外也，但当察其五脉之中，必得缓和之气，即是病脉，或反见他藏之脉，是本藏气衰，他藏之气弃之也，每见医守六部之绳墨，以求藏府之虚寔者，是欲候其人，不识声形笑貌，但认其居处之地也，若得其声形笑貌，虽遇之于殊方逆旅，暗室隔垣，未尝错认以为他人也，犹之此经之脉，见于他部，未尝错认以为他经之病也，至于临病察脉，全在活法推求，如诊富贵人之脉，与贫贱者之脉，迥乎不侔，贵显之脉，常清虚流利，富厚之脉，常和滑有神，贱者之脉，常浊壅多滞，贫者之脉，常蹇濡少神，加以劳勩则粗硬倍常，至若先富贵而后贫贱，则营卫枯槁，血气不调，脉必不能流利和滑，久按索然，且富贵之症治，与贫贱之症治，亦截然两途，富贵之人，恒劳心肾，精血内戕，病脉多虚，总有表里客邪，不胜大汗之下，全以顾虑元气为主，略兼和营调胃足矣，一切苦寒伤气，皆在切禁，贫贱之人，藜藿充肠，风霜切体，内外未尝温养，筋骸素惯疲劳，藏府经脉，一皆坚固，即有病苦忧劳，不能便伤神志，一以攻发为主，若参芪桂附等药，咸非是辈所宜，惟先贵后贱，先富后贫之人，素享丰腴，不安粗粝，病则中气先郁，非但药之难应，参芪或不能支，反憎郁抑之患，在所必至，非特富贵之脉症，与贫贱悬殊，即形体之肥瘠，亦是不同，肥盛之人，肌肉丰厚，胃气沈潜，纵受风寒，未得即见表脉，但须辨其声音涕唾，便知有何客邪，设鼻塞声重，涕唾稠黏，风寒所伤也，若虽鼻塞声重，而屡欬痰不即应，极力略之，乃得一线粘痰，甚则咽肿胀者，乃风热也，此是肥人外感第一关键，以肥人肌气充盛，风邪急切难入，因其内多痰湿，故伤热最易，惟是酒客湿热，渐渍于肉理，风邪易伤者有之，否则形盛气虚，色白肉松，肌腠不实之故，不可以此胶执也，瘦人肌肉浅薄，胃气外泄，即发热头痛，脉来浮数，多属于火，但以头之时痛时止，热之忽轻忽重，又为阴虚火扰之候也，惟发热头痛，无问昼夜，不分轻重，人迎浮盛者，方是外感之病，亦有表邪兼挟内火者，虽发热头痛，不分昼夜轻重，而烦渴躁扰，卧寐不宁，皆邪火烁阴之候，虽宜辛凉发散，又当顾虑其阴，独形瘦气虚，面白唇鲜，卫气不固者，最易伤风，却无内火之患矣，矧吾江南之人，元气最薄，脉多不实，且偏属东方，木火最盛，治之稍过，不无热去寒起之虑，而高粱之人，参养柔脆，调适尤难，故善治大江以南病者，不难徧行宇内也，但要识其所禀之刚柔，情性之缓急耳，西北之人，惯拒风寒，素食煤火，外内坚固，所以脉多沈实，一切表里诸邪，不伤则已，伤之必重，非大汗大下，重用峻剂，不能克应，滇粤之人，恒受瘴热，惯食槟榔，表里疎豁，所以脉多微数，按之少实，纵有风寒，只宜清解，不得轻用发散，以表药性皆上升横散，触动瘴气，发热漫无止期，不

至津枯血竭不已也，经云：西北之气散而寒之，东南之气，收而温之，所谓同病异治也，是以他方之人，必问方隅水土，傍观者以为应酬套语，曷知其为察脉审症，用药之大纲，故操司命之权者务宜外息诸缘，内心无喘，向生死机关下个竿头进步工夫，自然不落时人圈绩，当知医门学问，原无深奥难明处但得悉其要领，活法推求，便可一肩担荷，又何必搜罗百氏，博览群书，开凿寻文解义之端，愈滋多岐之惑哉。

经络

或问奇经诸脉，何以异于十二经，而以奇字目之，答曰：夫十二经者经脉之常度也，其源各从藏府而发，虽有梭别，其实一气贯通，曾无间断，其经皆直行上下，故谓之经十五络者，经脉之联属也，其端各从经脉而发头绪散漫不一，非如经脉之如环无端也，以其斜行左右遂名曰络，奇经为诸经之别贯经经自为起止各司前后上下之阴阳血气，不主一藏一府，随邪气之满溢而为病，故脉之发现诸部皆乖戾不和是古圣以奇字称之，非若经气之当升，络气之常降也，所以者何，盖缘经起中焦，恒随营气下行极而上，故其诊在寸络起下焦恒附营气上行极而下故，其诊在尺虽经有明谕，而世罕究其旨者，通评虚寔论云：经络皆寔，寸脉急而尺缓言经中所受之邪，既随经而盛于上，络气虽实，当无下陷之邪，则尺部不为之热满矣，次云络气不足，经气有余，脉口热满尺，部寒濇，有余则热满，是指邪气而言，非经气之充寔也，不足则寒濇，络气本虚之验也，又云经虚络满者，尺部热满脉口寒濇，络满亦指邪气，以经中之邪陷于络，故尺部为之热满也，按金匱云极寒伤经，极热伤络，盖经受寒邪而发热，络受热邪而传次，溢入于奇经矣，然经络之脉，虽各有疆界，各有司属，各有交会，而实混然一区，全在大气鼓运，营血灌注，方无偏胜竭绝之虞，经云：气主煦之，血主濡之，又言邪在气，气为是动邪在血，血为所生病，是以十二经脉，各以分隶气血之所属也，其经络二字，方书中靡不并举，曷知络脉皆不离本经之部分虽十二经外，别有阴络阳络脾之大络三种，而为病亦不殊本经之血气也，盖络脉之病，虽略亚于本经，然邪伏幽隐，气难升散，不似经脉之循经上下，易于开发也，而奇经又为十二经之约束，若藏气安和，经脉调畅八脉之形，无从而见也，即经络受邪，不至满溢，与奇经亦无预也，惟是经络之邪，热满，势必溢入于奇经，所以越人有沟渠满溢，诸经不能复拘之喻，试推伤寒之邪，皆从阳维而传次三阳，从阴维而传次三阴，未尝循十二经次第也，或有藏气内结，邪气外溢竟从奇经受病者有之，复问八脉之形象与病苦，可得闻乎答曰：在经有之吾尝考诸经中，言冲脉直上直下而中央牢，病苦逆气里急，督脉直上直下而中央浮，病苦脊强不得俛仰，任脉横寸口，边丸丸紧细而长病苦少腹切痛，男子内结七疝，女子带下瘕聚，阳维尺外斜上至寸而浮，病苦寒热，溶溶不能自收持，阴维尺内斜上至寸而沈病苦心痛，怅然失志阳蹻寸口左右弹，浮而细绵绵，病苦阴缓而阳急，阴蹻尺内左右弹，沈而细绵绵，病若阳缓而阴急，带脉中部左右弹而横滑，病苦腹痛，腰溶溶若坐水中，内经所言奇经之脉象如是，凡遇五癰七疝，项瘕背强，发歇不时，外内无定之症刚劲不伦，殊异寻常之脉便于奇经中求之，或问奇经之奇字，昔人咸奇

偶之奇为训未知孰是，因语之曰读书须要自立主见，切必浮漚漚地随人脚跟设泥昔人奇偶之说，不当有阴阳维蹻之配偶也，坐客皆举手称善，请着玉版，以为奇恒之别鉴。

师传（三十二则）

或问诊切之法，何者为宗，答曰诊切之法心空为宗，得其旨言下可了，不得其旨虽徧读五车转增障碍，只如日月，岂不净耶，而盲者不见，是盲之过非日月咎，客云：若尔则古人历陈某脉某病凿凿诸例，将有适于用乎，无适于用乎，答曰：大似向泥人祈祷有时灵应有时不灵应，客云：法法纰缪，安得涤除玄览参五色之诊乎，答曰：除却胸中落索，空空地向已灵上究去，了得浮脉之义，便了得沈脉之义，触类旁通，诸脉皆了无余蕴矣，夫脉学者，大医王之心印非大智慧大辨才难以语此，吾尝疾首生民，不闻炎黄之垂诲，永违仲景之至言，逮后唐进士千金方，直接长沙一脉，又以立法险峻，不易跻攀，乃致造詣日卑，风斯日下，今我不惜广长，开陈圣教，为众生运无尽灯，譬之一灯然百千灯，冥者皆明，明终无尽，无不没宿昔先师垂诲，吾当逐一为汝陈之。

浮脉者，下指即显浮象，按之稍减而不空，举之泛泛而流利，不似虚脉之按之不振，芤脉之寻之中空，濡脉之绵软无力也，浮为经络肌表之应，良由邪袭三阳经中，鼓搏脉气于外，所以应指浮满，在暴病得之，皆为合脉，然必人迎浮盛，乃为确候，若气口反盛，又为痰气逆满之征，否则其人平素右手偏旺之故，有始病不浮，病久而脉反浮者，此中气亏乏，不能内守，反见虚痞之兆，若浮而按之渐衰，不能无假象发见之虞，伤寒以尺寸俱浮为太阳受病，故凡浮脉主病，皆属于表，但须指下有力，即属有余客邪，其太阳本经风寒营卫之辨，全以浮缓浮紧，分别而为处治，其有寸关俱浮，尺中迟弱者，南阳谓之阳浮阴弱，营气不足，血少之故，见太阳一经，咸以浮为本脉，一部不逮，虚实悬殊，亦有六脉浮迟，而表热里寒，下利清谷者，虽始病有热，可验太阳，其治与少阴之虚阳发露不异，又有下后仍浮，或兼促兼弦兼紧兼数之类，总由表邪未尽，乃有结胸咽痛，胁急头疼之变端，详结胸藏结及痞之症，皆为下早表邪内陷所致，究其脉虽变异，必有一部见浮，死生虚寔之机，在关上沈细紧小之甚与不甚耳，惟阳明府热攻脾，脉虽浮大，心下反鞭者，急需下之，所谓从症不从脉也，其在三阴，都无浮脉，惟阴尽复阳，厥愈足温而脉浮者，皆为愈症，故太阴例有手足温，身体重而脉浮者，少阴例有阳微脉浮者，厥阴例有脉浮为欲愈，不浮为未愈者，须知阳病浮迟兼见里症，合从阴治，阴病脉浮，症显阳回，合从阳治，几微消息，当不越于圣度也，近世陶尚文浮中沈三法，举世共推，虽卓立已见，究其所云，不论脉之浮沈迟数，但以按之无力，重按全无者，便是阴症，曷知按之无力者，乃虚散之脉，与浮何预哉，逮夫杂症之脉浮者，皆为风象，如类中风痲之脉浮，喘咳痞满之脉浮，烦暝衄血之脉浮，风水皮水之脉浮，泄泻脓血之脉浮，如上种种，或与症相符，或与症乖互，咸可治疗，虽内经有肠漚下白沫，脉沈则生脉浮则死之例，然风木乘脾之症，初起多有浮脉，可用升散而愈者

，当知阴病见阳脉者生，非若沈细虚微之反见狂妄躁渴，难于图治也。

沈脉者，轻取不应，重按乃得，举指减小，更按益力，纵之不即应指，不似实脉之举指逼逼，伏脉之匿于筋下也，沈为藏府筋骨之应，盖缘阳气式微，不能统运营气于表，脉显阴象而沈者，则按久愈微，若阳气郁伏，不能浮应卫气于外，脉反伏匿而沈者，则按久不衰，阴阳寒热之机，在乎纤微之辨，伤寒以尺寸俱沈为少阴受病，故于沈脉之中，辨别阴阳，为第一关捩，若始病不发热，无头痛，而手足厥冷脉沈者，此直中阴经之寒症也，若先曾发热头痛，心绪不宁，至五七日后，而变手足厥冷，躁不得寐而脉沈者此厥深热深，阳邪陷阴之热症也，亦有始本阳邪，因汗下太过，而脉变沈迟，此热去寒起之虚症也，有太阳症下早，胸膈痞鞭而关上小细沈紧者，此表邪内陷，阳分之结胸也，若能食自利，乃阳邪下陷，阴分之藏结矣，有少阴病自利清水，口干腹胀不大便而脉沈者，此热邪陷于少阴也，有少阴病，始得之，反发热脉沈者，麻黄附子细辛汤温之，是少阴而兼太阳，即所谓之两感也，此与病发热头痛，脉反沈，身体痛，当温之宜四逆汤之法，似是而是寔不同也，有寸关俱浮，而尺中沈迟者，此阳症夹阴之脉也，若沈而实大数盛，动滑有力，皆为阳邪内伏沈而迟细微弱，弦濇少力皆属阴寒无疑，有冬时伏邪，发于春夏，烦热躁渴，而反脉沈足冷，此少阴无气，毒邪不能发出阳分，下虚死症也，凡伤寒温热时疫感冒得汗后脉沈，皆为愈证非阳病阴脉之比，有内外有热，而脉沈伏，不数不洪，指下濇小急疾无论伤寒杂病，发于何时皆为伏热，不可以其脉之沈伏，而误认阴寒也，至如肠澼自利而脉沈，寒疝积瘕而脉沈历节痛痹而脉沈，伏痰留饮而脉沈，胸腹结痛而脉沈，霍乱呕吐而脉沈，郁结气滞而脉沈咸为应病之脉，若反浮大虚濇，或虽沈而弦细坚疾，为胃气告匮，未可轻许以治也，迟脉者，呼吸定息，不及四至而举按皆迟，不似濇脉之参伍不调，缓脉之去来徐缓也，迟为阳气不显，营气自和之象，故昔人皆以隶之虚寒，而人迎主寒湿外袭，气口主积冷内滞，又以浮迟为表寒，沈迟为里寒，迟濇为血病，迟滑为气病，此论固是，然多有热邪内结，寒气外郁，而见气口迟滑作胀者，诎可以脉迟概为之寒，而不究其滑濇之象，虚实之异哉，详仲景有阳明病脉迟，微恶寒而汗出多者，为表未解，脉迟头弦腹满者不可下，有阳明病脉迟有力，汗出不恶寒，身重喘满，潮热便鞭，手足濇然汗出者，为外欲解，可攻其里，又太阳病脉浮，因误下而变迟，膈内拒痛者为结胸，若此皆热邪内结之明验也，当知迟脉虽现表证，亦属藏气不充，不能统摄百骸，所以邪气留连不解，即有腹满而头弦脉迟，阳分之患未除，禁不可下，直待里证悉具，然后下之，圣法昭然，岂不详审慎重乎，迟为阳气失职，胸中大气不能敷布之候，详迟为在藏一语，可不顾虑藏气之病乎。

数脉者，呼吸定息，六至以上，而应指急数，不似滑脉之往来流利，动脉之厥厥动摇，疾脉之过于急疾也，数为阳盛阴亏，热邪流传于经络之象，所以脉道数盛，火性善动而躁急，故伤寒以烦躁脉数者为传，脉静者为不传，有火无火之分也，即经尽欲解，而脉浮数，按之不扎，其人不虚，不战汗出而解，则知数而按之扎者，皆为虚矣，又阳明例云：病人脉数，数为热，当消谷引食，而反吐者，以发汗令阳气

微，膈内虚，脉乃数也，数为客热，不能消谷，胃中虚冷故吐也，又胃反而寸口脉微数者，为胸中冷，又脉阳紧阴数为欲吐，阳浮阴数亦吐，胃反脉数，中气大虚，而见假数之象也，人见脉数，悉以为热，不知亦有胃虚及阴盛拒阳者，若数而浮大，按之无力，寸口脉细者，虚也，经曰：脉至而从，按之不鼓，诸阳皆然，病热而脉数，按之不鼓甚者，乃阴盛拒阳于外而致病，非热也，形症似寒，按之鼓击于指下者，乃阳盛拒阴而生病，非寒也，丹溪云：脉数盛大，按之而濡，外有热症者，名曰中（平声）寒，盖寒留血脉，外症热而脉亦数也，凡乍病脉数，而按之缓者为邪退，久病脉数为阴虚之象，瘦人多火其阴本虚若形充色泽之人脉数，皆痰湿郁滞经络不畅而蕴热，其可贵之于阴乎若无故脉数，必生痈疽如数寔而吐臭痰者为肺痈，数虚而欬涎沫者为肺痿又历考数脉诸例，有云数则烦心者有云滑数心下结热者皆包络火旺而弃君主之位也，有云细数阴虚者，水不制火，真阴亏损也有云数为在府者，阳邪干阳藏气无预也，有云数则为寒者少火气衰壮火食气也，大抵虚劳失血，喘嗽上气多有数脉，但以数大奕弱者为阳虚，细小弦数者为阴虚，非若伤寒衄血之脉浮大为邪伏于经，合用发汗之比，诸凡失血，脉见细小微数无力者为顺，脉数有热，及寔大弦劲急者为逆，若乍疎乍数无问何病，皆不治也。

滑脉者，举之浮紧按之滑石不似寔脉之逼逼应指紧脉之往来劲急，动脉之见于一部，疾脉之过于急疾也，仲景云：翕奄沈，名曰滑滑者紧之浮名也言忽沈忽浮，形容流利之状，无以过之，滑为多血少气之脉，而昔人又以滑大无力，为内伤元气曷知滑脉，虽有浮沈之分，却无无力之象，盖血由气生，若果气虚，则鼓动之力先微，脉何由而滑耶，惟是气虚不能统摄阴火而血热脉滑者有之，尝考诸内经有脉滑曰病风，缓而滑曰热中脉浮而滑曰新病，脉盛滑坚者曰病在外，脉弱以滑，是为胃气，滑者阴气有余也，则知滑脉之病，无虚寒之理，他如伤寒温热时行等病，总以浮滑而濡者为可治，故先师论脉，首言大浮数动滑为阳，而杂病以人迎浮滑为风痰，缓滑为中风，气口缓滑为热中，滑数为宿食，尺中弦滑为下焦畜血，又呕吐而寸口迟滑，为胸中寔，下利而关上迟滑，为下未尽，厥逆而脉滑，为里有寔，详此则滑脉之病，可不言而喻，即经有滑者阴气有余一语，是指阴邪搏阳而言，岂以阴气有余，多汗身寒之病，便可目为血多，又以滑天之脉，牵合无力，而为内伤元气乎，平人肢体丰盛，而按之绵奕，六脉奕滑，此痰湿渐渍于中外，终日劳役，不知倦怠，若安息则重着酸疼矣，夫脉之滑而不甚有力者，皆浮滑缓滑濡滑微滑之类，终非无力之比，滑为血寔气壅之脉，悉属有余，妇人身有病而脉和滑者为孕，临产派滑疾者曰离经，若滑而急强，擘擘如弹石，谓之肾绝，滑不直手，按之不可得，为大肠气予不足，以其绝无和缓胃气，故经予之短期。

濡脉者，指下濡滞不前，内经谓之参伍不调，叔和喻以轻刀刮竹，通真子比之如雨沾沙，长沙又以泻漆之绝，比拟虽殊，其义则一，不似迟脉之指下迟缓，缓脉之脉象纤徐濡脉之来去绵奕也，良由津血亏少，不能濡润经络，所以濡濡不调，故经有脉濡曰痹，寸口诸濡亡血，濡则心痛，尺热脉濡为懈，种种皆阴血消亡，阳气有余，而为身热无汗之病，亦有痰食胶固中外，脉道阻滞，而见濡数模糊者，阴受水谷

之害也，金匱云：寸口脉浮大，按之反濡，尺中亦微而濡，知有宿食，有发热头痛，而见浮濡数盛者，阳中雾露之气也，雾伤皮肤，湿流关节，总皆脉濡，但兼浮数沈细之不同也，有伤寒阳明府寔，不大便而脉濡，温病大热而脉濡，吐下微喘而脉濡，水肿腹大而脉濡，消瘴大渴而脉濡，痰症喘满而脉濡，病在外而脉濡，妇人怀孕而脉濡，皆症脉相反之候，间有因胎病而脉濡者，然在二三月时有之，若四月胎息成形之后，必无虚濡之理，平人无故脉濡，为贫窘之兆，尺中蹇濡则艰于嗣，金匱云：男子脉浮弱而濡则无子，精气清冷，其有脉塞而鼓如省客，左右旁至如交漆，按之不得如赭土，皆乖戾不和，殊异寻常之脉，故素问列之大奇。

虚脉者，指下虚大而爽，如循鸡羽之状，中取重按，皆弱而少力，久按仍不乏根，不似芤脉之豁然中空，按久渐出，濡脉之爽弱无力，举指即来散脉之散漫无根，重按久按绝不可得也，虚为营血不调之候叔和以迟大而爽为虚，每见气虚喘乏，往往有虚大而数者，且言血虚脉虚，独不详仲景脉虚身热，得之伤暑，东垣以气口脉大而虚者，为内伤于气，若虚大而时显一濡，为内伤于血，凡血虚之病，非显濡弱，则弦细芤迟，如伤暑脉虚为气虚，弦细芤迟为血虚，虚劳脉极虚芤迟，或尺中微细小者，为亡血失精，男子平人脉虚弱微细者，善盗汗出，则气血之分了然矣，慎斋有云：脉洪大而虚者防作泻，可知虚脉多脾家气分之病，大则气虚不敛之故，经云：脉气上虚尺虚，是谓重虚，病在中脉虚难治，仲景有脉虚者不可吐，腹满脉虚复厥者不可下，脉阴阳俱虚，热不止者死，可见病寔脉虚，皆不易治，盖虚即是毛，毛为肺之平脉，若极虚而微，如风吹毛之状，极虚而数，瞥瞥如羹上肥者，皆为肺绝之兆也，为癰疾之脉虚为可治者，以其神出舍空，可行峻补，若实大为顽痰固结，搜涤不应，所以为难耳。

实脉者，重浊滑盛，相应如参春而按之石坚，不似紧脉之迸急不和，滑脉之往来流利，洪脉之来盛去衰也，实为中外壅满之象，经云邪气盛则实，非正气本充之谓，即此一语，可为实脉之总归，夫脉既实矣，谅虚症之必无也，症既实矣，谅假象之必无也但以热邪亢极而暴绝者有之，其为病也，实在表则头痛身热，实在里则胀腹满，大而实者，热由中发细而实者，积自内生在伤寒阳明病，不大便而脉实则宜下，下后脉实大，或暴微欲绝，热不止者死，厥病，下利脉实者，下之死，病脉之逆，从可见矣，盖实即是石，石为肾之平脉若石坚太过，劈劈如弹石状，为肾绝之兆矣，其消瘴鼓胀坚积等病，皆以脉实为可治，若泄而脱血，及新产骤虚，久病虚羸，而得实大之脉，良不易治也。

弦脉者，端直以长，举之应指，按之不移不似紧脉之状如转索，革脉之劲如弓弦也，弦为风木主令之脉故凡病脉弦，皆阳中伏阴之象，虚症误用寒凉，两尺脉必变弦，胃虚冷食停滞，气口多见弦脉，伤寒以尺寸俱弦，为少阳受病少阳为枢，为阴阳之交界，如弦而兼浮兼细，为少阳之本脉，弦而兼数兼缓，即有入府传阴之两途若弦而兼之以沈濡微弱，得不谓之阴乎经言寸口脉弦者，胁下拘急而痛，令人嗇嗇恶寒，又伤寒脉弦细，头痛发热者属少阳，此阳弦头痛也，痛必见于太阳，阳脉濡，

阴脉弦，法当腹中急痛，此阴弦腹痛也，痛必见于少腹，皆少阳部分耳，少阴病欲吐不吐，始得之，手足寒脉弦迟者，此胸中寔当吐之，若膈上有寒饮干呕者，不可吐，急温之，详此，又不当以兼沈兼濡，概谓之阴，弦迟为胸中实也，审症合脉，活法在人贵在心手之灵活耳，历诊诸病之脉，属邪盛而见弦者，十常二三，属正虚而见弦者，十常六七其于他脉之中，兼见弦象者，亦复不少，在伤寒表邪全盛之时，中有一部见弦，或兼迟兼濡，便是夹阴之候，客邪虽盛，急需温散，汗下猛剂咸非所宜即非时感冒，亦宜体，此至于素有动气怔忡，寒疝脚气，种种宿病，而挟外感之邪，于浮紧数大之中委曲搜求，弦象必隐于内，多有表邪脉紧于紧脉之中，按之渐渐减小纵之不甚鼓指，便当弦脉例治于浮脉之中，按之敛直滑脉之中，按之搏指，并当弦脉类看，于沈脉之中，按之引引濡脉之中，按之切切，皆阴邪内伏阳气消沈，不能调和百脉，而显弦直之状，良非客邪紧盛之兆，迨夫伤寒坏病，弦脉居多，虚劳内伤弦常过半所以南阳为六残贼之首推也，他如病疟寒饮一切杂症，皆有弦脉，按金匱云：疟脉自弦，弦数多热弦迟多寒，弦小坚者下之差弦迟者可温之弦紧者可发汗针灸也，浮大者可吐之，弦数者风发也，以饮食消息主之饮脉皆弦双弦者寒也，偏弦者饮也，弦数者有寒饮，沈弦者悬饮内痛，他如腹痛鼓胀，胃反胸痹，症瘕畜血，中喝伤风霍乱滞下，中气郁结，寒热痞满等病，种种皆有弦脉，总由中气少权，土败木贼所致，但以弦少弦多，以证胃气之强弱，弦寔弦虚，以证邪气之虚实浮弦沈弦，以证表里之阴阳，寸弦尺弦，以证病气之升沈，无论所患何症，兼见何脉但以和缓有神不乏胃气咸为可治，若弦而劲细，如循刀刃，弦而强直，如新张弓弦，如循长竿，如按横格，皆但弦无胃气也，所以虚劳之脉多寸口数大尺中弦细搏指者，皆为损脉，卢扁复生奚益哉。

缓脉者，从容和缓不疾不徐似迟而实未为迟不似濡脉之指下绵奕虚脉之瞥瞥虚大微脉之微细而濡，弱脉之细软无力也，仲景云：阳脉浮大而濡阴脉浮大而濡，阴脉与阳脉同等者，名曰缓也，伤寒以尺寸俱微缓者，为厥阴受病，厥阴为阴尽复阳之界，故凡病后得之咸为相宜，其太阳病发热头痛自汗脉浮缓者，为风伤卫症以其自汗体疎，自不能紧盛也，缓为脾家之本脉然必和缓有神，为脾气之充，若缓甚而弱，为脾气不足，缓而滑利，则胃气冲和，昔人以浮缓为伤风，沈缓为寒湿缓大为风虚，缓细为痹湿，又以浮缓为风中于阳，沈缓为湿中于阴，盖湿脉自缓，得风以播之，则兼浮缓，寒以束之则兼沈缓苦中于阴，则沈细微缓，以厥阴内藏风木之气，故脉虽沈而有微缓之象也。

洪脉者，既大且数，指下累累如连珠，如循琅玕而按之稍缓，不似实脉之举按逼逼，滑脉之奕滑流利，大脉之大而且长也，昔人以洪为夏脉，内经以钩为夏脉遂有钩即是洪之说，以其数大而濡，按之指下委曲旁出，固可谓之曰钩，火性虚炎，所以来盛去衰按之不实，然痰食瘀积阻碍脉道，关部常屈曲而出，此与夏脉微钩，似同而实不类也，洪为火气燔灼之候，仲景有服桂枝汤，大汗出大烦渴不解，脉洪为温病，温病乃冬时伏气所发，发于春者为温病，发于夏者为热病，其邪伏藏于内而发出于表，脉多浮洪而混混不清，每多盛于右手，亦有动滑不常者，越人所谓行在诸

经，不知何经之动也，当此不行内夺，反与解表，不至热交营度不已也，若温热时行，症显烦渴昏热，脉反沈细小弱者，阳病阴脉也，有阳热亢极，而足冷尺弱者，为下虚之症，皆不可治，又屡下而热势不解，脉洪不减，谓之坏病，多不可救洪为阳气满溢，阴气垂绝之脉，故蔼蔼如车盖者为阳结，脉浮而洪，身汗如油为肺绝，即杂病脉洪，皆火气亢甚之兆，若病后久虚，虚劳失血，泄泻脱元，而见洪盛之脉，尤非所宜，惟昏浊下贱，脉多洪实，又不当以实热论也。

微脉者，似有若无，欲绝非绝，而按之稍有模糊之状，不似弱脉之小弱分明，细脉之纤细有力也，微为阳气衰微之脉，经言寸口诸微亡阳，言诸微者，则轻取之微，重按之微，气口之微，尺中之微，皆属气虚，故所见诸症，在上则为恶寒多汗少气之患，在下则有失精脱泻少食之虞，总之与血无预，所以萦萦如蜘蛛丝者，仲景谓阳气之衰，尝见中风卒倒而脉微，暑风卒倒而脉微，皆为虚风之象，其脉多兼沈缓，若中寒卒倒而脉微，为阴邪暴逆，所以微细欲绝也，而伤寒尺寸俱微缓，为厥阴受病，病邪传至此经，不特正气之虚，邪亦向衰之际，是以俱虚，不似少阴之脉微细，但欲寐耳，详二经之脉，同一微也，而有阴尽复阳，阳去入阴之异，即太阳经病之脉微，而有发热恶寒，热多寒少，脉微为无阳者，有面有热，色邪未欲解而脉微者有阴阳俱停，邪气不传，而脉反微者，若以微为虚象，不行攻发，何以通邪气之滞耶，必热除身安而脉微，方可为欲愈之机，若太阳症具，而见足冷尺微，又为下焦虚寒之验，可不建其中气，而行正发汗之例乎。

紧脉者，状如转索，按之虽实而不坚不似弦脉之端直如弦牢革之强直搏指也，紧为诸寒收引之象亦有热因寒束，而烦热拘急疼痛者，如太阳寒伤营症是也，然必人迎浮紧，乃为表症之确候若气口紧坚，又为内伤饮食之兆，金匱所谓脉紧头痛，风寒腹中有宿食也，仲景又云：曾为人所难，紧脉从何而来，假令亡汗若吐，以肺里寒，故令脉紧也，假令欬者坐饮冷水，故令脉紧也，假令下利，以胃中寒冷故令脉紧也，详此三下转语，可谓曲尽紧脉为病之变端，而少阴经中，又有病人脉阴阳俱紧，反汗出者亡阳也，此属少阴法当咽痛而复吐利，是谓紧反入里之微验，又少阳病脉紧，至七八月下利脉暴微手足反温，脉紧反去，为欲解也，虽烦下利必自愈，此即紧去人安之互词，辨不可下脉症中，又有脉来阴阳俱紧恶寒发热则脉欲厥者，脉初来大，渐渐小，更来渐渐大，是其候也，此亦紧反入里之互词因误下而阳邪内陷欲出不出有似厥逆进退之象故言欲厥，脉虽变而紧状依然，非营卫离散，乍大乍小之比，而脉法中复有寸口脉微，尺脉紧其人虚损多汗知阴常在，绝不见阳之例，可见紧之所在，皆阳气不到之处，故有是象，夫脉按之紧如弦直上下行者痉，若伏坚者为阴痉，总皆经脉拘急，故有此象，若脉至如转索，而强急不和，是但紧无胃气也，岂堪尚引日乎。

弱脉者，沈细而更按之乃得举之如无不似微脉之按之欲绝，濡脉之按之若无细脉之浮沈皆细也，弱为阳气衰微之候，夫浮以候阳今浮取如无阳衰之明验也，故伤寒首言弱为阴脉，即阳经见之亦属阳气之衰，经言，寸口脉弱而迟虚满不能食寸口脉弱

而缓食卒不下气填膈上，上二条，，一属胃寒一属脾虚，故皆主乎饮食，又形作伤寒，其脉不弦紧而弱太阳中喝身热疼重而脉微弱可见脉弱无阳，必无寔热之理，祇宜辨析真阳之虚，与胃气之虚，及夏月伤冷水，水行皮中所致耳在阴经见之，虽为合脉然阳气衰微已极，非大温大补，良难春回寒谷也惟血痹虚劳，久嗽失血，新产及老人久虚，脉宜微弱然必弱而和滑，可卜胃气之未艾，若少壮暴病而见脉弱，咸非所宜，即血症虚症，脉弱而兼之以濇为气血交败，其能荣灶下之薪乎。

长脉者，指下迢迢而过于本位，三部举按皆然，不似大脉之举之盛大，按之少力也，伤寒以尺寸俱长，为阳明受病，内经又以长则气治，为胃家之平脉，胃为水谷之海，其经多气多血，故显有余之象，然必长而和缓，方为无病之脉若长而浮盛，又为经邪方盛之兆，亦有病邪向愈，而脉长者，仲景云：太阴中风，四肢烦疼，阳脉微，阴脉濇，而长者为欲愈，盖风本阳邪，因土虚木弃，陷于太阴之经而长脉见于微濇之中，疼热发于诸阳之本，洵为欲愈之征，殊非病进之谓，且有阴气不充，而脉反上盛者，经言寸口脉中手长者，曰足胫痛是也，此与秦越人遂上鱼为溢，遂入尺为覆，及上部有脉下部无脉，关格吐逆，不得小便，同脉异症，不可与尺寸俱长之脉，比例而推也。

短脉者，尺寸俱短，而不及本位，不似小脉之三部皆小弱不振，伏脉之一部独伏匿不前也，经云：短则气病，良由胃气阂塞，不能条畅百脉，或因痰气食积阻碍气道所以脉见短濇促结之状，亦有阳气不充而脉短者，经谓寸口脉中手短者，曰头痛是也，仲景云：汗多重发汗，亡阳譌语，脉短者死，脉自和者不死，又少阴脉不至，肾气绝为尸厥，伤寒六七日，大下后，寸脉沈而迟，手足厥冷，下部脉不至，咽喉不利，唾脓血者难治，戴同父云：短脉只当责之于尺寸若关中见短，是上不通寸为阳绝，下不通尺为阴绝矣，曷知关部，从无见短之理，昔人有以六部分隶而言者，殊失短脉之义。

大脉者，应指满溢，倍于寻常，不似长脉之但长不大，洪脉之既大且数也，大脉有虚寔阴阳之异，经云：大则病进，是指实大而言，仲景以大则为虚者，乃盛大少力之谓，然又有下利脉大者为未止，是又以积滞未尽而言，非大则为虚之谓也，有六脉俱大者，阴不足，阳有余也，有偏大于左者，邪盛于经也，偏大于右者，热盛于内也，亦有诸脉皆小，中有一部独大者，诸脉皆大，中有一部独小者，便以其部断其病之虚寔，且有素禀六阳，或一手偏旺偏衰者，又不当以病论也，凡大而数实有力，皆为实热，如人迎气大紧以浮者，其病益甚在外，气口微大，名曰平人，其脉大坚以濇者胀，乳子中风热，喘鸣肩息者，脉实大而缓则生，急则死，乳子，是指产后以乳哺子而言，非婴儿也，产后脉宜悬小，最忌实大，今症见喘鸣肩息，为邪气暴逆，又须实大而缓，方与症合，若实大急强，为邪胜正衰，去生远矣，此与乳子而病热，脉弦小，手足温则生，似乎相左，而实互相发明也，伤寒热病，譌语烦渴，脉来实大，虽剧可治，得汗后热不止，脉反实大躁疾者死，温病大热不得汗，脉大数急强者死，细小虚濇者亦死，厥阴病下利脉大者，虚也，以其强下之也，阴

症反大发热，脉虚大无力，乃脉症之变，内症元气不足，发热脉大而虚，为脉症之常，虚劳脉大，为血气虚盛，金匱云：男子平人脉大为劳，气有余，便是火也，所以瘦人胸中多气而脉大，病久气衰而脉大，总为阴阳离绝之候，孰谓大属有余，而可恣行攻伐哉，若脉见乍大乍小，为元神无主，随邪气之鼓动，可不慎而漫投汤药耶。

小脉者，三部皆小，而指下显然，不似微服之微弱依稀，细脉之微细如发，弱脉之奕弱不前，短脉之首尾不及也，夫脉之小弱，虽为元气不足，若小而按之不衰久按有力，又为实热固结之象，总由正气不充，不能鼓搏热势于外，所以隐隐略见滑热之状于内也，设小而症见热邪亢盛，则为脉症相反之兆，亦有平人六脉皆阴，或一手偏小者，若因病而脉损小，又当随所见部分而为调适，机用不可不治也，假令小弱见于人迎，卫气衰也见于气口，肺胃弱也，见于寸口，阳不足也，见于尺内，阴不足也，凡病后脉见小弱，正气虽虚，邪气亦退，故为向愈，设小而兼之以滑实伏匿，得非寔热内蕴之征乎，经云：切其脉口滑小紧而沈者，病益甚在中，又云：温病大热，而脉反细小，手足逆者死，乳子而病热，脉悬小手足温则生，寒则死，此条与乳子中风热互发，言脉虽实大，不至急强，脉虽悬小，四支不逆，可卜胃气之未艾，若脉失冲和，阳竭四末，神丹奚济非特主产后而言，即妊娠亦不出于是也婴儿病，赤痢飧泄，脉小手足寒，难已，脉小手足温，泄易已，腹痛脉细小而迟者易治，坚大而急者难治，洞泄食不化，脉微小流连者生，坚急者死，谛观诸义，则病脉之逆从可默悟矣，而显微又言，前大后小，则头痛目眩，前小后大，则胸满短气，即仲景来微去大之变词，虚中挟寔之旨，和盘托出矣。

芤脉者，浮大弦奕，按之中空中按虽不应指，细推仍有根气，纵之却显弦大，按之减小中空，不似虚脉之瞥瞥虚大，按之豁然无力也，芤为血虚不能濡气，故虚大如芤，然其中必显弦象，刘三点以为绝类葱葱，殊失弦大而按之减小中空之义，盖虚则阳气失职，芤则经络中空，所以有虚濡无力，弦大中空之异，仲景云：脉弦而大弦则为减，大则为芤，减则为寒，芤则为虚，虚寒相搏，此名为革，革则胃气告匮，而弦强搏指，按之无根，非芤脉中空之比，按太阳病有脉浮而紧，按之反芤，本虚战汗而解者，暑病有弦细芤迟血分受伤者，芤为失血之本脉，经云：脉至如搏，血温身热者死，详如搏二字，即是弦大而按之则减也，又云：脉来悬钩浮为常脉，言浮而中空，按之旁至似乎微曲之状，虽有瘀积阻滞，而指下柔和，是知尚有胃气，故为失血之常脉，若弦强搏指，而血温身热，为真阴枯竭，必死何疑，凡血脱脉芤，而有一部独弦，或带结促澹滞者，此为阳气不到，中挟阴邪之兆，是即瘀血所结处也，所以芤脉须辨一部两部，或一手两手而与攻补，方为合法。

濡脉者，虚奕少力应指虚细如絮浮水面，轻手乍来，重手乍去，不似虚脉之虚大无力，微脉之微细如丝，弱脉之沈细奕弱也，濡为胃气不充之象，故内伤虚劳，泄泻少食自汗喘乏，精伤痿弱之人，脉虽濡奕乏力，犹堪峻补温补，不似阴虚脱血，纯见细数弦强，欲求濡弱，绝不可得也，盖濡脉之浮奕，与虚脉相类，但虚则浮大，

而濡则小弱也，濡脉之细小，与弱脉相类，但弱在沈分，而濡在浮分也，濡脉之微弱，与微脉相类，但微则欲绝，而濡则力微也，濡脉之无力，与散脉相类，但散则从大而按之则无，濡则从小而渐至无力也，夫从小而渐至无力，气虽不充，血犹未败，从大而按之即无，则气无所统，血已伤残，阴阳离散，将何所恃，而可望其生乎，以此言之，则濡之与散，不啻霄壤矣。

动脉者，厥厥动摇，指下滑数如珠，见于关上，不似滑脉之诸部皆滑数流利也，动为阴阳相搏之候，阳动则汗出，阴动则发热，是指人迎气口而言，然多有阴虚发热之脉，动于尺内，阳虚自汗之脉，动于寸口者，所谓虚者则动，邪之所凑，其气必虚，金匱有云：脉动而弱，动则为惊，弱则为悸，因其虚而旺气弃之，惟伤寒以大浮数动滑为阳，是专主邪热相搏而言，非虚劳体痛，便溺崩淋脉动之比，而妇人尺脉动甚，为有子之象，经云：阴搏阳别，谓之有子，又云：妇人手少阴脉动者，妊子也，以肾藏精，心主血，故二处脉动，皆为有子，辨之之法，昔人皆以左大顺男，右大顺女为言，然妊娠之脉，往往有素禀一手偏大偏小者，莫若以寸动为男，尺动为女，最为有据。

伏脉者，隐于筋下，轻取不得，重按濡难，委曲求之，附着于骨，而有三部皆伏，一部独伏之异，不似短脉之尺寸短缩，而中部显然，沈脉之三部皆沈，而按之即得也，伏脉之病，最为叵测，长沙有趺阳脉不出，脾不上下，身冷肤鞭，少阴脉不至，令身不仁，此为尸厥等例，详伏为阴阳潜伏之候，有邪伏幽隐而脉伏不出者，虽与短脉之象有别，而气血濡滞之义则一，故关格吐逆，不得小便之脉，非偏大倍常，即偏小隐伏，越人所谓上部有脉，下部无脉是也，凡气郁血结久痛，及疝瘕留饮，水气宿食，霍乱吐利等脉，每多沈伏，皆经脉阻滞，营卫不通之故，所以妊娠恶阻，常有伏匿之脉，此又脉症之变耳，在伤寒失于表散，邪气不得发越，而六脉俱伏者，急宜发汗，而脉自复，刘元宾曰：伏脉不可发汗，谓其非表脉也，而洁古又言，当以麻黄细辛附子汤发之，临病适宜，各有权度，不可执一，若六七日烦扰不宁，邪正交并而脉伏者，又为战汗之兆，如久旱将雨，六合阴晦，雨过庶物皆苏也，不可以伏为阴脉，误投辛热，顷刻昆仑飞焰矣。

细脉者，往来如发，而指下显然，不似微脉之微弱模糊也，细为阳气衰弱之候，伤寒以尺寸俱沈细，为太阴受病，太阴职司敷化之权，今为热邪所传，营行之气，不能条畅百脉，所以尺寸皆沈细，不独太阴为然，即少阴之脉，亦多沈细，故仲景有少阴病，脉沈细数，不可发汗之禁，此皆外阴内阳，非若严冬卒中暴寒，盛夏暑风卒倒，内外皆阴之比，内经细脉诸条，如细则少气，脉来细而附骨者，积也，尺寒脉细，谓之后泄，头痛脉细而缓为中湿，种种皆阴邪之证验，所以胃虚少食，冷涎泛逆，便泄腹痛，湿痹脚栗，自汗失精，皆有细脉，但以兼浮兼沈，在尺在寸，分别而为裁决，如平人脉来细弱，皆忧思过度，内戕真元所致，若形盛脉细，少气不足以息，及病热脉细，神昏不能自持，皆脉不应病之候，不可以寻常虚细论也。

疾脉者，呼吸之间，脉七八至，虽急疾而不实大，不似洪脉之既大且数，却无躁疾之形也，疾脉有阴阳寒热真假之异，如疾而按之益坚，乃亢阳无制，真阴垂绝之候，若疾而按之不鼓，又为阴邪暴虐，虚阳发露之征，尝考先辈治按，有伤寒面赤目赤，烦渴引饮而不能咽，东垣以姜附人参汗之而愈，又伤寒畜热内盛，阳厥极深，脉疾至七八至以上，人皆误认阴毒，守真以黄连解毒治之而安，斯皆证治之明验也，凡温病大热躁渴，初频率小，至五六日后，脉来躁疾，大颧发赤者死，谓其阴绝也，躁疾皆为火象，内经有云，其有躁者在手，言手少阴厥阴二经，俱属于火也，阴毒身如被杖，六脉沈细而疾，灸之不温者死，谓其阳绝也，然亦有热毒入于阴分，而为阴毒者，脉必疾盛有力，不似阴寒之毒，虽疾而弦细乏力也，虚劳喘促声嘶，脉来数疾无伦，名曰行尸，金匱谓之厥阳独行，此真阴竭于下，孤阳亢于上也，惟疾而不躁，按之稍缓，方为热症之正脉，脉法所谓疾而洪大苦烦满，疾而沈细腹中痛，疾而不大不小，虽困可治，其有大小者难治也，至若脉至如喘，脉至如数，得之暴厥暴惊者，待其气复自平，迨至脉至浮合，浮合如数，一息十至以上，较之六数七疾八极更甚，得非虚阳外惊之兆乎。

牢脉者，弦大而长，举之减小，按之实强，如弦缕之状，不似实脉之滑实流利，伏脉之匿伏濡难，革脉之按之中空也，叔微云：牢则病气牢固，在虚症绝无此脉，惟湿痼拘急，寒疝暴逆，坚积内伏，乃有是脉，历考诸方，不出辛热开结，甘温助阳之治，庶有克敌之功，虽然，固垒在前，攻守非细，设更加之以食填中土，大气不得流转，变故在于须臾，可不为之密察乎，若以牢为内实，不问所以，而妄行迅扫，能无实实虚虚之咎哉，大抵牢为坚积内着，胃气竭绝，故诸家以为危殆之象云。

革脉者，弦大而数，浮取强直，重按中空，如鼓皮之状，不似紧脉之按之劈劈，弦脉之按之不移，牢脉之按之益坚也，婴童生曰：革乃变革之象，虽失常度，而按之中空，未为真藏，故仲景厥阴例中，有下利肠鸣脉浮革者，主以当归四逆汤，得非风行木末，扰动根株之候乎，又云：妇人则半产漏下，男子则亡血失精，金匱半产漏下，主以旋覆花汤，得非血室伤惫，中有瘀结未尽之治乎，其男子亡血失精，独无主治，云岐补以十全大补，得非极劳伤精，填补其空之谓乎，是以长沙直以寒虚相搏例之，惟其寒，故柔和之气失焉，惟其虚，故中空之象见焉，岂以革浮属表，不顾肾气之内惫乎。

促脉者，往来数疾中，忽一止复来，不似结脉之迟缓，中有止歇也，促为阳邪内陷之象，经云：寸口脉中手上击者曰肩背痛，观上击二字，则脉来搏指，热盛于经之义，朗然心目矣，而仲景太阳例，有下之后脉促胸满者，有下之利遂不止，而脉促者，有下之脉促不结胸者，有脉促手足厥冷者，上四条，一为表邪未尽，一为并入阳明，一为邪去欲解，一为传次厥阴，总以促为阳盛，里不服邪之明验，虽症见厥逆，祇宜用灸以通阳，不宜四逆以回阳，明非虚寒之理，具见言外，所以温热发斑，瘀血发狂，及痰食凝滞，暴怒气逆，皆令脉促，设中虚无凝，必无歇止之脉也。

结脉者，指下迟缓中，频见歇止，而少顷复来，不似代脉之动止不能自还也，结为阴邪固结之象，越人云：结甚则积甚，结微则气微，言结而少力，为正气本衰，虽有积聚，脉结亦不甚也，而仲景有伤寒汗下不解，脉结代，心动悸者，有太阳病身黄脉沈结，少腹鞭满，小便不利，为无血者，一为津衰邪结，一为热结膀胱，皆虚中挟邪之候，凡寒饮死血，吐利腹痛，癰疽虫积等气郁不调之病，多有结脉，暴见即宜辛温扶正，略兼散结开痰，脉结自退，尝见二三十至，内有一至，接续不上，每次皆然，而指下虚微，不似结促之状，此元气骤脱之故，峻用温补自复，如补益不应，终见危殆，若久病见此，尤非合脉，夫脉之歇止不常，须详指下有力无力，结之频与不频，若十余至，或二三十至一歇，而纵指续续，重按频见，前后至数不齐者，皆经脉窒碍，阴阳偏阻所致，盖阳盛则促，阴盛则结，所以仲景皆为病脉。

代脉者，动而中止，不能自还，因而复动，名曰代阴，不似促结之状虽见歇止，而复来有力也，代为元气不续之象，经云：代则气衰，在病后见之，未为死候，若气血骤损，元神不续，或七情太过，或颠仆重伤，或风家痛家脉见止代，只为病脉，伤寒家有心悸脉代者，腹痛心疼，有结濇止代不匀者，凡有痛之脉止歇，乃气血阻滞而然，不可以为准则也，若不因病而脉见止代，是一藏无气，他藏代之，真危亡之兆也，即因病脉代，亦须至数不匀者，犹或可坐，若不满数至一代，每次皆如数而止，此必难治，经谓五十动，不一代者，以为常也，以知五藏之期，予之短期者，乍疎乍数也，又云：数动一代者，病在阳之脉也，此则阳气竭尽无余之脉耳，所以或如雀啄，或如屋漏，或如弦绝，皆真代脉，见之生理绝矣，惟妊娠恶阻，呕逆最剧者，恒见代脉，谷入既少，气血尽并于胎息，是以脉气不能接续，然在二三月时有之，若至四月，胎已成形，当无歇止之脉矣。

散脉者，举之浮散，按之则无，去来不明，漫无根蒂，不似虚脉之重按虽虚，而不至于散漫也，散为元气离散之象，故伤寒欬逆上气，其脉散者死，谓其形损故也，可知散脉为必死之候，然形象不一，或如吹毛，或如散叶，或如悬雍，或如羹上肥，或如火薪然，皆真散脉，见之必死，非虚大之比，经曰：代散则死，若病后大邪去，而热退身安，泄利止而浆粥入胃，或有可生者，又不当一概论也，古人以代散为必死者，盖散为肾败之应，代为脾绝之兆，肾脉本沈，而散脉按之不可得见，是先天资始之根本绝也，脾脉主信，而代脉去来必愆其期，是后天资生之根本绝也，故二脉独见，均为危亡之候，而二脉交见，尤为必死之征。

清脉者，轻清缓滑，流利有神，似小弱而非微细之形，不似虚脉之不胜寻按，微脉之栗弱依稀，缓脉之阿阿迟纵，弱脉之沈细栗弱也，清为气血平调之候，经云：受气者清，平人脉清虚和缓，生无险阻之虞，如左手清虚和缓，定主清贵仁慈，若清虚流利者，有刚决权变也，清虚中有一种弦小坚实，其人必机械峻刻，右手脉清虚和缓，定然富厚安闲，若清虚流利，则富而好礼，清虚中有种枯濇少神，其人虽丰，目下必不适意，寸口清虚，洵为名裔，又主聪慧，尺脉清虚，端获良嗣，亦为寿征，若寸关俱清，而尺中蹇濇，或偏小偏大，皆主晚景不丰，及艰子嗣，似清虚而

按之滑盛者，此清中带浊，外廉内贪之应也，若有病而脉清楚，虽剧无害，清虚少神，即宜温补以助真元，若其人脉素清虚，虽有客邪壮热，脉亦不能鼓盛，不可以为症寔脉虚，而失于攻发也。

浊脉者，重浊洪盛，腾涌满指，浮沈滑实有力，不似洪脉之按之戛阔，寔脉之举之减小，滑脉之往来流利，紧脉之转索无常也，浊为禀赋昏浊之象，经云：受谷者浊，平人脉重浊洪盛，垂老不得安间，如左手重浊，定属污下，右手重浊，可卜庸愚，寸口重浊，家世卑微，尺脉重浊，子息卤莽，若重浊中有种滑利之象，家道富饶，浊而兼得蹇澹之状，或偏盛偏衰，不享安康，又主夭枉，似重浊而按之和缓，此浊中兼清，外圆内方之应也，大约力役劳苦之人，动辄劳其筋骨，脉之重浊，势所必然，至于市井之徒，拱手曳裾，脉之重浊者，此非天性使然欤，若平素不甚重浊，因病鼓盛者，急宜攻发以开泄其邪，若平昔重浊，因病而得蹇澹之脉，此气血凝滞，痰涎胶固之兆，不当以平时蹇澹论也。

口问（一十二则）

门人问曰：读师传诸义，发智慧光，如大火聚，扫却胸中无限阴霾矣，但某等根器疎陋，尚有积疑未泮，如三焦命门，各有岐说，未获定鉴，愿师垂海真铨，以破学人之惑，答曰：夫所谓命门者，即三焦真火之别名也，以其职司腐熟之令，故谓之焦，经谓中精之府，言其所主精气也，又云：上焦如雾，中焦如沤，下焦如渌者，言其气化之象也，岐伯曰：寸以射上焦，关以射中焦，尺以射下焦，此言三焦之脉位也，射者，自下而射于上，其脉即分属寸关尺，凡鼓动之机，靡不本诸三焦，则知六部之中，部部不离三焦之气也，三焦为真火之源，故有命门之号，难经独以右尺当之，而脉诀复有男女左右之分，男以精气为主，故右尺为命门，女以精血为主，故左尺为命门，是命门之诊，尤重在乎尺内也，三焦鼎峙两肾之间，为水中之火，既济阴阳，赵氏所谓天非此火不能生物，人非此火不能有生，为性命之主宰，故曰命门，越人谓其有名无形者，以火即气，气本无形，非若精津血液之各有其质也，以气化为无形则可，以三焦为无形则不可，灵枢本藏云肾应骨，密理厚皮者，三焦膀胱厚，粗理薄皮者，三焦膀胱薄，疎腠理者，三焦膀胱急，毫毛美而粗者，三焦膀胱直，稀毫毛者，三焦膀胱结也，详此明言厚薄急结之状，诂可谓之无形乎。

复问神门为心经之动脉，而王氏又云：神门决断，两在关后者，是指尺中肾脉而言，其故何也，答曰：神门之脉有二，如前所言神门即是命门，命门即是三焦，属于七节之上，故于尺中求之，以尺为六脉之根也，越人云：人之有尺，譬如树之有根水，为天一之元，先天之命根也，若肾脉独败，是无根矣，此与诸脉之重按有力为有根，脉象迥异，而为肾气之所司则所也，如虚浮无根，是有表无里，孤阳岂能独存乎，若尺内重按无根，不但先天肾水之竭，亦为后天不足之征，仲景所谓营气不足，血少故也，脉微所云：是指心经动脉而言，案气交变论中岁水太过一节，内有神门绝者死不治，言水胜而火绝也，其穴在掌后兑骨之端，即如人迎与气口并称，

皆主关前一分而言，其穴在喉之两傍，乃足阳明之动脉，能于是处求诸经之盛衰乎，可知神门二说，各有主见，各有至理，不可附会牵合而致疑殆也，问冲阳太溪，皆足之动脉，每见时师求之于垂毙之时，验乎不验乎，答曰：是即仲景趺阳少阴也，尝闻气口成寸，以决死生，未闻决之于二处也，仲景以此本属胃与肾脉，虽变其名，仍当气口尺中诊之，脉法之寸口趺阳少阴三者并列而论，是即寸关尺三部之别号，但未明言其故耳，喻嘉言释仲景平脉首条云：条中明说三部，即后面趺阳少阴，俱指关尺而言，然何以止言趺阳少阴，盖两寸主乎上焦，营卫之所司，不能偏于轻重，故言寸口，两关主乎中焦，脾胃之所司，宜重在右，故言趺阳，两尺主乎下焦，宜重在左，故言少阴，此先得我心之所同然，况二处动脉，仅可求其绝与不绝，断不能推原某脉主某病也，设闺中处子，而欲按其足上之脉，殊为未便，昔人所云：反关之脉，但言脉位之异，未审所见之脉与平常之人可例推乎，抑别有所异乎，答曰：凡脉之反关者，皆由脉道阻碍，故易位而见，自不能调畅如平常之脉也，其反关之因，各有不同，而反关之状，亦自不一，有胎息中惊恐颠仆而反关者，有襁褓束缚致损而反关者，有幼时跌蹠动经而反关者，有韶龀疳积伐肝太过，目连札而左手偏小，有似反关者，有大惊丧志，死绝复苏而反关者，有一手反关者，有两手反关者，有从关斜走至寸而反关者，有反于内侧，近大陵而上者，有六部原有如丝，而阳溪列缺，别有一脉大于正位者，有平时正取侧取俱无，覆手取之而得者，有因病而正取无脉，覆手诊之乃得者，总皆阴阳伏匿之象，有伤寒欲作战汗脉伏而误认反关者，大抵反关之脉，沈细不及，十常八九，坚强太过者，十无二三，欲求适中之道，卒不易得也，亦有诸部皆细小不振，中有一粒如珠者，此经脉阻结于其处之状，故其脉较平人细小者，为反关之常，较平人反大者绝少，不可以为指下变异，谓之怪脉也，凡遇反关殊异平常之脉，须细询其较之平时稍大，即为邪盛，比之平时愈小，即为气衰，更以所见诸症参之。

门人问曰：人迎主表，气口主里，东垣内外伤辨，言之详矣，而盛启东又以新病之死生，系乎右手之关脉，宿病之死生，主乎左手之关尺，斯意某所未达，愿闻其义云何，答曰：疾有新久，症有顺逆，新病谷气犹存，胃脉自应和缓，即或因邪鼓大，因虚减小，然须至数分明，按之有力，不至浊乱，再参语言清爽，饮食知味，胃气无伤，虽剧可治，如脉至浊乱，至数不明，神昏语错，病气不安，此为神识无主，苟非大邪暝眩，岂宜见此，经云：脉浮而滑，谓之新病，脉小而濡，谓之久病，故新病一时形脱者死，不语者亦死，口开眼合，手撒喘汗遗尿者，俱不可治，新病虽各部脉脱，中部独存者，是为胃气，治之必愈，久病而左手关尺奕弱，按之有神，可卜精血之未艾，他部虽危，治之可生，若尺中弦紧急数，按之搏指，或细小脱绝者，法在不治，盖缘病久胃气血衰，又当求其尺脉，为先天之根气也，启东又云：诊得浮脉，要尺内有力为先天肾水可恃，发表无虞，诊得沈脉，要右关有力，为后天脾胃可凭，攻下无虞，此与前说互相发明，言虽异而理不殊也。

问脉有下指浮大，按久索然者，有下指濡奕，按久搏指者，有下指微弦，按久和缓者，何也，答曰：夫诊客邪暴病，应指浮象可症，若切虚羸久病，当以根气为本，

如下指浮大，按久索然者，正气大虚之象，无问暴病久病，虽症显灼热烦扰，皆正衰不能自主，随虚阳发露于外也，下指濡栗，久按搏指者，里病表和之象，非藏气受伤，则坚积内伏，不可以脉沈误认为虚寒也，下指微弦，按久和缓者久病向安之象，气血虽殆，而藏气未败也，然多有症变多端而脉渐小弱，指下微和，似有可愈之机者，此元气与病气俱脱，反无病象发现，乃脉不应病之候，非小则病退之比，大抵病人之脉，初下指虽见乏力，或弦细不和，按至十余至渐和者，必能收功，若下指似和，按久微濡不能应指，或渐觉弦硬者，必难取效，设病虽牵缠，而饮食渐进，便溺自调，为胃气渐复之兆，经云：安谷者胃，浆粥入胃，则虚者活，此其候也。

问有病同而脉异，病异而脉同，病同而治异，病异而治同，何也，答曰：夫所谓病同而脉异者，人在气交之中，所感六淫七情，八风九气，一时之病，大率相类，故所见之症，亦多相类，而人之所禀，各有偏旺偏衰之不同，且有内戕神志，外役支体，种种悬殊，脉象岂能如一，如失血症，脉有浮大而芤者，有小弱而数者，伤胃及藏之不同也，气虚症有气口虚大而濡者，有气口细小而弱者，劳伤脱泄之不同也，病异而脉同者，内伤夹外感，阳症夹阴寒，虚中有实，积新邪夹旧邪，表里交错，为患不一，而脉之所现，不离阴阳寒热虚实之机，其细微见症，安能尽显于指下哉，如太阳中风，瘫痪不仁，脉皆浮缓，一为暴感之邪，一为久虚之病，虚劳骨蒸，病症寒热，关尺皆弦紧，一为肾藏阳虚，一为少阳邪盛，可不互参脉症一概混治乎，病同而治异者，风气之病，时气之病，疟利之病，内伤虚劳之病，初起见症，往往相似，而人之所禀，各有贞脆，且有多火多痰多气，平时之资质既殊，病中之调治自异，如金匱之短气有微饮者，从小便去之，苓桂朮甘汤主之，肾气丸亦主之，消渴小便不利，蒲灰散主之，滑石白鱼散，茯苓戎监汤并主之，若治病不求其本，不问脉症之真象假象，但见病医病，殊失逆从反正之旨矣，病异而治同者，所见之症虽异，总不外乎邪正之虚实，如伤寒尺中脉迟之营气不足，阳邪内陷之腹中痛，虚劳里急之悸衄失精，并宜小建中汤，伏气郁发之热病，太阳中热之喝病，并宜白虎汤，寒疝之腹急胁急，产后之腹中痛，并宜当归生姜羊肉汤，岂可以一方主治一病，而不达权变之用哉。

问古人治例，有从症不从脉，从脉不从症一病而治各不同，或愈或不愈者，其故何也，答曰：此节庵先生以南阳治例，下一脚注也，惜乎有所未尽耳，盖从症从脉，各有其方，如脉浮为表，治宜汗之，然亦有宜下者，仲景云脉浮而大，心下反鞭有热属藏者攻之，不令发汗，脉沈为里治宜下之，然亦有宜汗者，如少阴病，始得之，反发热脉沈者，麻黄附子细辛汤汗之，脉促为阳盛，当用芩葛清之，若脉促厥冷，非灸百会以通其阳，此非促为阳盛也，脉迟为寒，当姜附温之，若阳明病脉迟不恶寒身体濇然汗出，则当用大承气，又非迟为阴寒也，此皆不从脉之治，以其症急也，又如表症汗之，乃常法也仲景云：病发热头痛，脉反沈，身体痛，当温之，宜四逆汤，里症下之，亦其常也，日晡发热者，属阳明，脉浮虚者，宜发汗用桂枝汤，结胸症具，当与陷胸下之，脉浮大者不可下，当与桂枝人参汤温之，身体疼痛，

当以麻桂汗之，然尺中脉迟者不可汗，当用小建中汤和之，此皆不从症治，以其脉虚也，一病而治各不同，或愈或不愈者，良由不明受病之故，尝考内经多有同一见症，而所受之经各别，所见之脉迥殊，其可执一例治乎，况医有工拙，病有标本，假令正气有权之人，无论治本治标，但得药方开发病气，元神自复，若正气本虚之人，反现假症假脉，而与苦寒伐根之药，变端莫测矣，故凡治邪气暴虐，正气骤脱之病制方宜猛盖暴邪势在急迫，骤虚法当峻补，若虚邪久淹，羸弱久困之病，不但制方宜缓，稍关物议之味，咸须远之，是以巨室贵显之家，一有危疑之症，则遍邀名下相商，于补泻杂陈之际，不可独出已见而违众处方，即不获已，亦须平淡为主，倘病在危逆，慎勿贪功奏技，以招铄金之谤也。

客问内经阴阳别论所言，二阳之病发心脾，三阳为病发寒热，一阳发病少气诸例，俱论脉法之阴阳，王太仆误作经脉批注，观其提纲，悉从脉有阴阳一句而来，次言知阳者知阴，知阴者知阳，凡阳有五，五五二十五阳，即仲景大浮数动滑为阳，以五藏之脉，各有大浮数动滑，是为五五二十五阳也，不言五五二十五阴者，先言知阳者知阴，则沈瀼弱弦微之阴，可不言而喻也答曰：读书虽要认定提纲，一气贯澈然中间转折，尤宜活着，不可执着，盖脉有阴阳句，岐伯原是答黄帝人有四经十二从等问，所言凡阳有五，五五二十五阳，是言五藏之阳气，应时鼓动于脉，五五相承，为二十五阳，与玉机真藏之故病有五，五五二十五变，异名同类，夫脉法之阴阳，原不离乎经脉之阴阳，况下文所言，三阳在头三阴在手，得非明言经脉阴阳之确据乎，若以脉有阴阳，为通篇之提纲，皆附会于脉，未免支离牵强，殊失先圣立言之旨矣，曷知阴阳别论，原从阴阳应象，阴阳离合，鱼贯而下，皆论经脉之阴阳，又为提纲中之挈领，可不体会其全，妄讥先辈乎。

旅泊苕溪，偶检嘉言先生仲景脉法解，坐有同人谓石顽曰：夫脉之显著共闻者，尚且指下难明，况乎险奥幽微，人所共昧，如高章纲牒卑损之脉，既非恒有之象，何长沙博采古训，以眩耳目，喻子曲为释词，以夸博识乎，答曰：此古圣至微至显之的诀，不能晦藏于密，一时为之阐发，岂故为诡异以欺后世耶，其所谓纲者，诸邪有余之纲领，损者，诸虚积渐之损伤，恐人难于领悟，乃以高章牒卑四字，体贴营卫之盛衰，虽六者并举，而其所主，实在纲损二脉也，以其辞简义深，未由窥测，喻子独出内照，发明其义，惜乎但知高章为高章取象，牒卑为牒卑措辞，不知高张为纲脉之纪，牒卑为损脉之基耳，盖高者，自尺内上溢于寸，指下涌涌，既浮且大，而按之不衰，以卫出下焦，行胃上口，至手太阴，故寸口盛满，因以高字名之，章者，自筋骨外显于关，应指逼逼，既动且滑，而按之益坚，以营出中焦，亦并胃口而上上焦，故寸关实满，因以章字目之，纲者，高章兼该之象，故为相搏，搏则邪正交攻，脉来数甚，直以纲字揭之，牒者，寸口微滑而按之软弱，举指瞥瞥，似数而仍力微，以卫气主表，表虚不能胜邪，故有似乎心中怵惕之状，因以牒字喻之，卑者，诸脉皆不应指，常兼沈瀼之形，而按之隐隐，似伏而且瀼难，以营气主里，里虚则阳气不振，故脉不显，有似妾妇之卑屑不能自主，故以卑字譬之，损者，牒卑交参之谓，故为相搏，搏则邪正俱殆，脉转衰微，直以损字呼之，而损脉之下

，复有迟缓沈三者，言阿阿徐缓，而按之沈实，为营卫俱和，阴阳相抱之象，不过借此以显高章等脉，大都高章纲慄卑损之脉，皆从六残贼来，其浮滑之脉，气多上升而至于高，弦紧之脉邪必外盛而至于章，沈濇之脉，阳常内陷而至于卑，非阴寒脉沈，不传他经之比凡此六者，能为诸脉作病故谓残贼，纵邪气盛满而汗下克削太过皆能致虚，虚则脉来慄慄按之力微速所必至至于高章相搏，未有不数盛者，慄卑相搏，未有不弦劲者，所以沈伏之中，尺内时见弦细搏指，则为损脉来至，必难治也，详高慄之脉，往往见于寸口章脉每多显于趺阳，卑脉恒于少阴见之然慄卑之脉寸口趺阳未尝不有也，高章之脉，尺内少阴，从未一见耳，观后寸口趺阳少阴诸条，皆言高章慄卑之病其阴阳死生之大端，端不出大浮数动滑为阳，沈濇弱弦微为阴之总纲，以其非专言伤寒脉法，故长沙另缉平脉法篇隶诸辨脉法下，由是昔余诠释赞论，略未之及，兹因同人下问，不觉为之饶舌。

或问医以声色之辨为神圣妙用而审切反居其次，何也答曰：夫色者神之华，声者气之发，神气为生阳之征验，在诊之际不待问而阴阳虚实之机，先见于耳目间矣，予于伤寒绪论，言之颇详，姑以大略陈之色贵明润不欲沈夭，凡暴感客邪之色，不妨昏浊壅滞病久气虚祇宜瘦削清癯若病邪方锐，而清白少神虚羸久困，而妩媚鲜泽，咸非正色，五色之中青黑黯惨，无论病之新久总属阳气不振，惟黄色见于面目，而不至索泽者皆为向愈之候，若眼胞上下如烟煤者寒痰也，眼黑颊赤者，热痰也，眼黑而行步艰难呻吟者，痰饮入骨也眼黑而面带土色，四肢痿痹，屈伸不便者风痰也，病人见黄色光泽者，为有胃气不死，干黄者为津液之槁，多凶目睛黄者，非瘕即衄目黄大颊为病进，平人黑气起于口鼻耳目者危，若赤色见于两颧黑气出于神庭，乃大气入于心肾，暴亡之兆也至于声者，虽出肺胃实发丹田其轻清重浊，虽由基始，要以不异平时为吉，如病剧而声音清朗如常者，形病气不病也，始病即气壅声浊者，邪干清道也病未久而语声不续者，其人中气本虚也，脉之呻者，病也，言迟者，风也，多言者，火之用事也，声如从室中言者，中气之湿也言而微，终日乃复言者，正气之夺也，衣被不敛，言语善恶不避亲疏者，神明之乱也，出言懒怯先重后轻者，内伤元气也，出言壮厉，先轻后重者，外感客邪也，攒眉呻吟者，头痛也，噫气以手抚心者，中脘痛也，呻吟不能转身，坐而下一脚者，腰痛也，摇头以手扞腮者，齿颊痛也，呻吟不能行步者，腰脚痛也诊时吁气者，郁结也，摇头言者，里痛也，形羸声哑者，劳瘵，咽中有肺花疮也，，暴哑者，风痰伏火，或怒喊哀号所致也，语言蹇塞者，风痰也诊时独言独语，不知首尾者，思虑伤神也，伤寒坏病，声哑唇口有疮者，狐惑也平人无寒热，短气不足以息者，痰火也声色之诊最繁无庸琐述以混耳目。

门人问曰：尝闻肥人之脉宜沈，肾肝之脉宜沈，冬月之脉宜沈，于此有人，年盛体丰，冬时腰痛不能转侧，怯然少气，足膝常逆，症脉皆寒与肾气丸不应，转增寒热喘瞞，何也，答曰：不在症治也，夫肥人之脉沈者，湿伤血脉也，腰痛不能转侧者，湿滞经络也，怯然少气者，湿干肺胃也，足膝常逆者，湿遏阳气，不能旁达四支也，法当损气以助流动之势，则痛者止而逆者温反与滋腻养营之药，则痰湿愈壅，

经络不能条畅，而寒热喘满，势所必至也，昔有朔客，初至吴会，相邀诊视时当夏月裸坐盘飧，倍于常人而形伟气壮，热汗淋漓于头顶间诊时不言所以，切其六部沈实，不似有病之脉，惟两寸略显微数之象，但切其左则以右掌抵额，切其右则易左掌抵额，知为肥盛多湿，夏暑久在舟中，时火鼓激其痰于上而为眩晕也，询之果然因与导痰清湿而安，设不察所苦，但以脉沈，求其病之所属，失之远矣，医之手眼可不临机活泼乎。

逆顺

诊切之要，逆顺为宝，若逆顺不明，阴阳虚实死生不别也，故南阳先师，首言伤寒阴病见阳脉者生，阳病见阴脉者死，即此一语，可以推卒病之顺逆，亦可广诸病之死生，一着先机至微至显奈何先辈专守王氏之绳墨，不达至圣之璇玑，以至脉学之言，愈阐愈昧，求脉之道，愈趋愈蹶良由不解活法推源之故，因是汇辑逆顺诸例，庶学者披卷晓然虽以死生并列，而逆症尤不可忽如伤寒未得汗，脉浮大为阳，易已，沈小为阴，难已伤寒已得汗，脉沈小安静为顺，浮大躁疾者，逆然多有发热头痛，而足冷阳缩尺中迟弱，可用建中和之者，亦有得汗不解，脉浮而大，心下反鞭合用承气攻之者，更有阴尽复阳，厥愈足温，而脉续浮者，苟非深入南阳之室，恶能及此，迨夫温病热病，热邪亢盛虽同，绝无浮紧之脉观内经所云，热病已得汗，而脉尚盛躁，此阴脉之极也，死其得汗而脉静者生，热病脉尚盛躁而不得汗者，此阳脉之极也死，脉盛躁，得汗静者生，他如温病穰穰大热，脉数盛者生，细小者死，热病汗下后脉不衰，反躁疾，名阴阳交者死，历参温热诸病，总以数盛有力为顺，细小无力为逆，得汗后脉不衰，反盛躁，尤逆也，至于时行疫疠，天行大头，咸以脉数盛滑利为顺，沈细虚濇为逆，然湿土之邪内伏，每多左手弦小，右手数盛者，总以辛凉内夺为顺，辛热外散为逆，当知温热时疫，皆热邪内蕴而发，若与表散，如炉冶得鼓铸之力耳，然疫疠虽多，人迎不振，设加之以利足冷，又未可轻许以治也，故昔人有阴阳俱紧，头痛身热而下利足冷者死，谓其下虚也，至若温毒发斑，譫语发狂等症，总以脉寔便秘为可治，脉虚便滑者难治，若斑色紫黑如果实靨，虽便秘能食，便通即随之而逝矣，其狂妄躁渴，昏不知人，下后加呃逆者，此阳去入阴，终不可救，卒中风口噤，脉缓弱为顺急实大数者逆，中风不仁，痿躄不遂，脉虚濡缓为顺，坚急疾者逆，中风遗尿盗汗，脉缓弱为顺，数盛者逆，中风便溺阻濇，脉滑实为顺虚濇者逆，中寒卒倒，脉沈伏为顺虚大者逆，中暑自汗喘乏，腹满遗尿，脉虚弱为顺，躁疾者逆，风暑卒倒，脉微弱为顺，散大者逆，大抵卒中天地之气，无论中风中寒中暑中喝，总以细小流连为顺，数寔坚大为逆，散大艰濇，尤非所宜，不独六淫为然，即气厥痰厥，食痰虬厥，不外乎此，盖卒中暴厥，皆真阳素亏，故脉皆宜小弱，不宜数盛，中恶腹满则宜紧细微滑不宜虚大急数，中百药毒，则宜浮大数疾，不宜微细，虚濇，详中风中暑，一切暴中，俱有喘乏遗尿，如中风中寒，则为肾气之绝，中暑中喝，则为热伤气化痰食等厥，又为气道壅遏所致，死生逆顺悬殊，可不辨而混治乎，凡内伤劳倦，气口虚大者为气虚，弦细或濇者为血虚，若躁疾坚搏，大汗出，发热不止者，死以里虚不宜复见表气开泄也，内伤饮

食，脉来滑盛有力者，为宿食停胃，濡伏模糊者，为寒冷伤脾，非温消不能克应，霍乱脉伏为冷食停滞，胃气不行，不可便断为逆，搏大者逆，既吐且利，不宜复见实大也，霍乱止而脉代，为元气暴虚，不能接续，不可便断为逆，厥冷迟微者逆，阳气本虚，加以暴脱，非温补不能救疗，噎膈呕吐，脉浮滑大便润者顺，痰气阻逆，胃气未艾也，弦数紧濡，涎如鸡清，大便燥结者逆，气血枯竭，痰火菀结也，腹胀，关部浮大有力为顺，虚小无神者逆，水肿，脉浮大实弱为顺，濡细虚小者逆，又沈细滑利者，虽危可治，虚小散濡者不治，鼓胀，滑寔流利为顺，虚微短濡者逆，肿胀之脉，虽有浮沈之不同，总以实滑为顺，短濡为逆，欬嗽，浮实和滑者易已，沈细数坚者难已，久嗽缓弱为顺，弦急实大者逆，劳嗽骨蒸，虚小缓弱为顺，坚大濡数者逆，弦细数疾者尤逆，上气喘欬，脉虚宁宁，伏匿为顺，坚强搏指者逆，加泻尤甚，上气喘息低昂，脉浮滑，手足温为顺，脉短濡，四支寒者逆，上气脉数者，死谓其形损故也，历陈上气喘欬诸例，皆以实弱缓滑为顺，濡数坚大者逆，盖缓滑为胃气尚存，坚濡则胃气告匮之脉也，肺痿，脉虚数为顺，短濡者逆，数大寔者，亦不易治，肺痈初起，微数为顺洪大者逆，已溃缓滑为顺，短濡者逆，气病而见短濡之脉，气血交败，安可望其生乎，吐血衄血下血，芤而小弱为顺，弦急寔大者逆，汗出若衄，沈滑细小为顺，寔大坚疾者逆，吐血，沈小为顺，坚强者逆，吐血而欬逆上气，芤实为顺，细数者逆，弦劲者亦为不治，阴血既亡，阳无所附，故脉来芤实，若细数则阴虚火炎，加以身热不得卧，不久必死，弦劲为胃气之竭，亦无生理，畜血脉弦大可攻为顺，沈濡者逆，从高跌仆，内有血积，腹胀满，脉坚强可攻为顺，小弱者逆，金疮出血太多，虚微细小为顺，数盛急实者逆，破伤，发热头痛，浮大滑为顺，沈小濡者逆，肠澼下白沫，脉沈则生，脉浮则死，肠澼下脓血，沈小留利者生，数疾坚大身热者死，久利沈细和滑为顺，浮大弦急者逆，虽沈细小弱，按之无神者不治，肠澼下利，内经虽言脉浮身热者死，然初病而兼表邪，常有发热脉浮，可用建中而愈者，非利久虚阳发露，反见脉浮身热口噤不食之比，泄泻脉微小为顺，急疾大数者逆，肠澼泄泻，为肠胃受病，不当复见疾大数坚之脉也，小便淋瀝脉滑疾者易已，濡小者难已，消瘴脉寔大，病久可治，脉悬小坚病久不可治，消渴脉数大实滑为顺，细小浮短者逆，又沈小滑为顺，实大坚者逆，头痛目痛，卒视无所见者死，清阳失守，邪火僭逆于上也，其脉浮滑，为风痰上盛可治，短濡，为血虚火逆不治心，心腹痛，痛不息，脉沈细迟小为顺，弦长坚寔者逆，疰瘕脉沈寔者可治，虚弱者死，疰瘕脉弦者生，虚疾者死，心腹积聚，脉实强和滑为顺，虚弱沈濡者逆，癰疾脉搏大滑，久自已小坚急死不治，又癰疾脉虚滑为顺，濡小者逆，狂疾脉大实为顺，沈濡者逆，痿痹脉虚濡为顺，紧急者逆，蚀阴肛，虚小为顺，紧急者逆，痈疽初起，脉微数缓滑为顺，沈濡坚劲者逆，未溃洪大为顺，虚濡者逆，溃后虚迟为顺，数实者逆，肠痈实滑微数为顺，沈细虚濡者逆，病疮，脉弦强小急，腰脊强，癰瘕皆不可治，溃后被风，多此疮病，脉浮弦为阳，沈紧为阴，若牢细坚劲搏指者，不治，妊娠脉宜和滑流利，忌虚濡不调，临月脉宜滑数离经，忌虚迟小弱，牢革尤非所宜，新产脉宜缓弱，忌弦紧，带下，脉宜小弱，忌急疾，崩漏，脉宜微弱，忌寔大，乳子而病热，脉悬小，手足温则生，寒则死，凡崩漏胎产久病，脉以迟小缓滑为顺，急疾大数者逆，以上诸例，或采经论，或摭名言，

咸以病脉相符为顺，病脉相反为逆，举此为例，余可类推，颖悟之士，自能闻一知十，无烦余之屑屑也。

异脉

异脉者，乖戾不和，索然无气，不与寻常诸脉相类，内经大奇论，贯列诸脉，摹写最微，苟非逐一稽研，焉能心领神会，如心脉满大，癰癥筋挛，肝脉小急，癰癥筋挛，二条见症皆同，而脉象迥异，受病各别，其同病异治等法，良有见乎此也，若肝脉惊暴，有所惊骇，脉不至，若瘕，皆惊气失常，所以肝脉驰骤，气平自己，毋治也，肾脉小急，肝脉小急，心脉小急，不鼓皆为瘕，言诸经之脉，皆有小急，但以按之不鼓者为瘕，若纵之鼓指，又为火伏之象，非瘕也，肾肝并，沈为石水，并浮为风水，并虚为死，并小弦欲惊，并者，六位皆然，非见一二部也，水脉当沈，以风势鼓激则浮，浮则重按不乏，虚则按之即空，以水气内蓄，不当并见虚脉故死，并小弦欲惊者，以少阳生气，为阴邪所埋，故惕惕如惊，而寔非惊也，肾脉大急沈，肝脉大急沈，皆为疝，心脉搏滑急为心疝，肺脉沈搏为肺疝，疝脉无不弦急者，观下文三阳急为瘕，三阴急为疝，则疝瘕之阴阳辨治，可瞭然矣，二阴急为癰厥，厥属肾而癰属心包也，二阳急为惊，闻水声则惕然而惊也，脾脉外鼓，沈为肠澼，久自己肝脉小缓，为肠澼，易治，肾脉小搏沈，为肠澼，下血，血温身热者死，心肝澼亦下血，二藏同病者可治，其脉小沈，澼为肠澼，其身热者死，热见七日死，肠澼之脉，总以缓小为易治，坚搏为难治，外鼓沈者，言虽浮大而根气不乏也，小搏沈者，阴邪内注而脉显阴象，不当复见虚阳外扰也，心肝二藏，水火同气，故同病者易治，脾肾同病，为土崩水竭，故死不治，胃脉沈鼓澼，胃外鼓大，心脉小坚急，皆鬲，偏枯，男子发左，女子发右，不瘕，舌转可治，三十日起，其从者瘕三岁起，年不满二十者，三岁死言胃脉重按则澼，浮取则大，阴血受伤，而阳气失守也，心脉小坚急，阴邪胜而上侮君主也，胃气既伤，血脉又病，故心下痞鬲，而半体偏枯也，偏枯以男子发左，女子发右为逆，然虽逆而非不治也，如不瘕舌转，非藏受病见症虽逆，治亦易起，若瘕不能言，肾气内亏，症虽不逆，治亦难痊，若年不满二十，气血方盛之时，而见偏枯之疾，此根气乏夭，不出三年必死也，脉至而搏，血衄身热者死，脉来悬钩浮为常脉，血衄身热，而脉来搏指，虚阳外脱，阴血内亡，安得不死，脉来悬钩浮，言浮而中空之状，隐然言外，脉至如喘，名暴厥，暴厥者，不知与人言，言暴逆气浮，故脉喘喘乏力，肾气不能下守可知，脉至如数，使人暴惊，三四日自己，言暴惊气乱，故脉至如数，而寔未常数，故不须治，脉至浮合，浮合如数，言一息十至以上，如浮波之合，后至凌前，虚疾而动无常候，是经气予不足也，脉至如丸泥，言指下动滑如循薏苡子，是胃精予不足也，脉至如横格言坚强如横木之拒于指下，是胆气予不足也，脉至如火薪然，言浮数而散，瞥瞥如羹上肥，是心精之予夺也，脉至如散叶，言飘忽无根，是肝气予虚也，脉至如省客，省客者，言如省问之客，乍见欲言而迟疑不吐，故以脉塞而鼓四字体贴之，是肾气予不足也，脉至如弦缕，言弦急而强，如转索之状，是胞精予不足也，脉至如交漆，交漆者，左右傍至也，言指下艰澼不前，重按则不由正道而出，或前大

后细，与绵绵如泻漆之绝互发，脉至如涌泉，言寸口洪盛，如泉出穴之涌，而按之散漫，浮鼓肌中，太阳气予不足也，脉至如颓土之状，言濡大模糊，如雨中颓土，按之不得，是肌气予不足也，脉至如悬雍，悬雍者，浮揣切之益大，重按即无，故以腭间下垂之肉喻之，是十二俞之予不足也，脉至如偃刀，偃刀者，浮之小急，按之坚大急，五藏菹热，寒热独并于肾也，脉至如丸，滑不直手，按之不可得，是大肠气予不足也，脉至如华者，言如花之虚浮，令人善恐，不欲坐卧，行立常听，是小肠气予不足也，如上诸脉，古圣目之大奇，洵非寻常可拟，余尝反复互参，始得其旨，前九条，咸以脉症异同，究其病之所属，如脾脉外鼓沈，及胃脉沈鼓濡，胃外鼓大之脉皆彷彿，而为病迥殊，后十四条，又以指下乖异，辨诸经之气予不足，而悉予之短期，近世但知弹石解索，雀啄屋漏，鱼翔虾游，谓之六绝，若浮合等脉，真藏七诊，茫然不知何义，而漫治取谤者有之，多有病本濒危，药之不应，而显绝脉绝症，如病人身热脉大，服药后，忽然微细欲绝，厥冷下利，呃逆不止者死，脉转躁疾亦死，病人厥逆下利，脉微欲绝，服药后，脉暴出者死，与厥逆下利，本不能食，今骤能食，为除中者死同义，又脉来忽沈忽浮，乍疎乍数，来去无次，皆不可治，经谓不大不小，病犹可治，其有大小者，为难治也，真藏者，独弦独钩，独毛独石独代，而指下坚强，绝无和缓之象，藏气病气，打成一片，故曰真藏，见之必死，七诊者，独小独大，独疾独迟，诸部皆然，非一部两部见病脉也，独热者，尺炬然热，独寒者，尺肤寒是也，独陷下者，诸部皆陷伏不应也，真藏悉为死候，七诊犹为病脉，其所重全在胃气，胃主肌肉，故言形肉已脱，九候虽调犹死，七诊虽见，九候皆从者不死，胃为五藏之本也，若有七诊之病，其脉候亦败者死矣，前篇汇次逆顺，此篇专辑异脉，欲人贯彻其旨，庶无轻诺许治之失。

妇人

问妇人脉法，与男子何异，答曰：女子二七天癸通，月事以时下，故其所重全在冲任，冲任为精血之海，其脉常随肝肾而行，故以左尺为命门，阴阳应象论云：阴阳者，血气之男女也，左右者，阴阳之道路也，盖天道左旋而主阳气，地道右转而主阴血，阴常从阳，为阳之守，故左尺反有命门之号，然阴稟多暴，脉多随气上章，阴性多郁，脉亦随气内慄，古人虽有女子右脉常盛，及女脉在关下之说，要非定论，其病惟经候胎产，异于男子，他无所殊也，若肾脉微濡，或左手关后尺内脉浮，或肝脉沈而急，或尺脉滑而断绝不匀，皆经秘不调之候，如体弱之妇脉常微弱，但尺内按之不绝，便是有子，月断呕逆不食，六脉不病，亦为有子，所以然者，体弱而脉难显也，脉经曰：妇人脉三部浮沈正等，按之不绝，无他病而不月者，妊子也，尺数而旺者亦然，经曰：何以知怀子之且生，身有病而无邪脉也，又云：阴搏阳别，谓之有子，言尺内阴脉搏指，与寸口阳脉迥别，其中有阳象也，阴阳相𦵏𦵏，故能有子，阴虚阳搏谓之崩，言尺内虚大弦数，皆内崩而血下，若消瘦喘息，月事不来者，二阳之病发心脾也，妇人不月，脉来滑疾，重手按之散者，胎已三月也，和滑而代者，此二月余之胎息也，重手按之，滑疾而不散者，五月也，妊娠四月，欲知男女法古人悉以左尺滑大为男，右尺滑大为女，两尺俱滑大为双胎，然往往有

左寸动滑为男者，以经行血泻，阴常不满，故尺常不足，不可执于尺内滑大，方为胎脉之例，经云：妇人手少阴脉动甚者，妊子也，寸为阳位，故见动滑，则为血充而显阳象，左叶熊黑，右应鸾凤之兆，可预卜而无疑也，凡妇人经水三月不来，诊其脉两寸浮大，两关滑利，两尺滑实而带数，此胎脉也，若有形而不动，或当脐下翕翕微动如抱瓮之状，按之冰冷，又两尺乍大乍小，乍有乍无，或浮或沈，或动或止，早暮不同者，乃鬼胎也，须连视二三日乃见，宜补气活血，温养脾胃，则水行经自通矣，若脉来疾如风雨乱点，忽然而去，久之复来如初者，是夜叉胎也，亦有左关之脉，指下见两歧，而产夜叉者，总与平常之脉不类也，妊娠脉弱，防其胎堕，以气血无养也，急宜补养，若弦急亦堕，是火盛也，妇有孕脉沈细弦急，憎寒壮热，唇口俱青黑，是胎气损也，当问胎动否，若不动，反觉上抢心闷绝，按之冰冷者，当作死胎治之，妇人经断有躯，其脉弦者，后必大下，不成胎也，然有因病脉弦，又当保胎为务，气旺则弦自退矣，妇人尺脉微迟为居经，月事三月一下血气不足故也，妇人尺脉微弱而濇，少腹恶寒，年少得之为无子，年大得之为绝孕，若因病而脉濇者，孕多难保，凡妊娠外感风邪，脉宜缓滑流利，最忌虚濇躁急，虚濇则不固，躁急则热盛伤胎，多难治也，胎前下利，脉宜滑小，不宜洪数，洪数则防其胎堕，堕后七日多凶，治疗之法，攻积必死，兜濇亦死，急宜伏龙肝汤，煎温养脾胃药，多有生者，凡妊娠之脉，宜寔大有力，忌沈细弦急虚濇，半产漏下，宜细小流连，忌急寔断绝不匀，临产宜滑数离经，忌虚迟弦细短濇，产后宜沈小微弱，忌急寔洪数不调，新产伤阴，出血不止，尺脉不能上关者死，新产中风热病，脉宜浮弱和缓，忌小急悬绝，崩漏不止，脉宜细细小芤迟，忌虚濇数寔，凡诊妇人室女伤寒热病，须问经事若何，产后须问恶露多少，及少腹中有无结块，此大法也。

婴儿

问婴儿三岁以下，看虎口三关纹色，其义云何，答曰：婴儿气血未盛，经脉未充无以辨其脉象，故以食指络脉形色之彰于外者察之，其络即三部之所发，其色以紫为风热，红为伤寒，青为惊恐，白为疳积，惟黄色隐隐，或淡红隐隐为常候，至见黑色危矣，若虎口三关多乱纹为内钓，腹痛气不和，脉乱身热不食，食即吐而上唇有珠状者，为变蒸也，其间纹色，在风关为轻，气关为重，命关尤重也，此言次指上三关近虎口一节为风关，中节为气关，爪甲上节为命关，然纹直而细者，为虚寒，少气，多难愈，粗而色显者，为邪干正气，多易治，纹中有断续如流珠形者为有宿食，其纹自外向里者为风寒，自内向外者为食积也，岐伯曰：阴络之色应其经，阳络之色变无常，随四时而行也，寒多则凝泣，凝泣则青黑，热多则淖泽，淖泽则黄赤，此皆常也，至三岁以上，乃以一指按三关，此言寸关尺三部也，其脉常以六至为则，添则为热，减则为寒，浮弦为乳瘤，弦紧为风瘤，虚濇为慢惊，沈弦为腹痛，弦寔为气不和，牢实为便秘，沈细为冷乳不消，沈滑为宿食不化，或小或濇，或沈或细，皆为宿食停滞，浮大为伤风，伏结为物聚，弦细为疳劳，沈数为骨蒸有热也，婴儿病赤瓣飧泄，脉小手足寒难已，脉小手足温，泄易已，小儿见其腮赤目赤，呵欠烦闷，乍凉乍热，或四末独冷，鼓栗恶寒，面赤气涌，涕泪交至，及耳后有

红丝纹缕，脉来数盛者，皆是痘疹之候，汤药之所当忌者最多，慎勿漫投以貽其咎也。